

Les inégalités de santé : les apports de l'économie de la santé

Florence Jusot

Université Paris-Dauphine (Leda-Legos) & Irdes

Introduction

- La promotion de la santé et de l'équité en santé est l'un des objectifs principaux de l'organisation mondiale de la santé (WHO).
 - Le « droit à la santé » a été énoncé par l'OMS dès sa création
 - L'objectif d'une réduction des inégalités de santé entre groupes sociaux a été énoncé dans la politique-cadre de la « Santé pour tous » de la Région européenne de l'OMS dès 1985
- A la suite de nombreux rapports (Rapport de la Commission des déterminants sociaux de l'OMS en 2008 « Réduire le fossé en une génération - Instaurer l'équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé » ; Rapport du Haut conseil de santé publique en 2009 : « Les inégalités sociales de santé : sortir de la fatalité » ; Rapport de l'IGAS EN 2011 : « Les inégalités sociales de santé : Déterminants sociaux et modèles d'action »)
- ...la réduction des inégalités face à la santé se trouvent au cœur de la Stratégie Nationale de santé de 2014-2018 et 2018-2022
 - Axe 1 : Mettre en place une politique de promotion de santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie
 - Axe 2 : Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins
- On constate pourtant de fortes différences :
 - d'état de santé entre pays mais aussi entre groupes sociaux entre les pays
 - de recours aux soins entre groupes sociaux à état de santé comparable

Introduction

- Quelle est l'ampleur des inégalités sociales de santé en France et en Europe, c'est-à-dire des différences d'état de santé et de mortalité entre les individus ayant des situations sociales différentes (revenu, éducation, catégorie sociale,) ? Comment évoluent elles ?
- Quel jugement peut on porter sur ces inégalités ? Leur caractère injuste justifie t-il de mettre en place des politiques publiques pour les réduire ?
- Quelles sont les causes de ces inégalités ? Quels sont en particulier les rôles joués par les ressources financières, l'organisation du système de santé et son financement
- Quelles sont les politiques et interventions que l'on peut mettre en place pour les réduire ? Quelle est l'efficacité à attendre des politiques et interventions mises en place jusqu'à présent ?

Les inégalités sociales de santé :

De quoi parle-t-on ?

Inégalités de santé / inégalités sociales de santé :

De quoi parle-t-on ?

- **Inégalités de santé : différences d'état de santé au sein d'une population**

Variance de l'espérance de vie ; écart entre la durée de vie la plus faible (0) et la plus longue (121 ans)

Toute différence est pertinente indépendamment de son lien avec les caractéristiques des individus

- **Inégalités sociales de santé : Différences d'état de santé entre groupes sociaux**

Ecart d'espérance de vie à 35 ans entre les hommes cadres (47,2 ans) et les hommes ouvriers (40,9 ans)

On s'intéresse aux différences d'état de santé entre groupes d'individus regroupés selon une caractéristique sociale considérée a priori et donc jugée pertinente. Par contre, on ne s'intéresse plus aux différences intragroupes

Inégalités sociales de santé :

De quoi parle-t-on ?

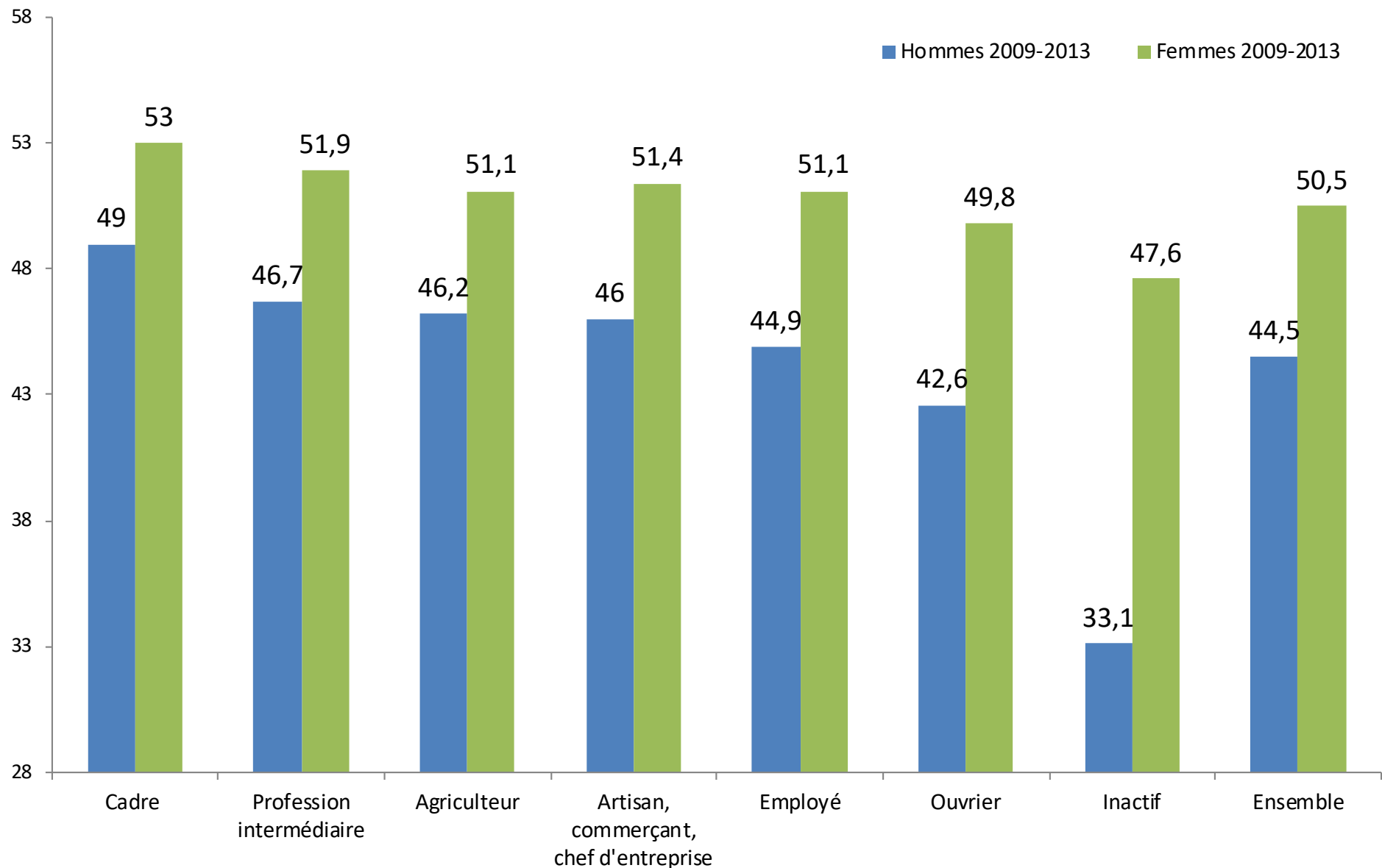
- **Un gradient social de mortalité et de santé**

c'est-à-dire des différences de santé entre groupes sociaux, tout au long de la hiérarchie sociale

On observe ces inégalités quels que soient les indicateurs de santé utilisés (mortalité, maladies chroniques, état de santé perçu, limitations dans les activités)

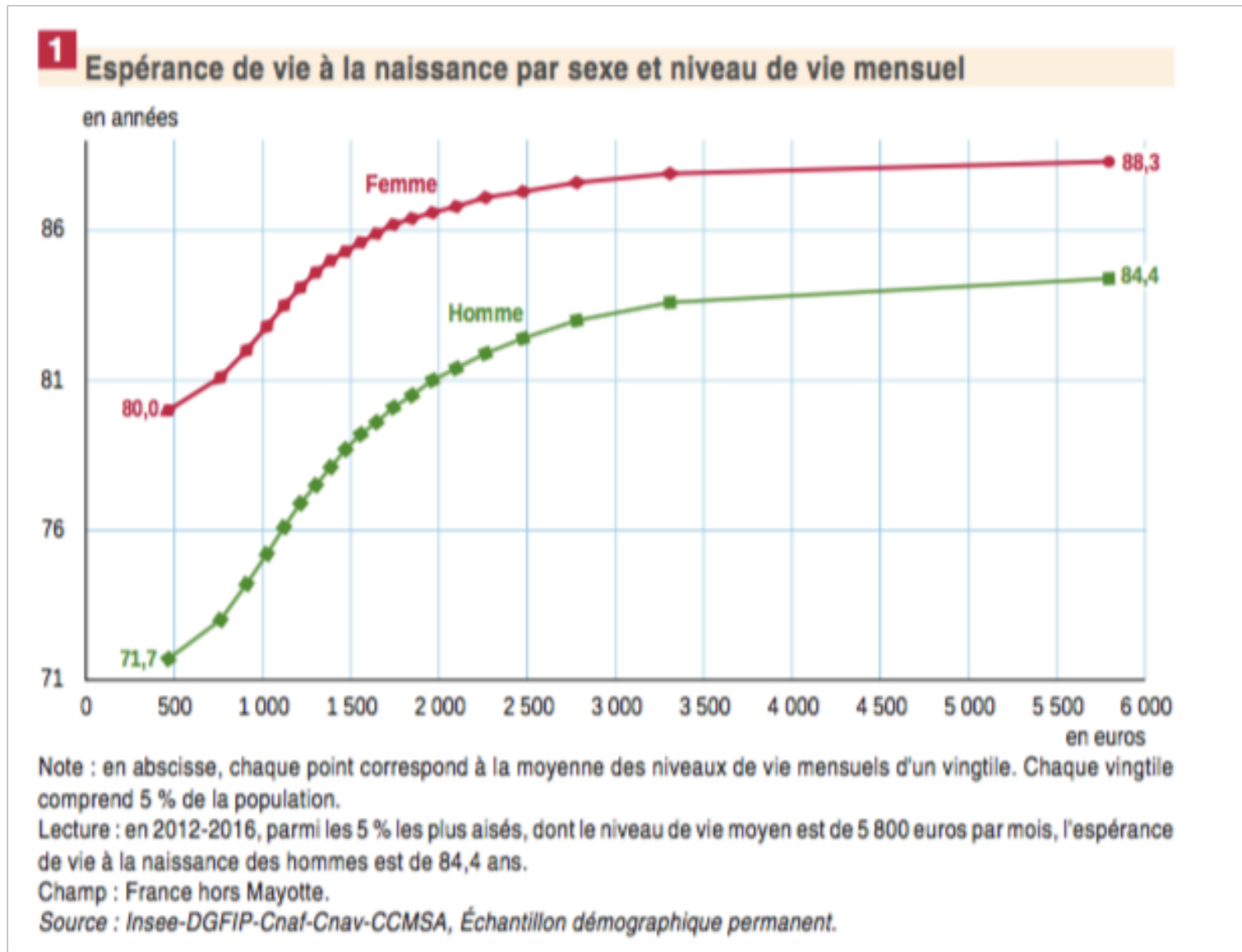
On observe ces inégalités quels que soient les indicateurs sociaux utilisés pour définir les groupes sociaux (revenu, éducation, profession (PCS : profession et catégorie sociale))

Espérances de vie à 35 ans en France 2009-2013



Blanpain N. (2016), « Les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus que les hommes ouvriers », Insee Première, 1584.

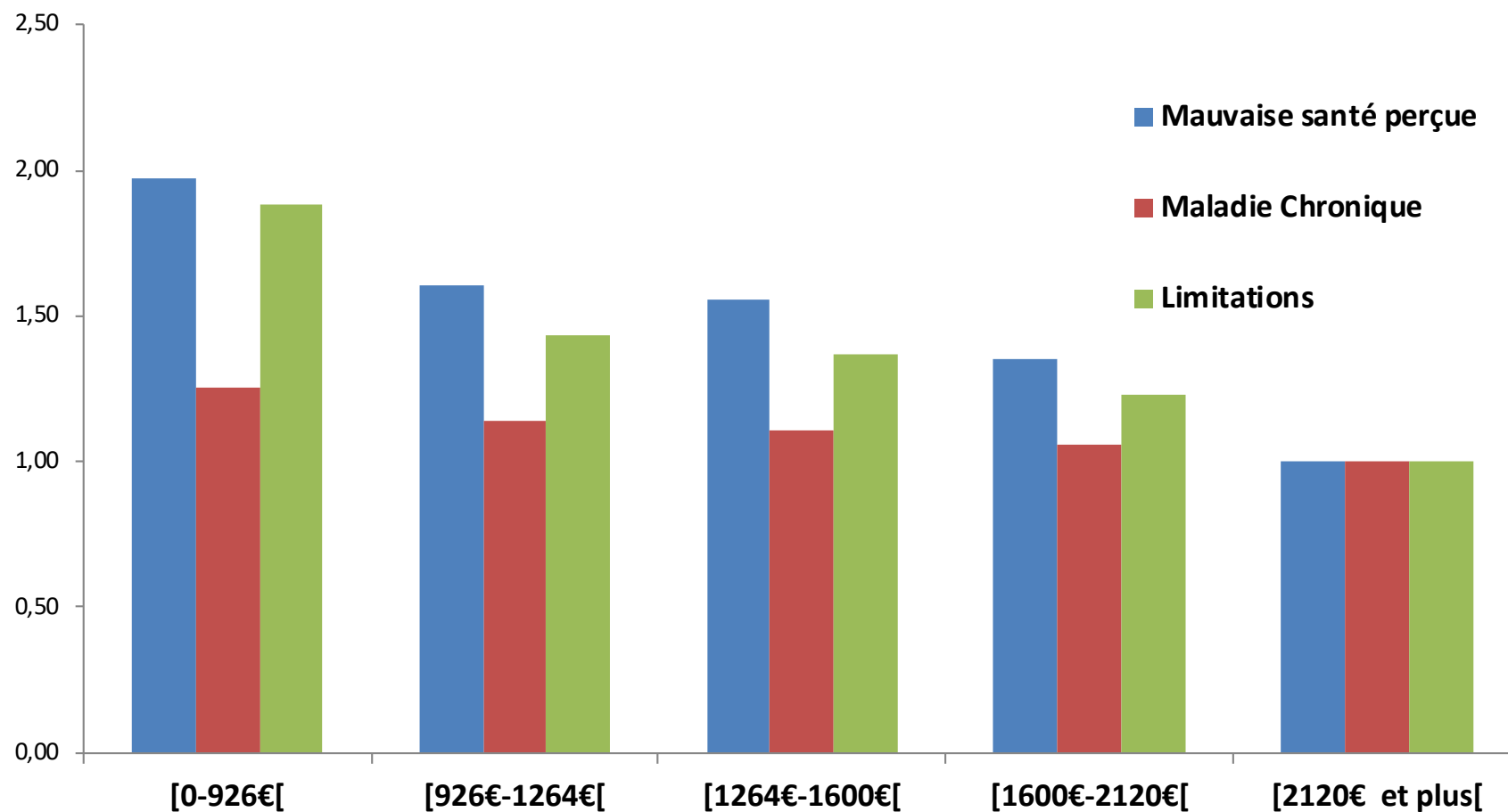
Espérance de vie selon le niveau de revenu



Blanpain N. (2018), « L'espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d'écart entre les plus aisés et les plus modestes », Insee Première, 1687.

Inégalités de santé selon le revenu en France en 2012

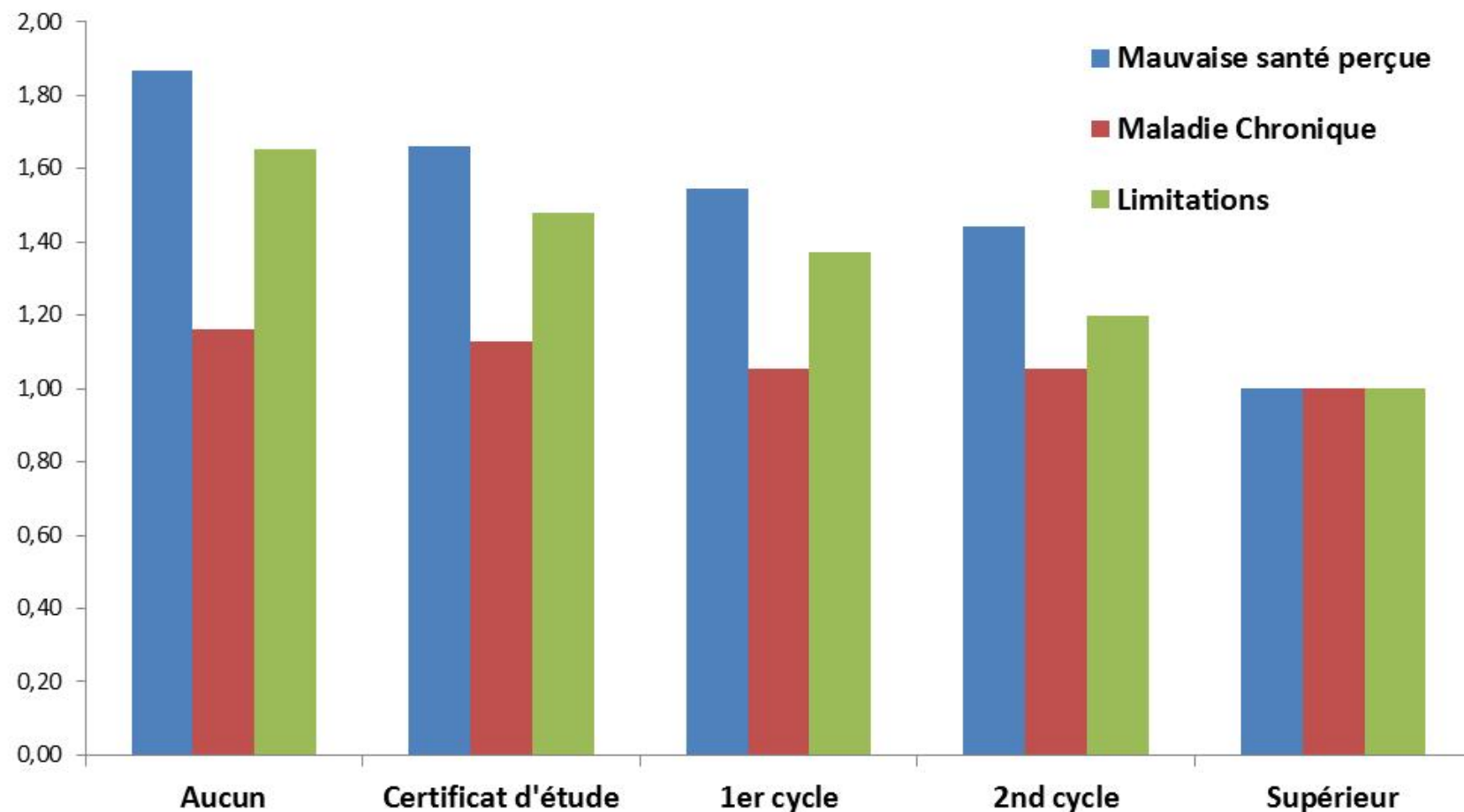
Risque relatif à âge et
sexe comparables



Source : Calculs de l'auteur d'après Célant N., Guillaume S., Rochereau T. (2014), « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », Les rapports de l'Irdes,, n°556.

Inégalités de santé selon le diplôme en France en 2012

Risque relatif à âge et
sexe comparables



Source : Calculs de l'auteur d'après Célant N., Guillaume S., Rochereau T. (2014), « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », Les rapports de l'Irdes, n°556.

Inégalités sociales de santé : De quoi parle-t-on ?

- **Un gradient social de mortalité et de santé**

c'est-à-dire des différences de santé entre groupes sociaux, tout au long de la hiérarchie sociale

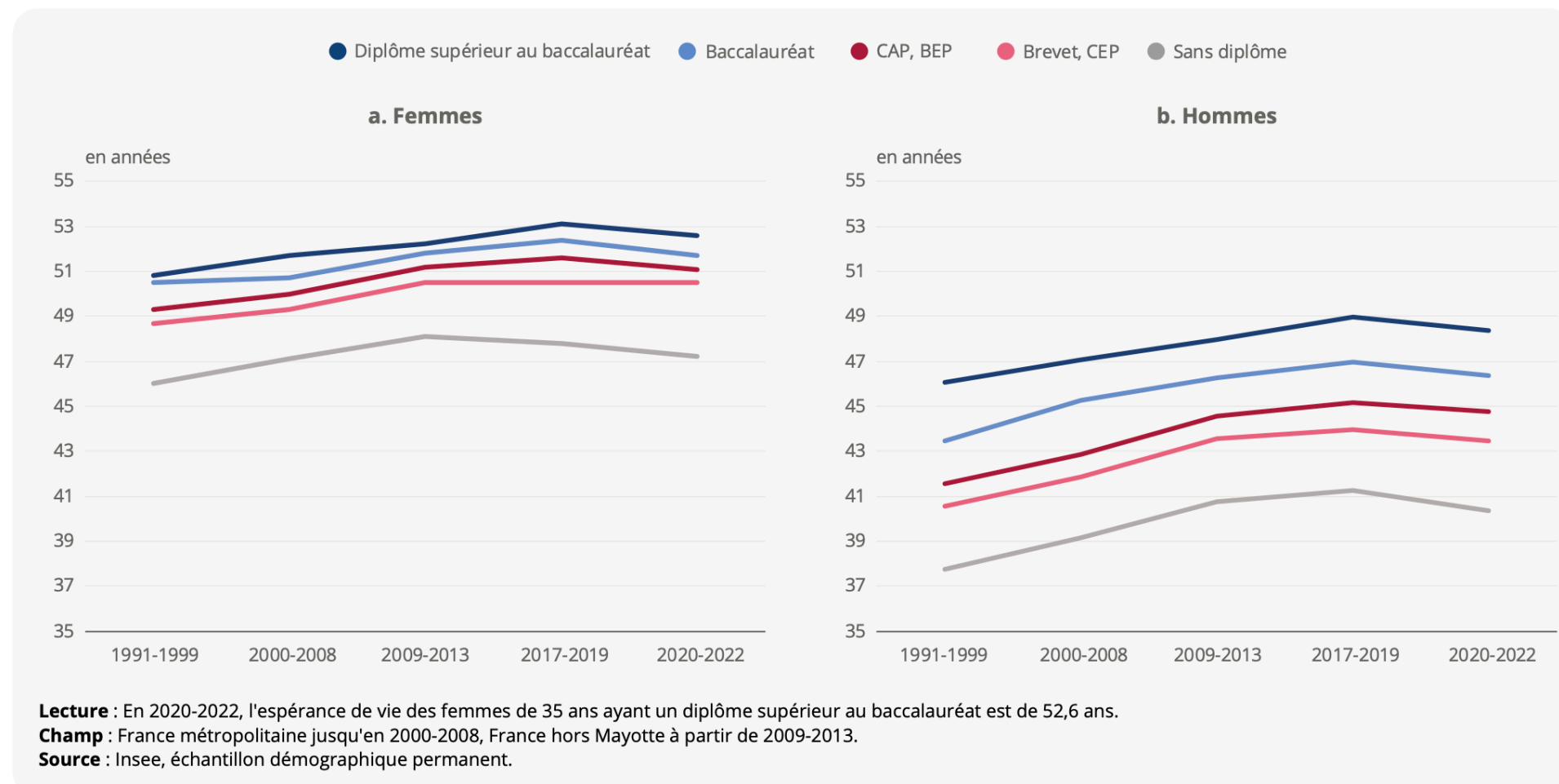
- **Qui ne se réduit pas dans le temps**

Depuis les années 1970, l'espérance de vie a largement progressée, en raison notamment des progrès médicaux. Cette augmentation de l'espérance de vie a profité à tous les groupes sociaux : les ouvriers, comme les cadres, ont vu leur espérance de vie augmenter.

Mais les écarts d'espérance de vie entre groupes sociaux ne se sont pas réduits, malgré les progrès médicaux et les politiques sociales (salaire minimum (SMIC), Revenu Minimum d'Insertion devant Revenu de Solidarité Active, Minimum Vieillesse, Couverture Maladie Universelle Complémentaire, puis Aide Complémentaire Santé, devenue Complémentaire Santé Solidaire.

Evolution de l'espérance de vie à 35 ans

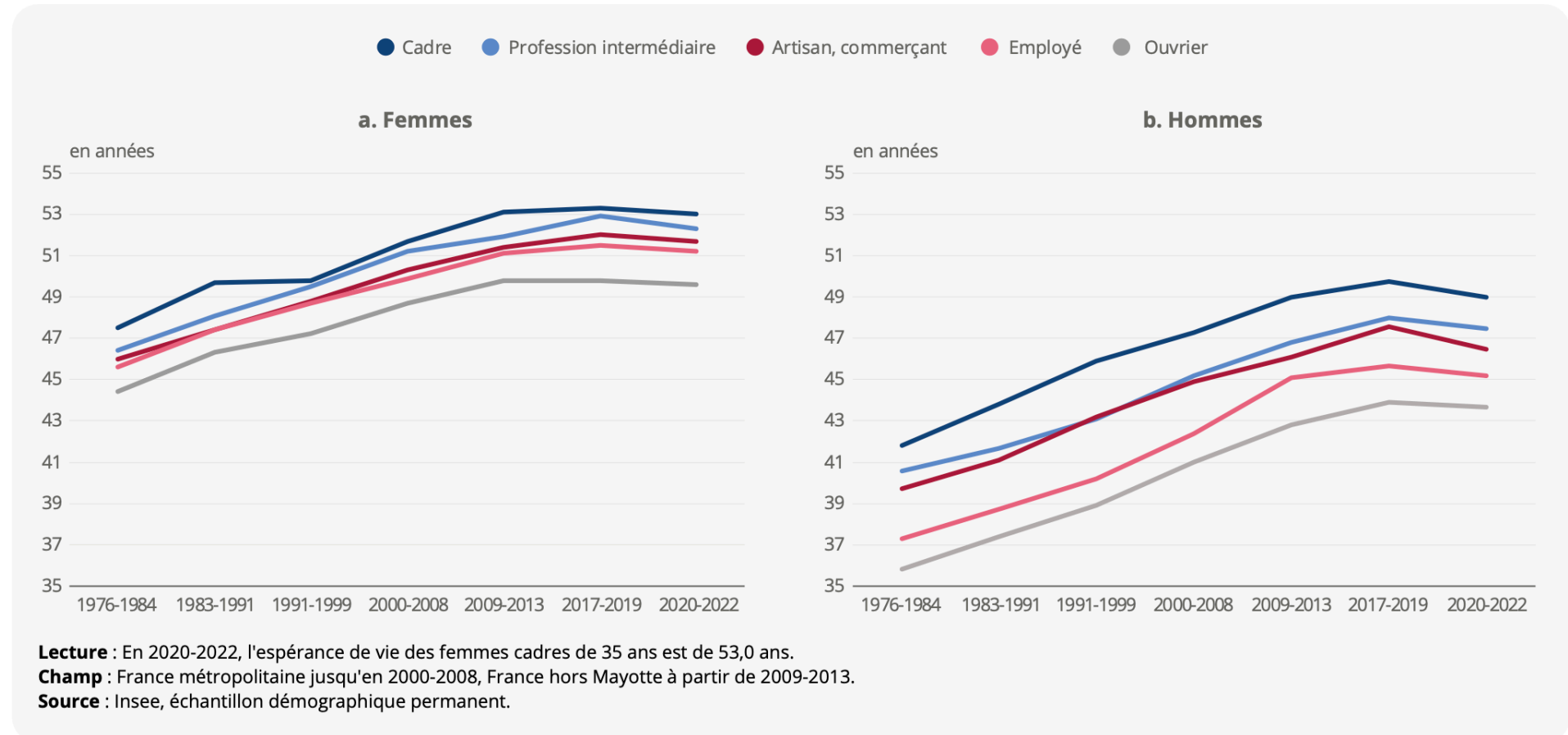
► 2. Espérance de vie à 35 ans selon le diplôme, de 1991-1999 à 2020-2022



Blanpain N. (2024), « Les écarts d'espérance de vie entre cadres et ouvriers : 5 ans chez les hommes, 3 ans chez les femmes », Insee Première, 2005.

Evolution de l'espérance de vie à 35 ans

► 3. Espérance de vie à 35 ans selon la catégorie sociale, de 1976-1984 à 2020-2022



Blanpain N. (2024), « Les écarts d'espérance de vie entre cadres et ouvriers : 5 ans chez les hommes, 3 ans chez les femmes », Insee Première, 2005.

Inégalités sociales de santé : De quoi parle-t-on ?

- **Un gradient social de mortalité et de santé**

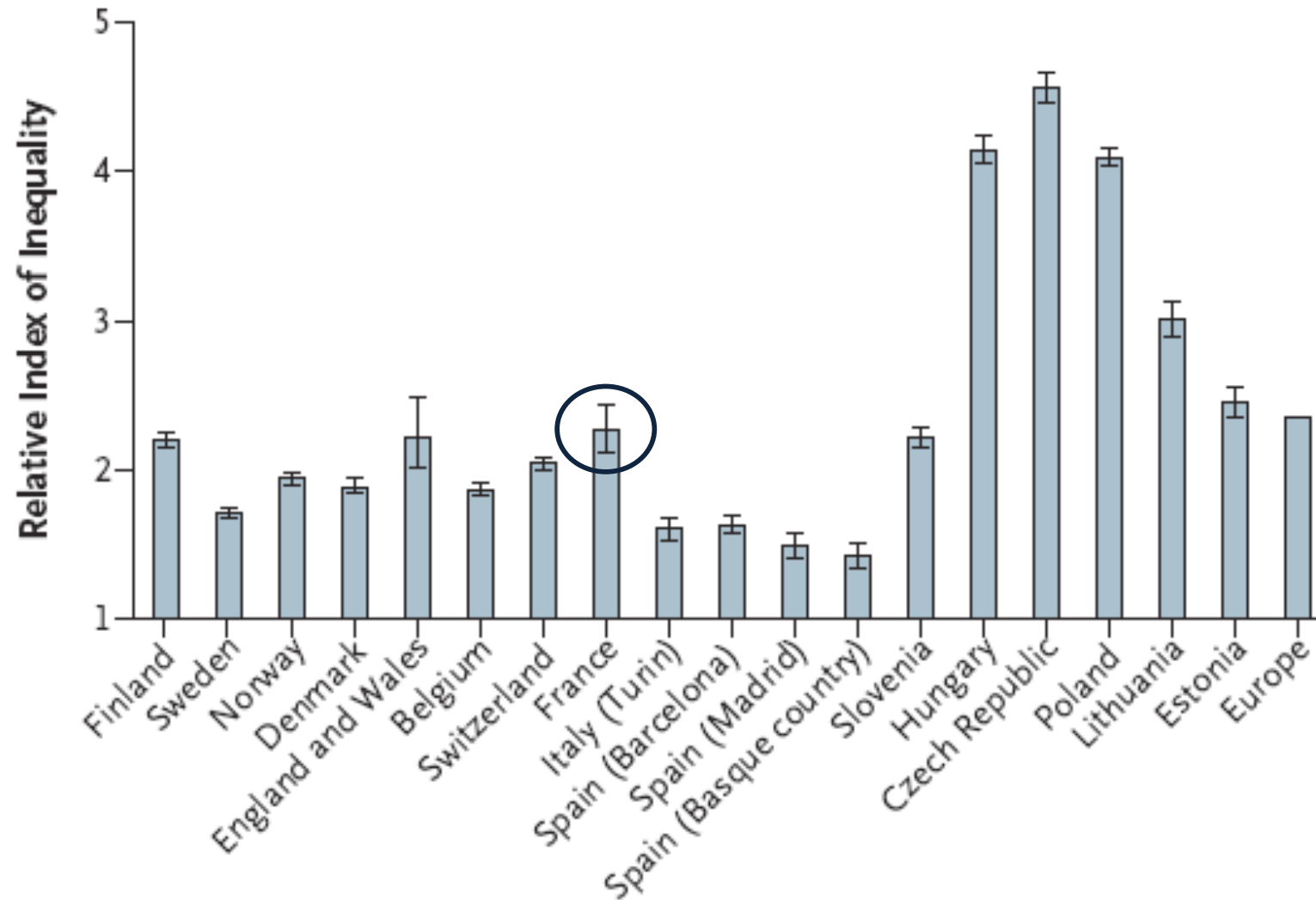
c'est-à-dire des différences de santé entre groupes sociaux, tout au long de la hiérarchie sociale

- **Qui ne se réduit pas dans le temps**

- **Qui est assez fort en France par rapport à celui qui est observé dans les autres pays européens de l'Ouest**

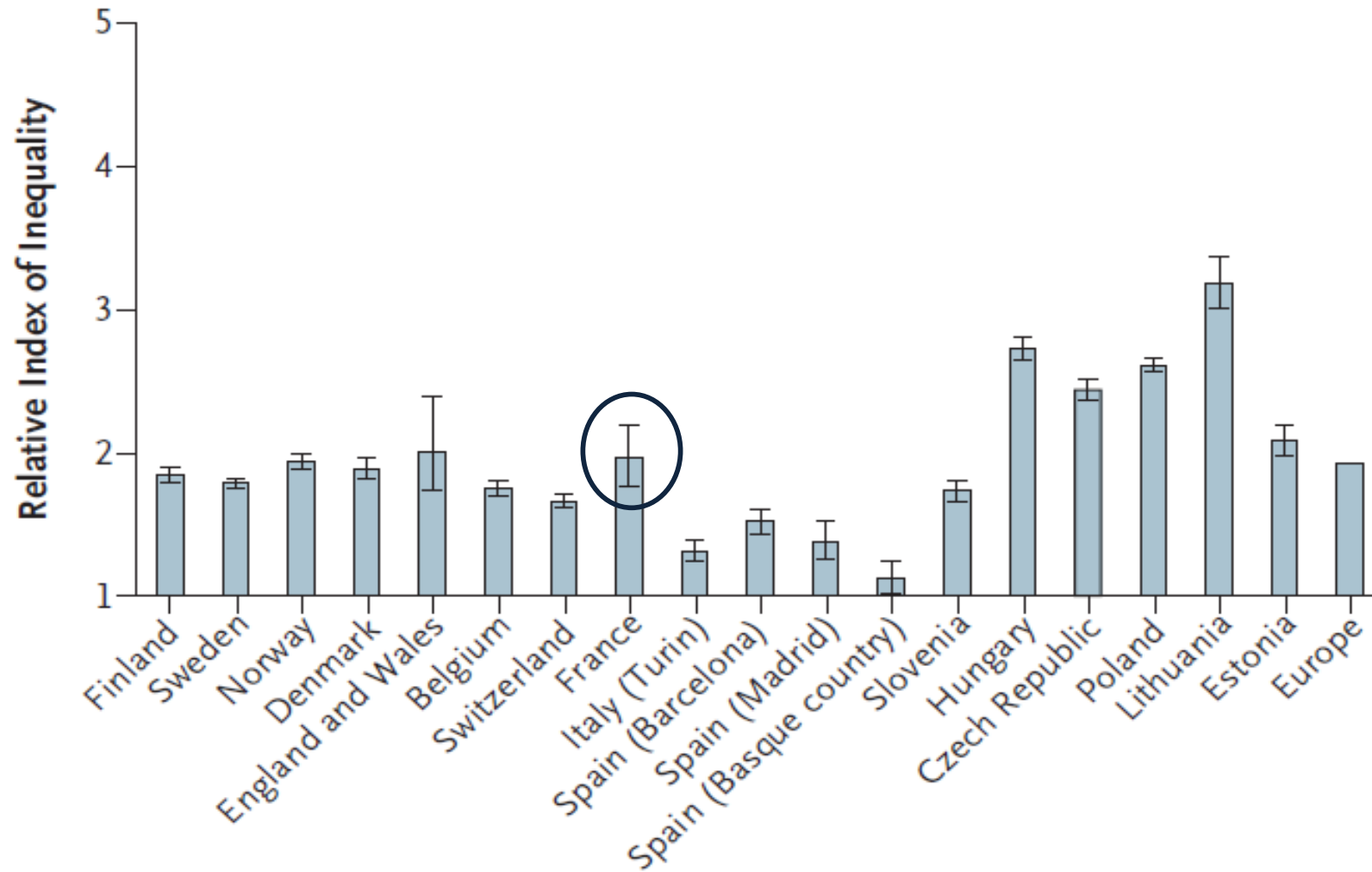
La France fait partie des pays d'Europe de l'Ouest où les inégalités sociales de santé sont les plus importantes. Notamment, elles sont plus importantes qu'en Espagne, en Italie ou, en Suède. Par contre les inégalités sociales de santé sont encore plus fortes dans les pays d'Europe de l'Est et d'Europe Centrale. Les inégalités sociales de santé sont plus faibles en France qu'aux Etats-Unis mais restent comparables.

Risque relatif décès des personnes ayant un niveau d'éducation primaire par rapport à celles ayant un niveau supérieur (hommes)



Source : Mackenbach J.P., Stirbu I., Roskam A.J.R., Schaap M.M., Menvielle G., Leinsalu M., Kunst A.E., The European Union Working Group on Socioeconomic Inequalities in Health (2008), "Socioeconomic inequalities in health in 22 european countries", The New England Journal of Medicine, 358, 23 : 2468-2481.

Risque relatif décès des personnes ayant un niveau d'éducation primaire par rapport à celles ayant un niveau supérieur (femmes)

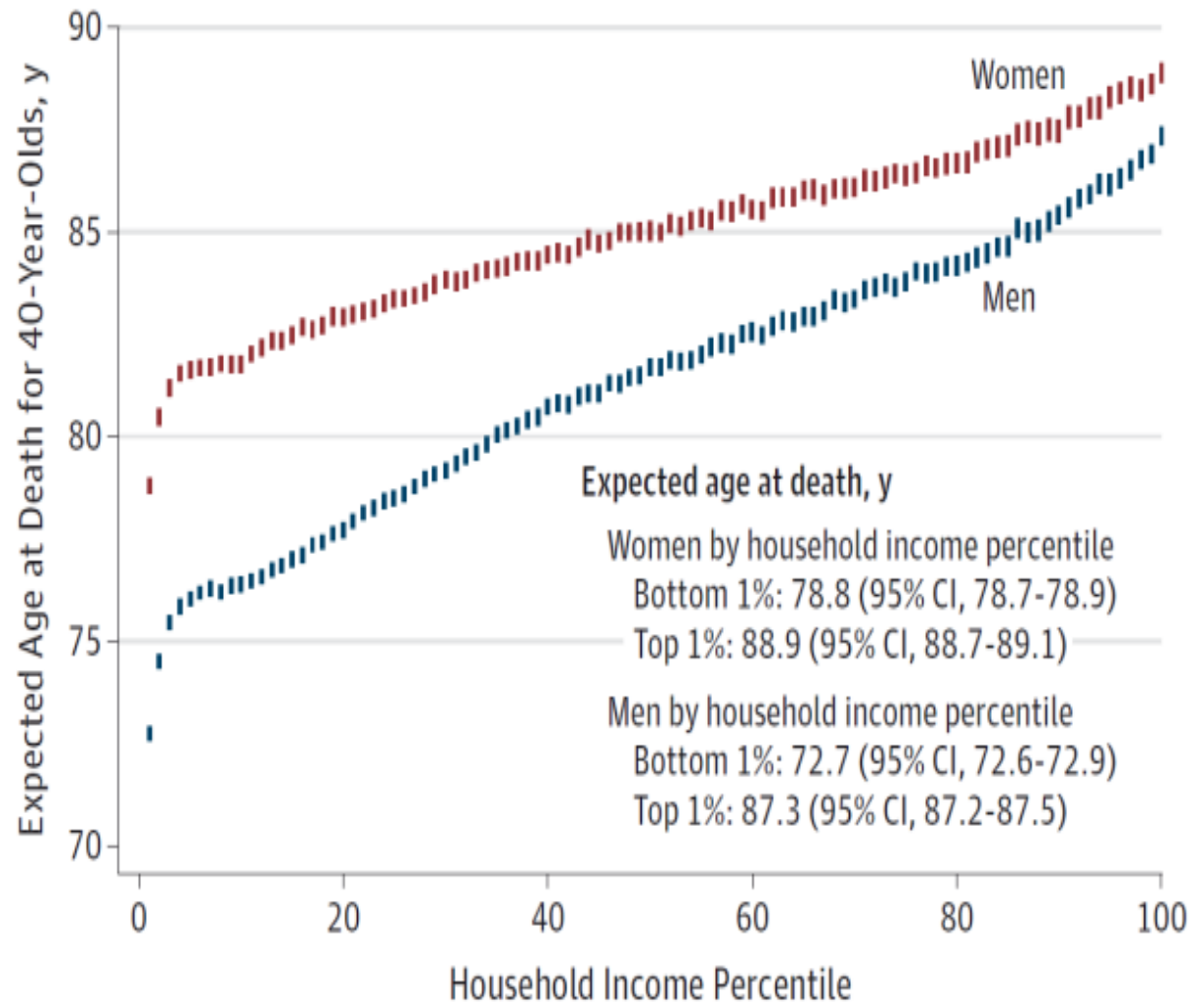


Source : Mackenbach J.P., Stirbu I., Roskam A.J.R., Schaap M.M., Menvielle G., Leinsalu M., Kunst A.E., The European Union Working Group on Socioeconomic Inequalities in Health (2008), "Socioeconomic inequalities in health in 22 european countries", The New England Journal of Medicine, 358, 23 : 2468-2481.

Life expectancy increases with income across the whole distribution in US (Chetty et al *JAMA* 2016)

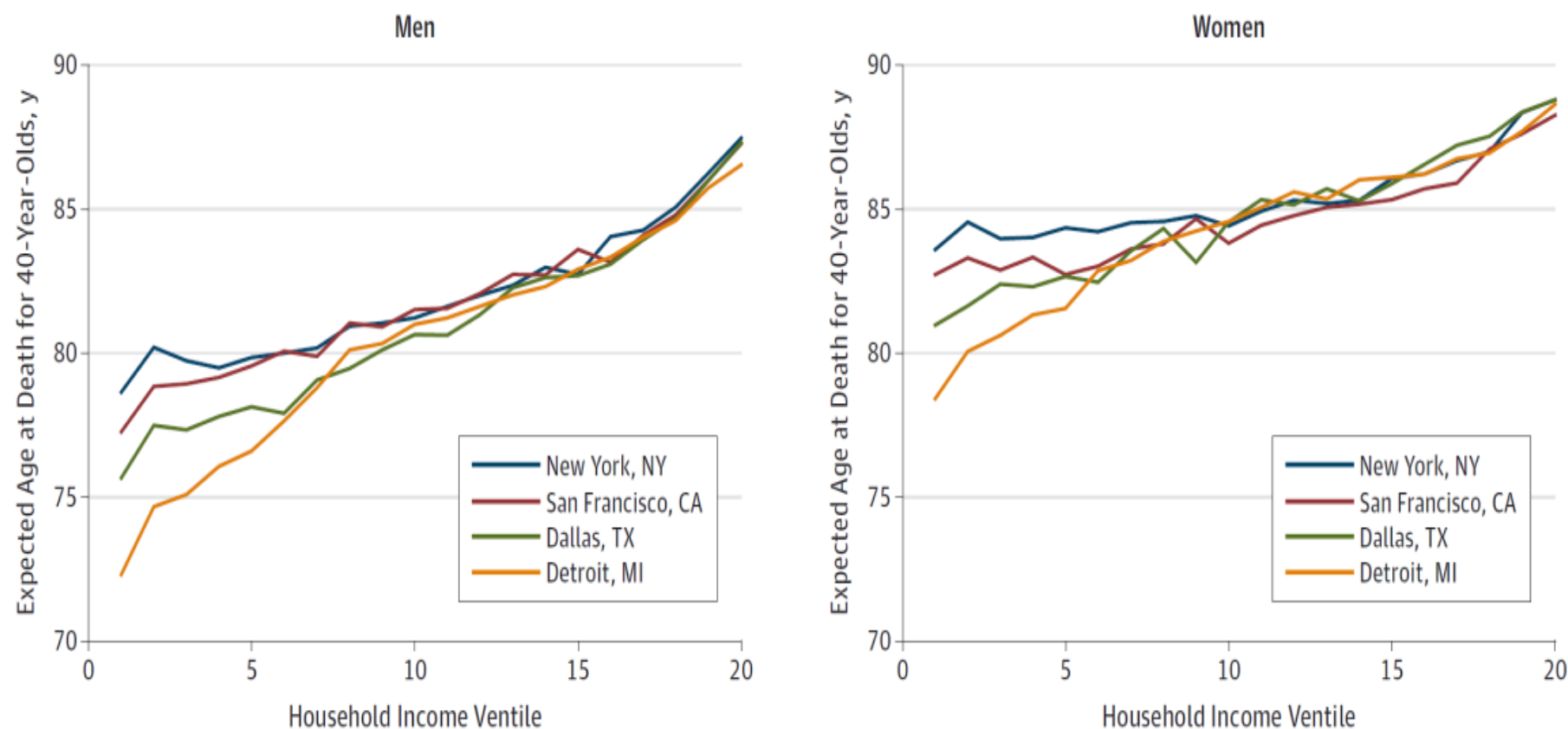
Figure 2. Race- and Ethnicity-Adjusted Life Expectancy for 40-Year-Olds by Household Income Percentile, 2001-2014

US male in poorest 1% has same life expectancy as average male in Sudan



Income gradient in US life expectancy varies geographically (Chetty et al 2016)

Figure 4. Race- and Ethnicity-Adjusted Life Expectancy by Income Ventile in Selected Commuting Zones, 2001-2014



Life expectancy varies more at bottom than at top of income distribution

Les inégalités sociales de santé : Qu'en pense-t-on?

Un exemple introductif

L'exemple du naufrage du Titanic

Types de passager	1ère Classe	2ième Classe	3ième Classe	Membres de l'équipage	Musiciens et postiers	Equipage total	Ensemble
Nombres de passagers	324	277	708	885	13	898	2207
Nombre de survivants	201	118	181	212	0	212	712
Probabilité de décès	0,38	0,57	0,74	0,76	1	0,76	0,68
Risque relatif de décès par rapport aux passagers de 1ère classe	1	1.51	1.96	2.00	2.63	2,01	1,78

Quelques principes justifiant l'allocation des canaux de sauvetage

- Les femmes et les enfants d'abord :
 - Principe utilitariste (J. Bentham) : le plus grand « bonheur » pour le plus grand nombre, on privilégie les individus qui ont le plus d'années à vivre et le plus d'années pour contribuer à la société
 - Fair innings (A. Williams): offrir plus de ressources à ceux qui n'ont pas eu une durée de vie normale
- En fonction de la classe de leur billet :
 - Principe libéral (J. Lock, F. Hayek) : en fonction des droits de propriété qu'ils ont sur les canaux de sauvetage, c'est-à-dire du prix du billet payé
 - Principe utilitariste: si l'on pense que le vie de certains a une plus grande valeur pour la société (les hommes politiques, les industriels)
 - Principe égalitariste-libéral (J. Roemer): on pourrait trouver plus juste que les personnes qui ont gagné des ressources grâce à leurs efforts leur permettant de payer le billet plus cher aient une meilleur accès que s'ils en ont hérité
- En si la santé avait été considérée comme un bien premier (qui soit être garanti pour tous) à la J.Rawls ou à la A. Sen, on aurait pu procéder à un tirage aléatoire

Un second exemple introductif

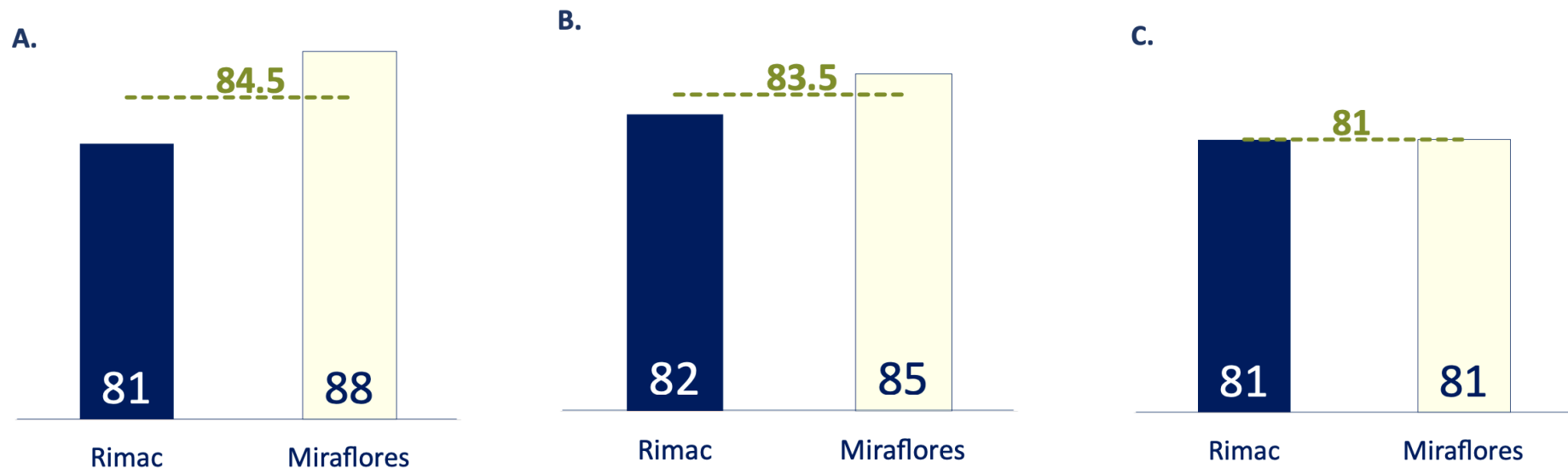
Considérons 2 territoires : Rimac et Miraflores.

Rimac est un territoire **moins favorisé** que Miraflores.

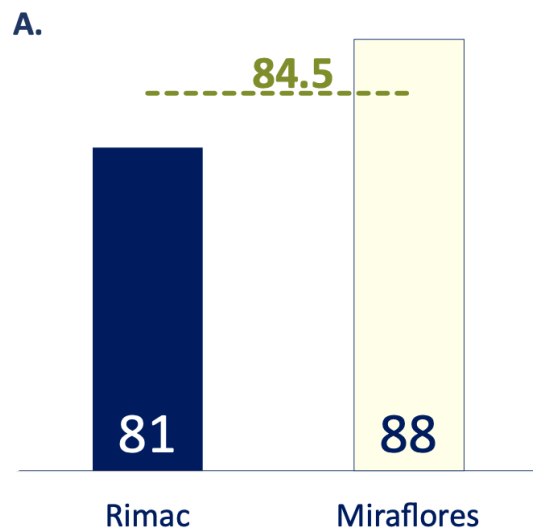
Trois programmes de prévention sont possibles.

Ces trois programmes ont le **même coût** mais conduisent à des **espérances de vie différentes** à Rimac et Miraflores.

Classez ces 3 programmes du programme que vous préférez le plus à celui que vous préférez le moins

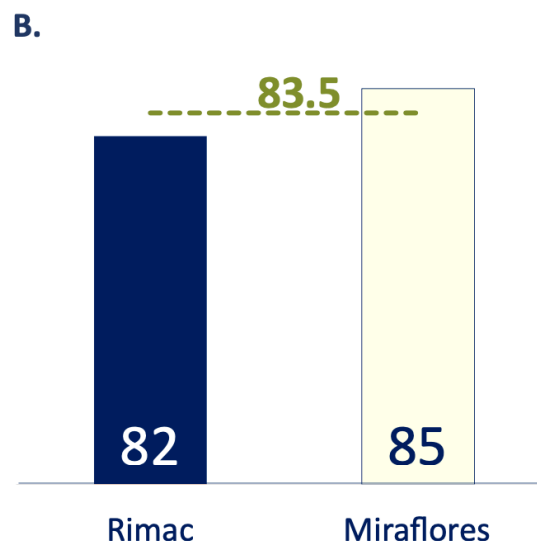


Solution utilitariste



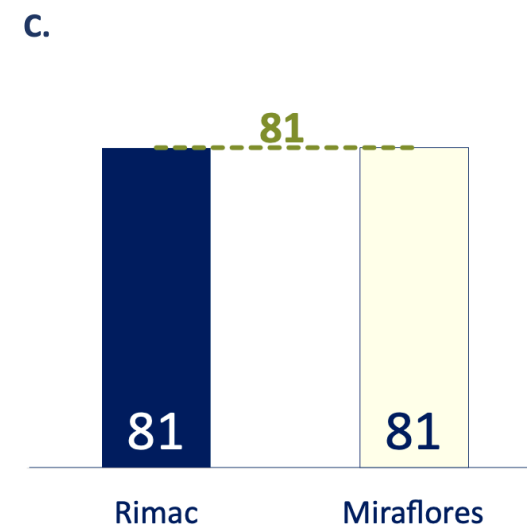
22,09% le classent en 1
52,11% le classent en 3

Solution Rawsienne



33,35% le classent en 1
7,54% le classent en 3

Solution égalitariste



43,56% le classe en 1
40,35% le classent en 3

La solution égalitariste est préférée à la solution Rawlsienne qui est classée 2d par la grande majorité.

Les égalitaristes sont des femmes, âgées de moins de 70 ans, en état de santé autre que très bon, bac + 3 et 4, centristes.

Ceux qui rejettent l'égalitarisme sont âgés de plus de 60 ans, avec un état de santé très bon, bac + 3 et 4 et non extrémistes

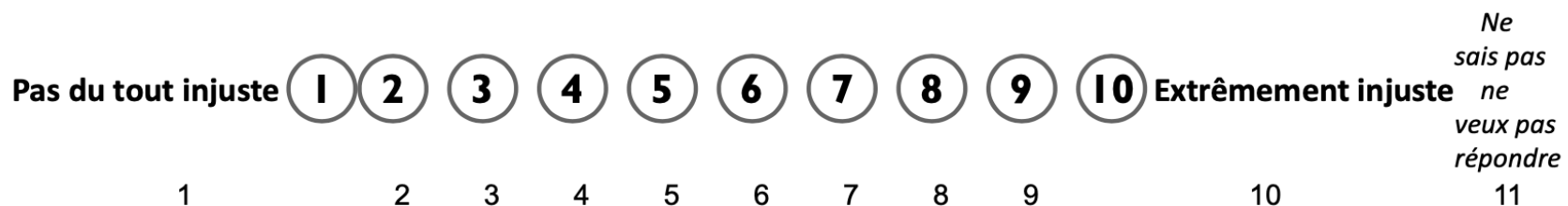
Veillez notez sur une échelle de 1 à 10 le degré d'injustice des situations suivantes :

« Les vingt pour cent des Français les plus riches ont plus souvent / plus de chances / de risque que les vingt pour cent les plus pauvres »

- d'avoir une alimentation saine et d'avoir un niveau d'exercice sain
- de recourir au généraliste
- de faire des tests de dépistage de routine (type dépistage du cancer du colon)
- d'avoir accès à un spécialiste lorsqu'ils sont malades
- d'attendent moins longtemps pour se faire opérer

« Les vingt pour cent des Français les plus riches ont moins de risque que les vingt pour cent les plus pauvres »

- de mourir après une chirurgie à haut risque
- d'être opéré en urgence alors que cela aurait pu être évité par des soins de qualité
- de décéder alors que cela aurait pu être évité par des soins de qualité



	Peu ou pas injuste 1-3	Modérément injuste 4-6	Très injuste 7-9	Extrêmement injuste 10
Alimentation et exercice sain	7.22%	23.43%	43.52	24.54
Généralistes	7.39%	21.57%	40.40%	29.16%
Dépistage	7.31%	22.51%	39.31%	29.24%
Spécialistes si malades	6.41%	16.93%	44.46%	31.08%
Attente pour se faire opérer	4.46%	13.56%	33.58%	46.91%
Mourir après chirurgie	4.88%	18.82%	31.78%	41.51%
Hospitalisation évitable par des soins de qualité	4.09%	16.86%	40.75%	36.55%
Décès évitable par des soins de qualité	4.12%	14.09%	37.90%	42.32%

- 70% à 80 % des individus trouvent ces inégalités d'accès aux soins injustes
- Le sentiment d'injustice augmente avec la gravité de la situation décrite et lorsque les conséquences en terme de mortalité sont décrites
- Sentiment d'injustice plus faible chez les hommes, les moins de 30 ans, les personnes sans aucun diplôme, gagnant plus de 2500 ou 3000 euros, les personnes vivant dans des villes de plus de 100 000 habitants, les personnes vivant sans enfants, les personnes avec un état de santé bon ou très bon, les personnes ayant une orientation politique à droite. Aucune différence entre l'Ile de France et le reste de la France.

Supposons que deux individus, aussi malades l'un que l'autre, aient besoin de la même opération du cœur. L'un ne fume pas, l'autre est un gros fumeur. À votre avis, qui devrait être opéré en premier ?

Le non fumeur	
Le gros fumeur	
La consommation de tabac ne devrait pas faire de différence	
Ne peut choisir	

Supposons que deux individus, aussi malades l'un que l'autre, aient besoin de la même opération du cœur. L'un ne fume pas, l'autre est un gros fumeur. À votre avis, qui devrait être opéré en premier ?

Le non fumeur	31.52%
Le gros fumeur	6.16%
La consommation de tabac ne devrait pas faire de différence	55.72%
Ne peut choisir	6.61%

La majorité de l'échantillon est égalitariste `

Mais un tiers de l'échantillon souhaite rémunérer l'effort

Très peu veulent prioriser l'individu le plus à risque en raison d'un manque d'effort

Les problèmes de santé peuvent avoir plusieurs causes. Pensez-vous que si les gens souffrent de graves problèmes de santé, c'est principalement ... ?

Comportements mauvais pour la santé	
En raison de l'environnement	
Conditions de travail	
Pour des raisons génétiques	
Parce qu'ils sont pauvres	
Ne peut choisir	

Les problèmes de santé peuvent avoir plusieurs causes. Pensez-vous que si les gens souffrent de graves problèmes de santé, c'est principalement ... ?

Comportements mauvais pour la santé	30.03%
En raison de l'environnement	23.50%
Conditions de travail	9.52%
Pour des raisons génétiques	11.01%
Parce qu'ils sont pauvres	6.13%
Ne peut choisir	19.81%

De manière cohérente les mauvais comportements sont perçus comme la cause première des problèmes de santé

**Ce qu'en pensent les philosophes et
les économistes spécialistes de la
justice et du choix social**

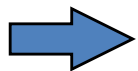
Équité dans la santé, la consommation, et le financement des soins

La plupart des systèmes se rapporte au principe de tradition égalitariste « A chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités » et cherche à limiter les inégalités sociales de santé. Les principes d'équité suivants doivent être respectés, en particulier ceux en bleu.

Équité	Financement	Utilisation des soins	Etat de santé
Horizontale	Financement égal à capacité contributive égale	Traitement égal à besoin de soins égal (même maladie)	Santé identique à âge donné dans tous les groupes sociaux (définis selon les circonstances)
Verticale	Financement inégal à capacité contributive inégale (revenu)	Traitement inégal à besoin de soins inégal	Inégalités de santé liées à l'âge, le sexe, aux efforts, aux préférences

Équité horizontale dans la consommation de soins

- C'est le principe que l'on cherche avant tout à respecter, en particulier en France
- Ce principe exige un traitement égal à besoin de soin égal : "à chacun selon ses besoins"
- Ce principe interdit donc toute inégalité de recours selon le niveau de vie, le lieu d'habitation, à besoin de soins comparable
- Car offrir de soins à ceux qui souffrent est un respect élémentaire de la dignité humaine
- Car avoir un accès équitable aux soins est un élément essentiel pour réduire les inégalités en santé
- L'accès aux soins peut être vu comme un bien premier



On qualifie d'inéquités de consommation de soins, ou inégalités sociales de consommation de soins, les différences systématiques de consommation de soins à besoin de soins donné (c'est-à-dire pour un même état de santé, même âge, même sexe), qui sont constatées entre groupes sociaux (selon le revenu, le niveau d'éducation, la profession, la nationalité, l'ethnicité, le milieu social d'origine, le lieu d'habitation...)

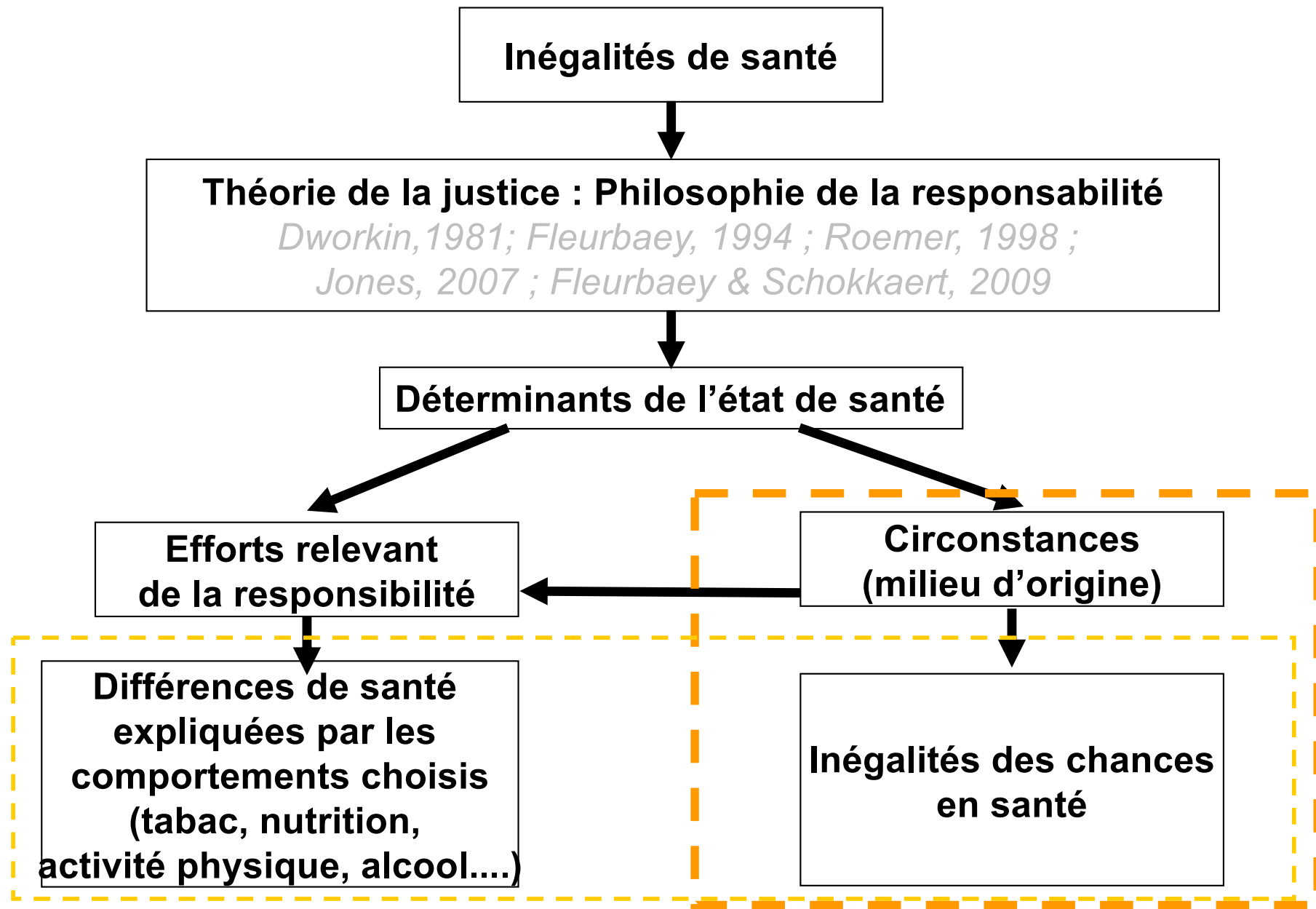
Equité verticale dans le financement des soins

- Le principe d'équité verticale exige un financement aux soins croissant avec la capacité à payer (le revenu) (indépendamment du besoin de soins) : “de chacun selon ses capacités”
 - Financement proportionnel au revenu
 - Financement progressif, c'est à dire plus que proportionnel avec le revenu, qui représente une part de plus en plus grande du revenu quand le revenu augmente
 - Cela permet de garantir l'accès aux soins de tous en déconnectant le financement de soins de l'utilisation des soins
 - Cela permet d'éviter que les besoins de soins et donc les dépenses de santé n'aggravent les inégalités de revenu initiales, grâce à un financement proportionnel au revenu ou progressif
 - Cela permet d'avoir un instrument de plus pour redistribuer le revenu, lorsque le financement est strictement progressif
 - C'est pourquoi le financement des soins passe par des cotisations sociales croissantes avec les salaires dans les systèmes Bismarkiens, et par des impôts croissants avec les revenus dans les systèmes Beveridgiens
-  On dit qu'il y a un financement des soins inéquitable si celui-ci n'est pas croissant avec le revenu, et s'il est croissant avec les besoins de soins et l'utilisation des soins

Equité dans la santé

- On qualifie d'inéquités de santé ou **d'inégalités sociales de santé** les différences systématiques d'état de santé qui sont constatées entre groupes sociaux, à âge et sexe donnés :
 - selon le revenu
 - le niveau d'éducation
 - la profession
 - la nationalité
 - L'éthnicité
 - Le lieu d'habitation
- Toutefois, certains considèrent que toutes les inégalités sociales de santé ne sont pas inévitables.
- Seules celles qui sont liées à des circonstances indépendantes de la responsabilité des individus (comme le milieu d'origine car (on ne choisit pas ses parents) sont considérées comme inévitables ou illégitimes. On parle alors d'**inégalités des chances en santé**.
- Les inégalités de santé dues à des comportements à risque choisis /aux préférences (alcool, tabac, mauvaise nutrition, sédentarité) sont jugées non injustes (c'est-à-dire justes) ou légitimes.

Inégalités de santé et inégalités des chances en santé, effort et circonstances



Les politiques d'égalité des chances

La mise en place d'une politique d'égalité des chances implique donc de respecter deux principes :

- le principe de rémunération de l'effort
- le principe de compensation pour les circonstances

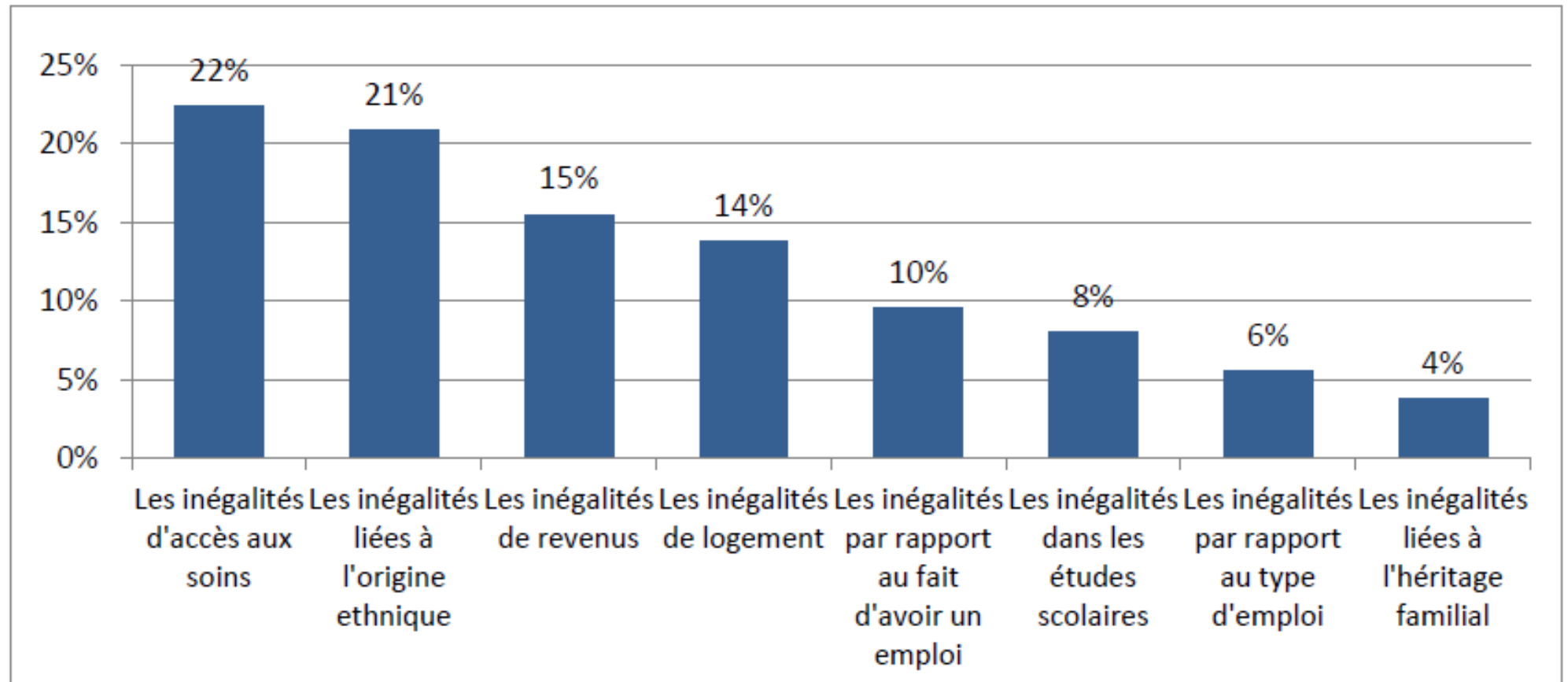
Ce critère justifie des politiques de discrimination positive et de compensation en faveur des personnes victimes de ces circonstances (éducation à la santé en milieu scolaire, ...), mais aussi des politiques de responsabilisation des agents.

La difficulté est de savoir si les différences d'état de santé sont liées à des circonstances (origine sociale, besoins...) ou à des différences d'effort ou de préférences.

Cela est d'autant plus difficile que les circonstances influencent l'effort :
Doit-on rendre responsables les enfants de fumeurs d'être fumeur ?

Ce qu'en pensent les gens

Les inégalités les moins acceptables

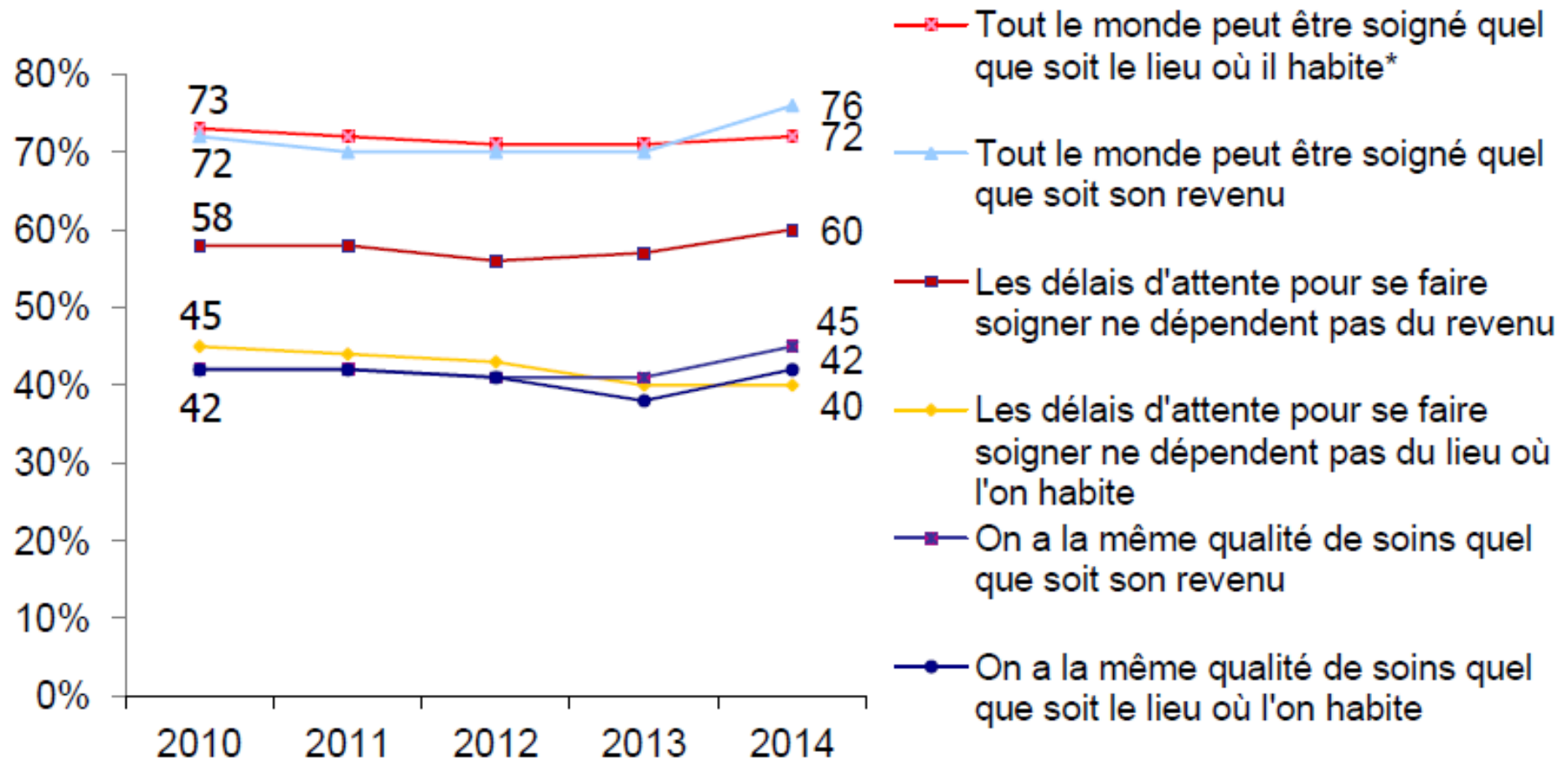


Réponse à la question : "Il existe plusieurs types d'inégalités. Parmi les suivantes, quelles sont celles qui sont **LES MOINS ACCEPTABLES** aujourd'hui dans la société française... ?".

Champ : personnes de 18 ans ou plus en France métropolitaine.

Source : BVA, Baromètre d'opinion Drees 2014

Des inégalités qui existeraient ou non



Réponse à la question : " Êtes-vous d'accord ou pas avec les opinions suivantes ? En France..."
Champ : personnes de 18 ans ou plus en France métropolitaine.

L'accès aux soins vraiment pour tous ?

Les gens devraient avoir accès aux soins financés par l'Etat même s'ils se comportent d'une manière qui nuit à leur santé

oui	non	Sans opinion	Ne peut pas choisir
26%	47%	23%	4%

La santé n'a pas de prix... mais elle a un coût

Dans quelle mesure seriez-vous prêt(e) à payer des impôts plus élevés pour augmenter le niveau de soins médicaux offerts à l'ensemble de la population?

Prêt(e)	Pas prêt(e)	Sans opinion	Ne peut pas choisir
20,5%	55,5%	20%	4%

Les inégalités sociales de santé :

Pourquoi ?

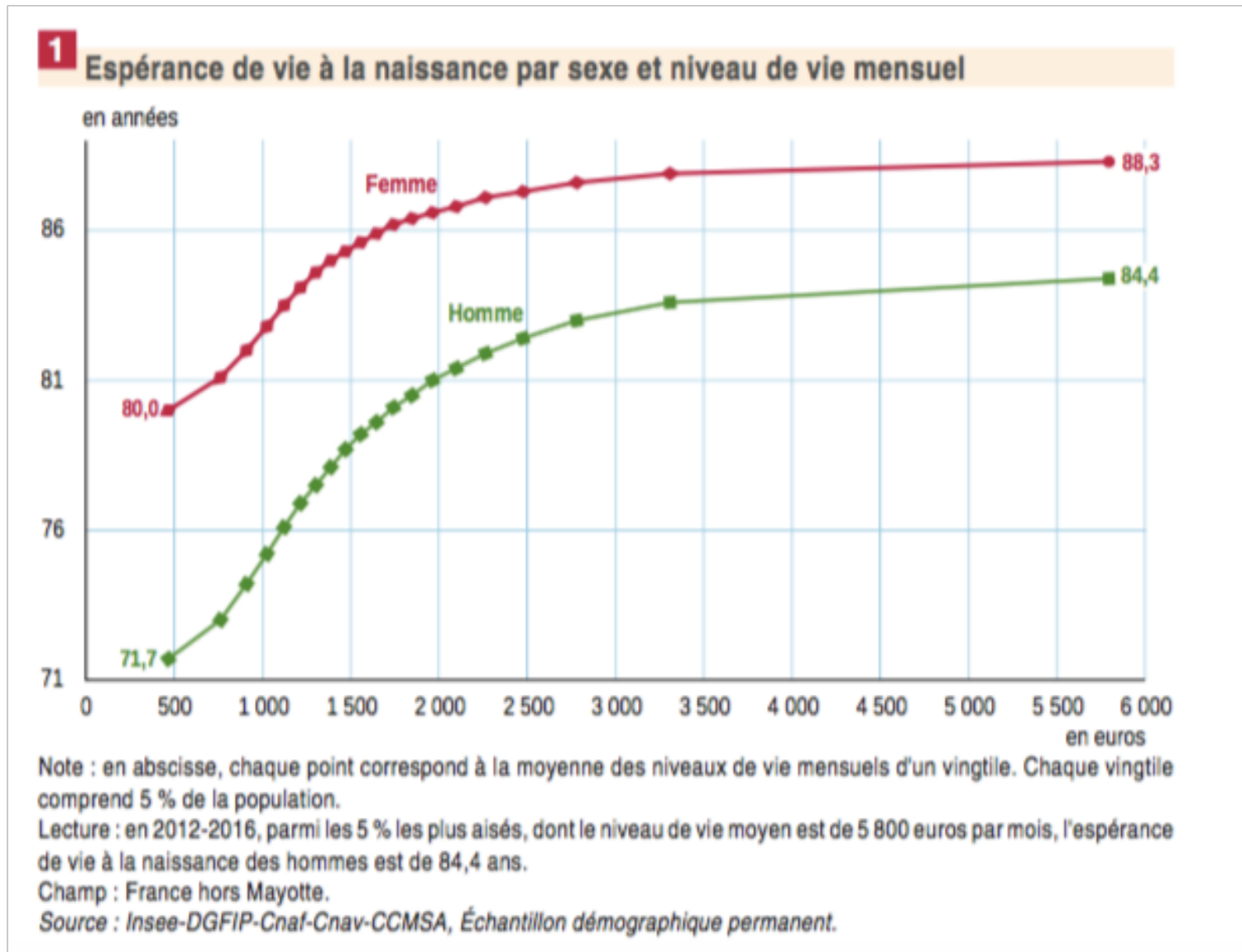
Les grands types de causes

- Revenu et conditions matérielles de vie
- **Déterminants psycho-sociaux**
- **Effet inverse de l'état de santé sur la situation sociale**
- **Comportements à risque**
- **Difficultés d'accès aux soins**
- **Inégalités face à la complémentaire santé**

Revenu, conditions de vie matérielles de vie et santé

- Quels sont les rôles spécifiques des conditions matérielles de vie et en particulier du revenu dans la construction des inégalités ?
- C'est une question importante car le revenu est l'un des déterminants sur lequel il est le plus facile d'intervenir par des transferts monétaires et des subventions
- Il est également possible d'intervenir au travers les politiques de lutte contre la pauvreté et notamment la politique du logement ou l'aménagement urbain

Espérance de vie selon le niveau de revenu



Blanpain N. (2018), « L'espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d'écart entre les plus aisés et les plus modestes », Insee Première, 1687.

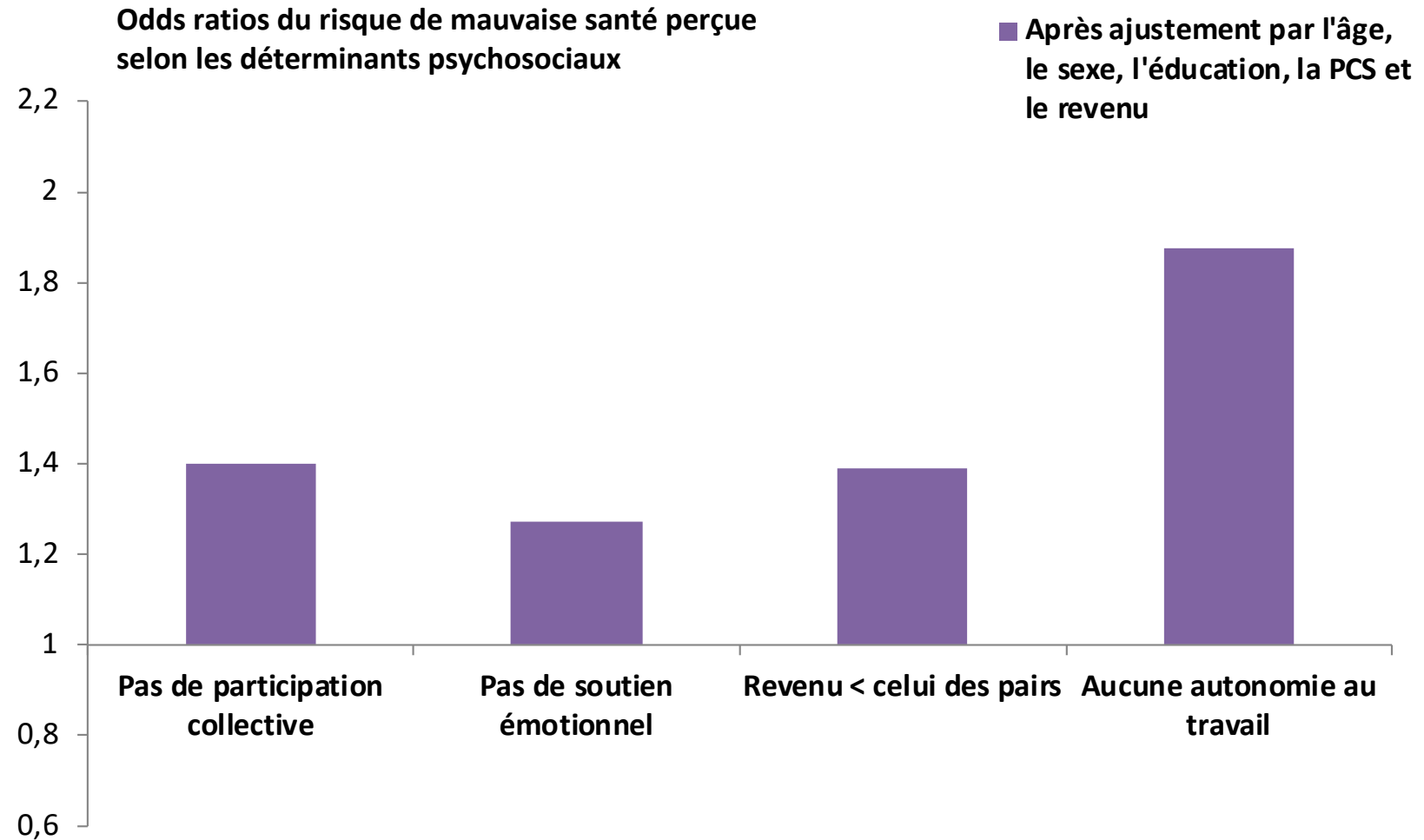
Un effet causal du revenu sur la santé ?

- L'observation d'une corrélation entre santé et revenu signifie-t-il pour autant que le revenu a un effet causal sur la santé ? Un supplément de revenu peut-il améliorer la santé ?
- Pas forcément, cette corrélation peut autant provenir
 - d'un effet du revenu sur la santé
 - d'un effet inverse des problèmes de santé sur les revenus
 - de variables non observées corrélées à la fois au revenu et à la santé (conditions de travail, patrimoine génétique,)
- Plusieurs approches permettent d'étudier l'effet causal du revenu sur la santé :
 - Etudier l'évolution de la santé en relation avec l'évolution du revenu : Causalité à la Granger
 - *Adams et al. (2003), Adda et al. (2003), Meer et al. (2003) : effet de la richesse sur la santé mentale et la santé perçue (pas la mortalité)*
 - Etudier l'effet d'une augmentation « exogène » du revenu (processus quasi expérimental)
 - Transferts reçus des parents : Scodellaro, Khlaf, Jusot (2010) : effet sur la très bonne santé perçue
 - Gain à la loterie : Lindhal (2002), Gardner et Oswald (2007), Apouey et Clark (2010) : effet sur la santé perçue, surtout sur la santé mentale
 - Changement non anticipé des prestations reçues : Snyder et Evans (2006) : effet négatif sur le risque de décès de la diminution des pensions reçues par les individus nés après 1917
 - Approche par les variables instrumentales : effet sur la santé d'une variable qui, si elle a un effet sur la santé, ne peut passer que par un effet du revenu

Les grands types de causes

- **Conditions matérielles de vie**
- **Déterminants psycho-sociaux**
- **Effet inverse de l'état de santé sur la situation sociale**
- **Comportements à risque**
- **Difficultés d'accès aux soins**
- **Inégalités face à la complémentaire santé**

Santé et Déterminants psychosociaux

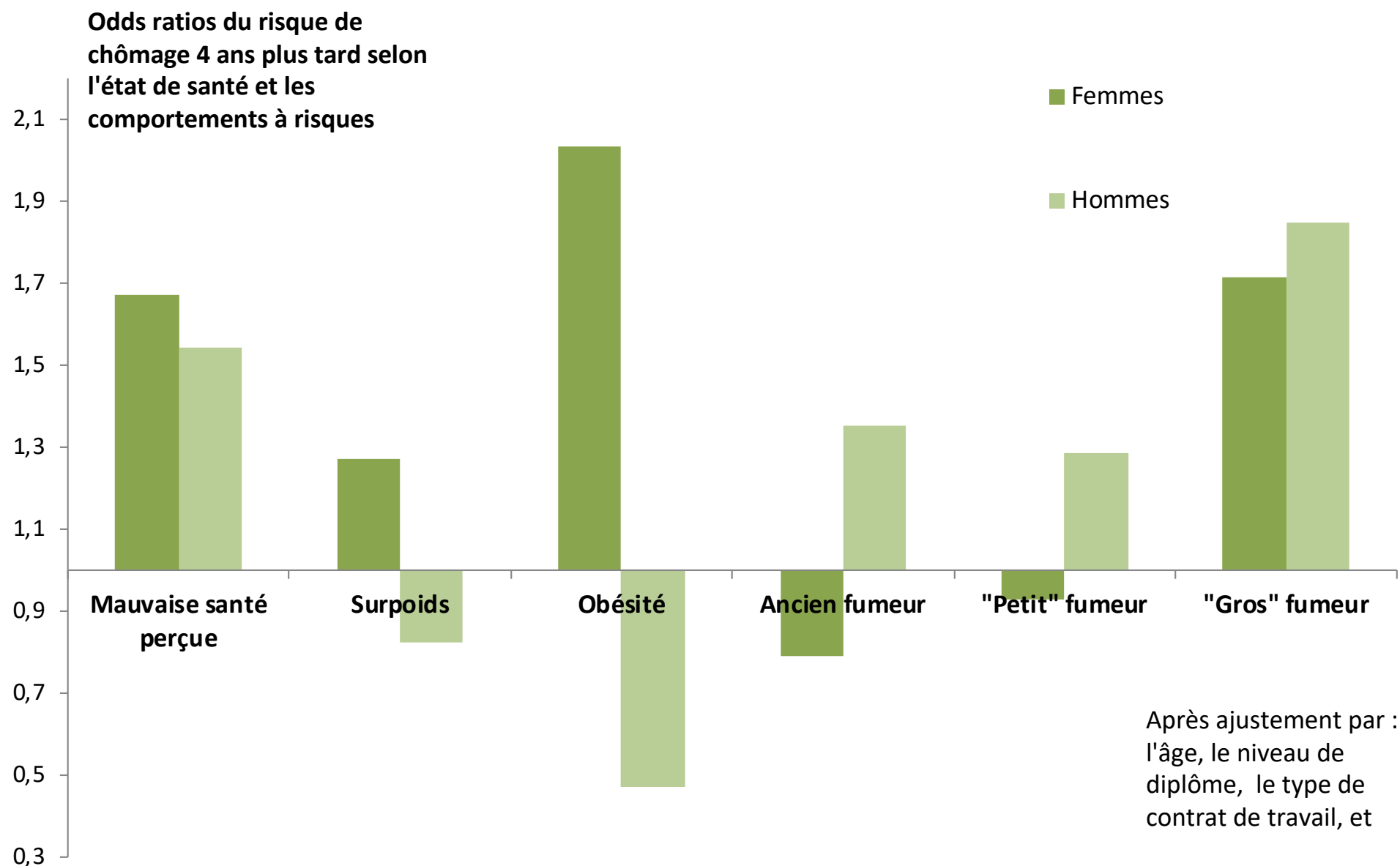


Jusot F., Grignon M., Dourgnon P. (2008), " Access to psycho-social resources and health: exploratory findings from a survey of the French population ", Health economics, Policy and Law, 3, 4: 365–391.

Les grands types de causes

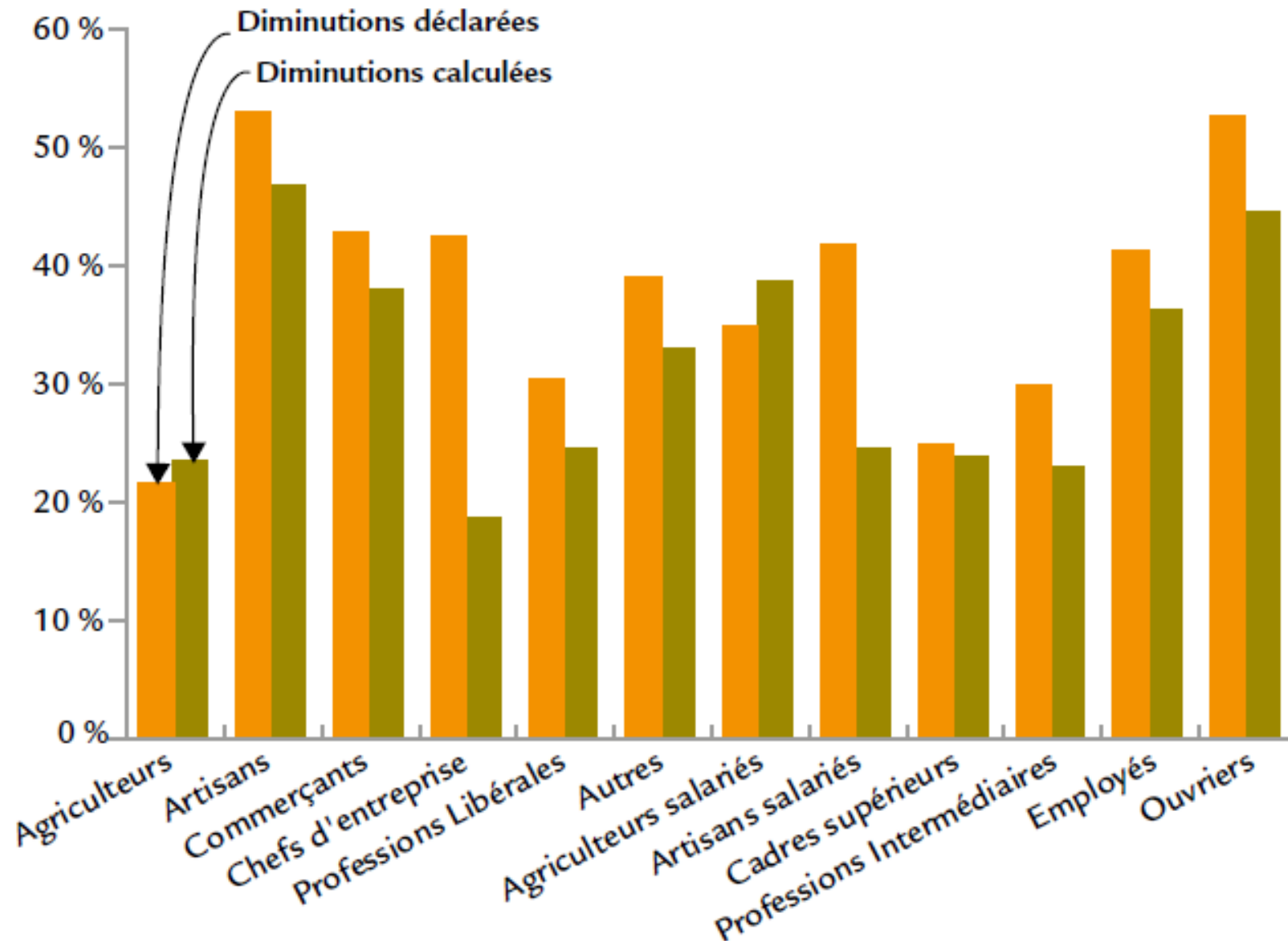
- Conditions matérielles de vie
- Déterminants psycho-sociaux
- Effet inverse de l'état de santé sur la situation sociale
- Comportements à risque
- Difficultés d'accès aux soins
- Inégalités face à la complémentaire santé

Impact de la santé sur le risque de chômage



Jusot F., Khlata M., Rochereau T., Sermet C. (2008), "Job loss from ill-health, smoking and obesity: concurrent evidence for direct and indirect selection", *Journal of Epidemiology and Community Health*, 62, 4 : 332-337.

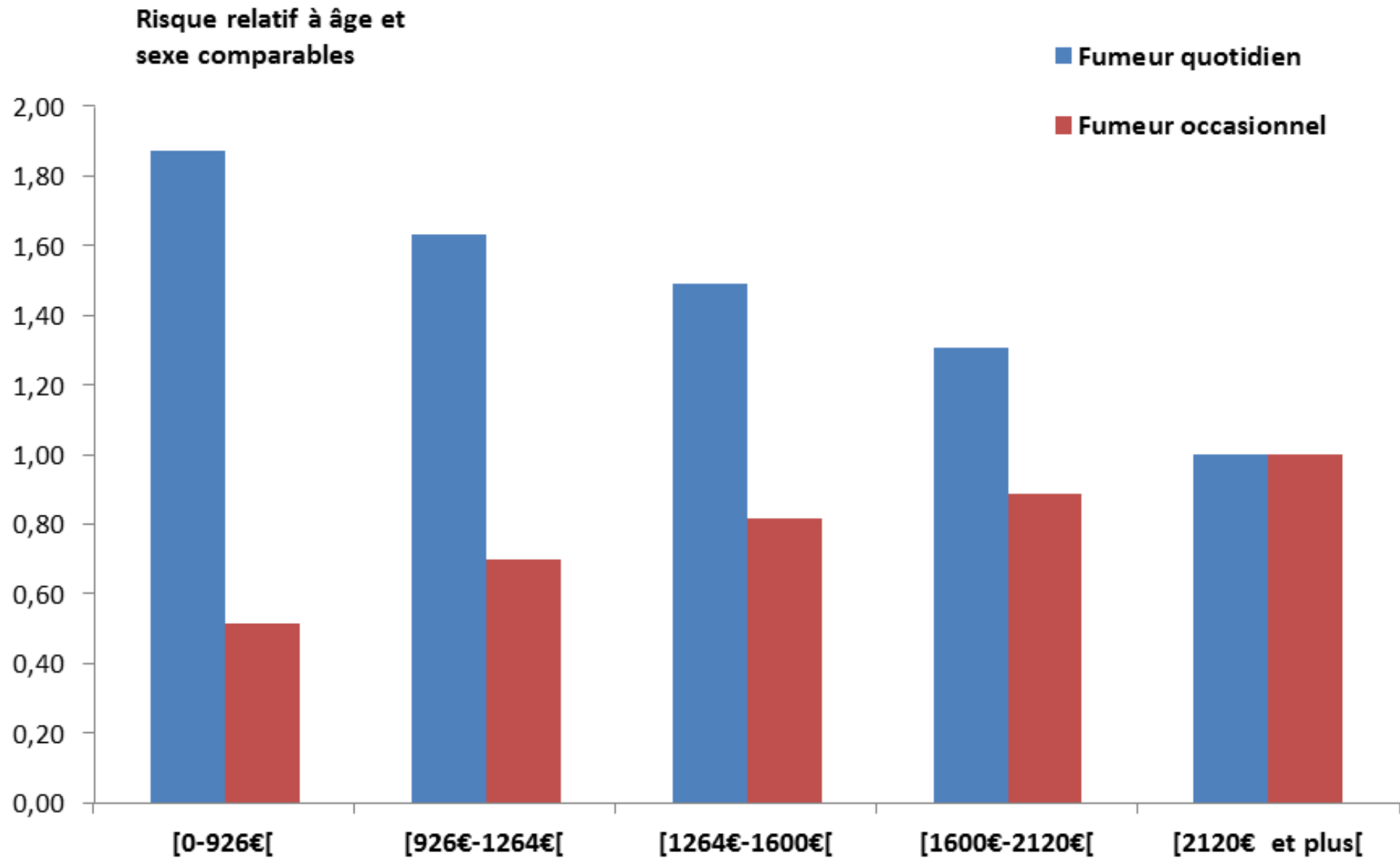
Pourcentage de personnes ayant subi une baisse de leur revenu après leur cancer



Les grands types de causes

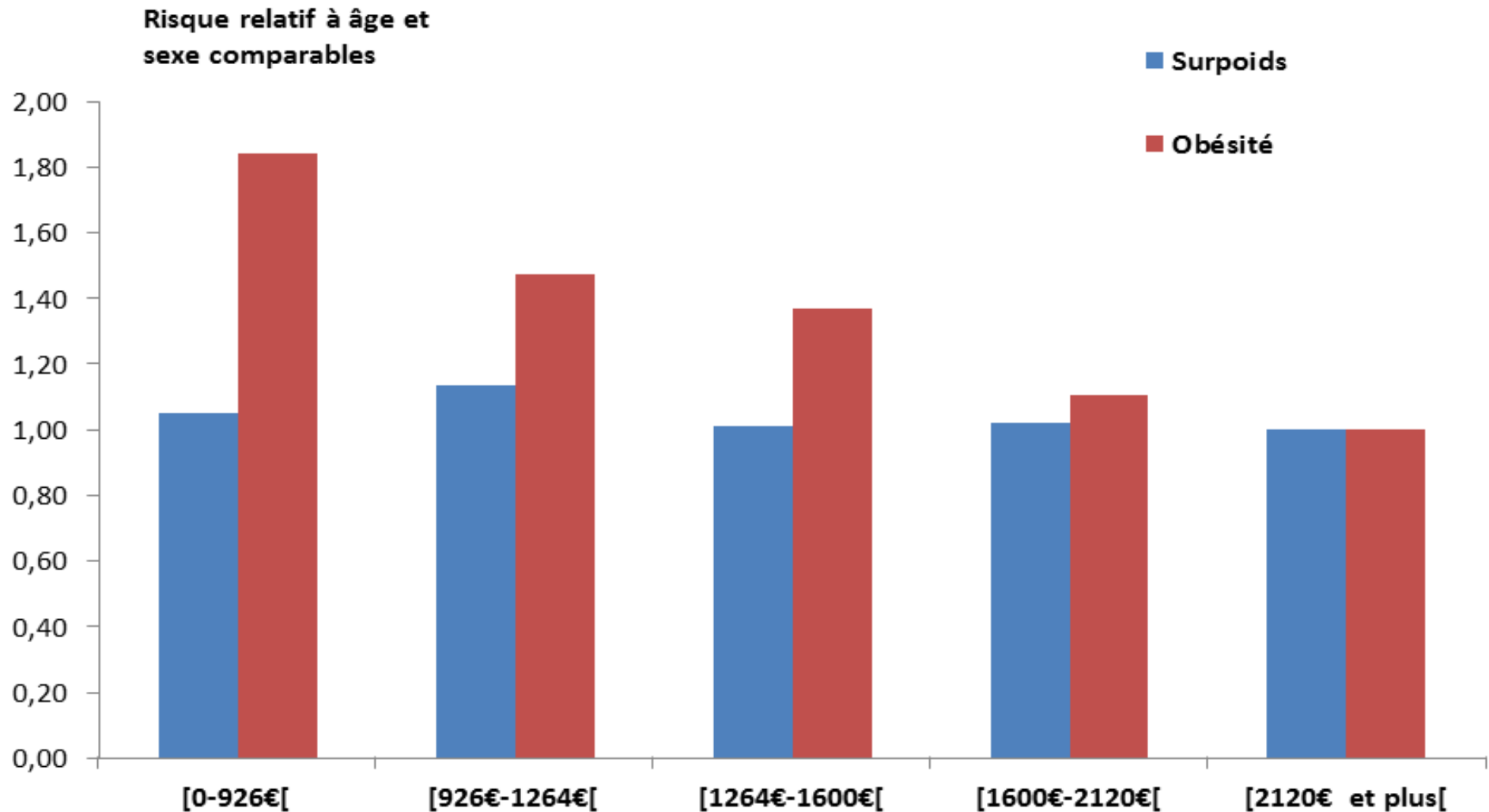
- **Conditions matérielles de vie**
- **Déterminants psycho-sociaux**
- **Effet inverse de l'état de santé sur la situation sociale**
- **Comportements à risque**
- **Difficultés d'accès aux soins**
- **Inégalités face à la complémentaire santé**

Inégalités face au tabagisme en 2012



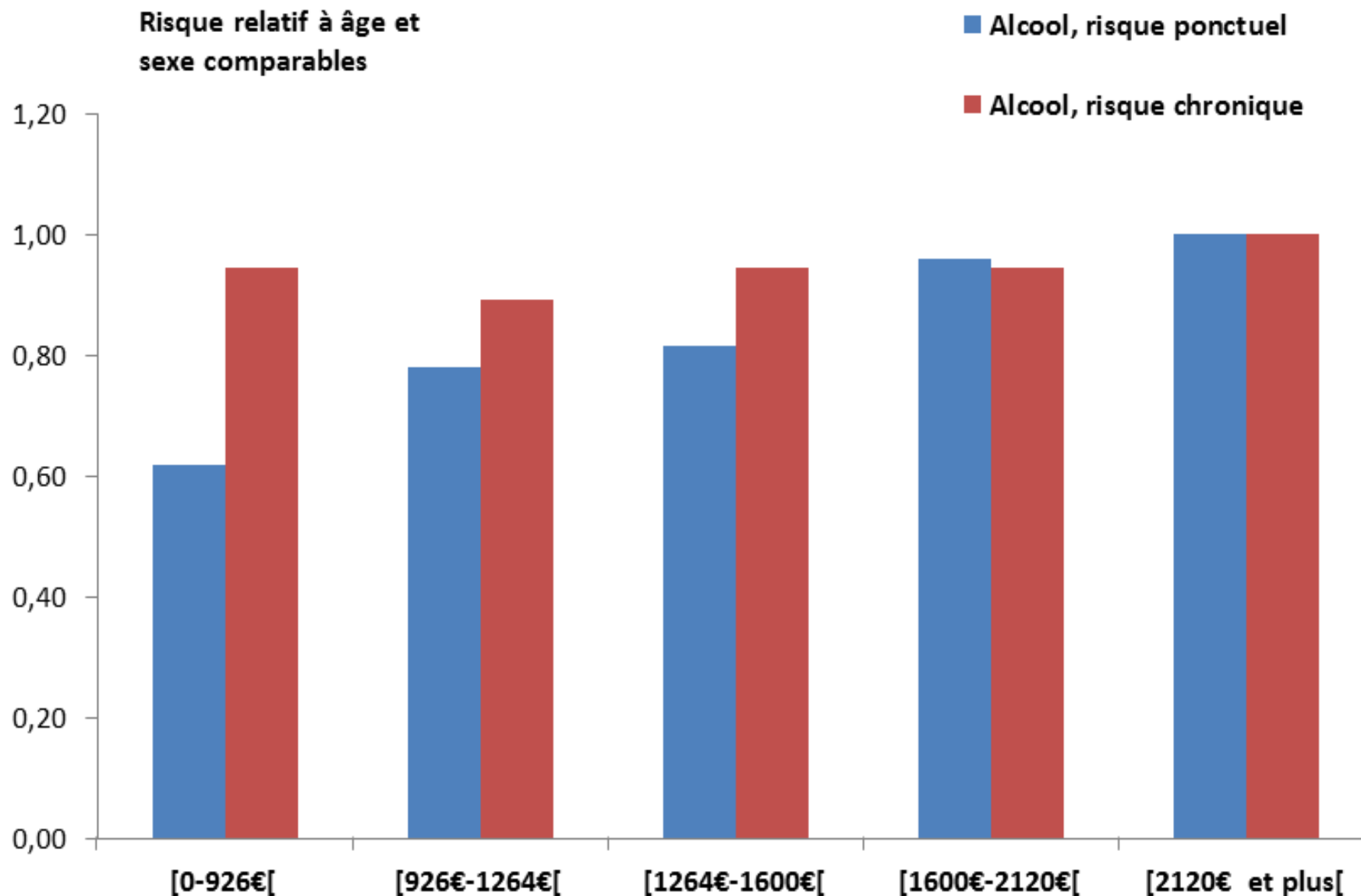
Source : Calculs de l'auteur d'après Célant N., Guillaume S., Rochereau T. (2014), « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », Les rapports de l'Irdes, n°556.

Inégalités face à l'obésité en 2012



Source : Calculs de l'auteur d'après Célant N., Guillaume S., Rochereau T. (2014), « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », Les rapports de l'Irdes, n°556.

Inégalités face à l'alcool en 2012

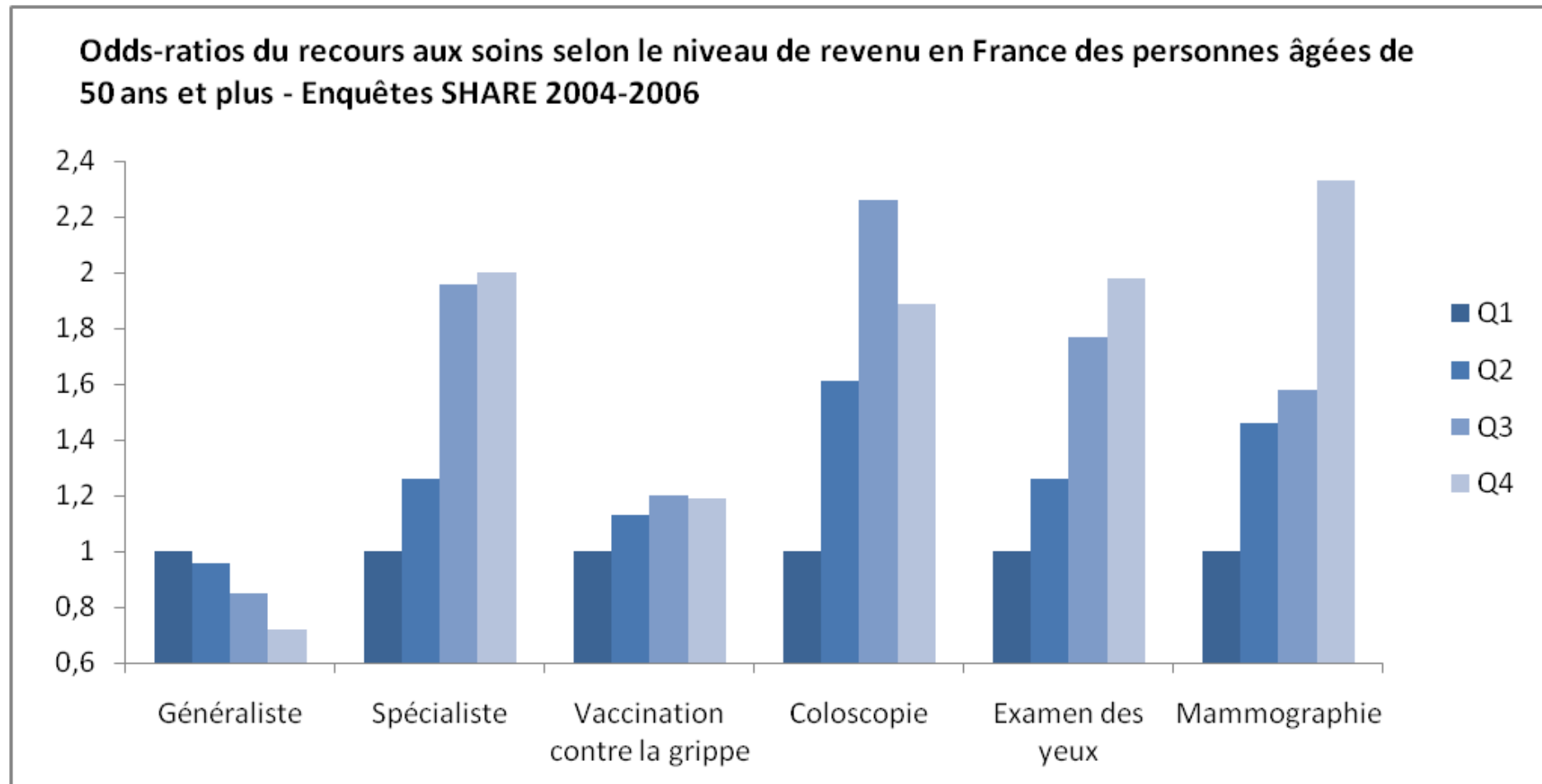


Source : Calculs de l'auteur d'après Célant N., Guillaume S., Rochereau T. (2014), « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », Les rapports de l'Irdes, n°556.

Les grands types de causes

- **Conditions matérielles de vie**
- **Déterminants psycho-sociaux**
- **Effet inverse de l'état de santé sur la situation sociale**
- **Comportements à risque**
- **Difficultés d'accès aux soins**

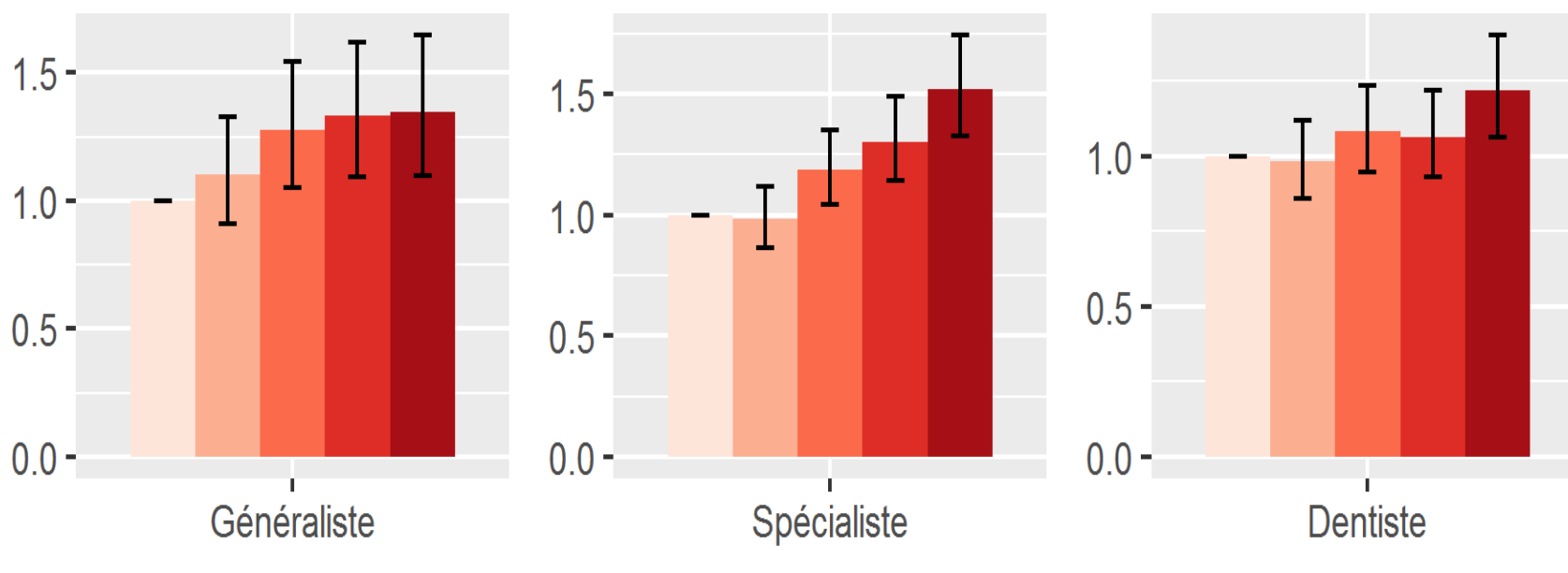
Des inégalités de recours aux soins d'autant plus marquées pour les soins réalisés par les spécialistes



Source : Jusot F. (2010), « Inégalités de recours à la prévention et Inégalités de santé en Europe : Quel rôle attribuable aux systèmes de santé ? », rapport dans le cadre programme GIS-IReSP Institut de Recherche en Santé Publique « Prévention »)

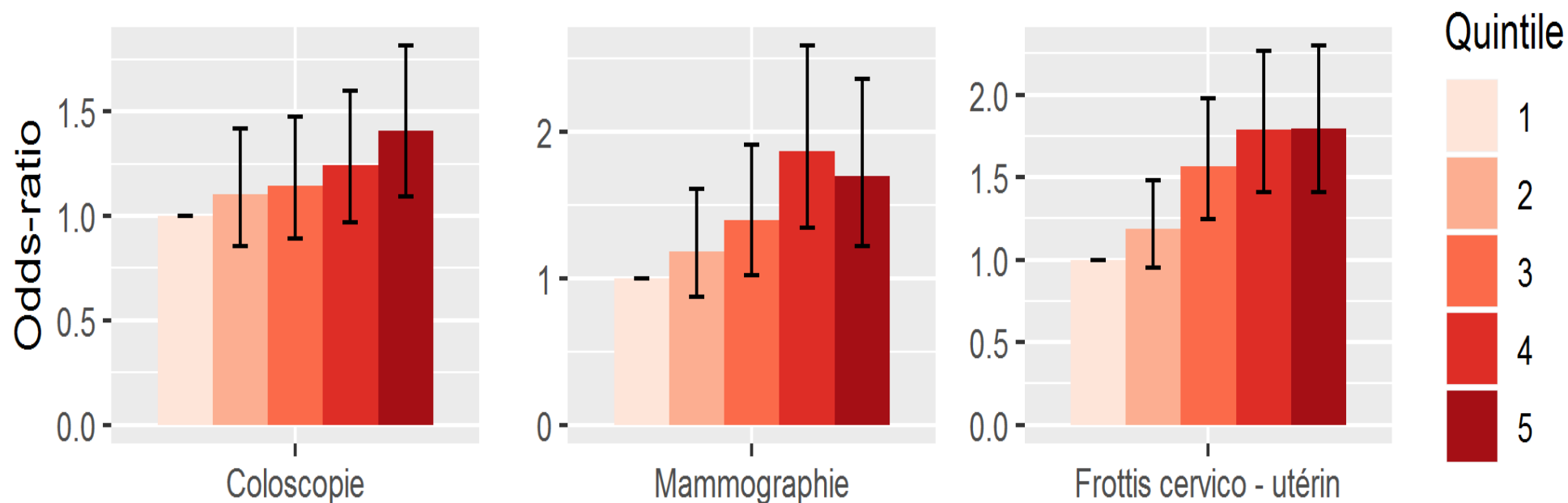
Résultats après ajustement par l'âge, le sexe et l'état de santé

Inégalités de recours en 2014 selon le revenu, après ajustement par l'état de santé, l'âge, l'éducation et la couverture



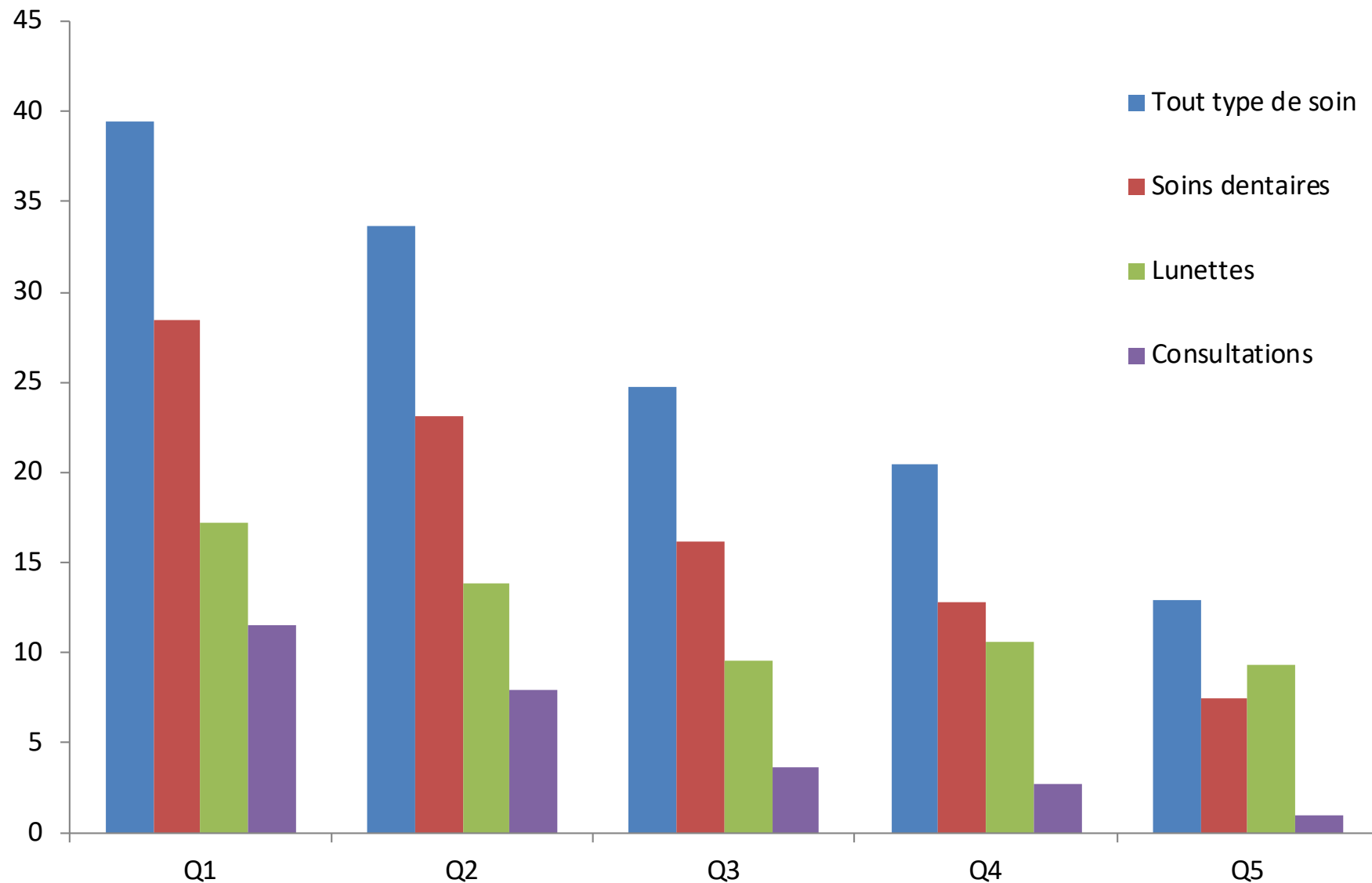
Source : Enquête EHIS-ESPS 2014

Inégalités de recours en 2014 selon le revenu, après ajustement par l'état de santé, l'âge, l'éducation et la couverture



Source : Enquête EHIS-ESPS 2014

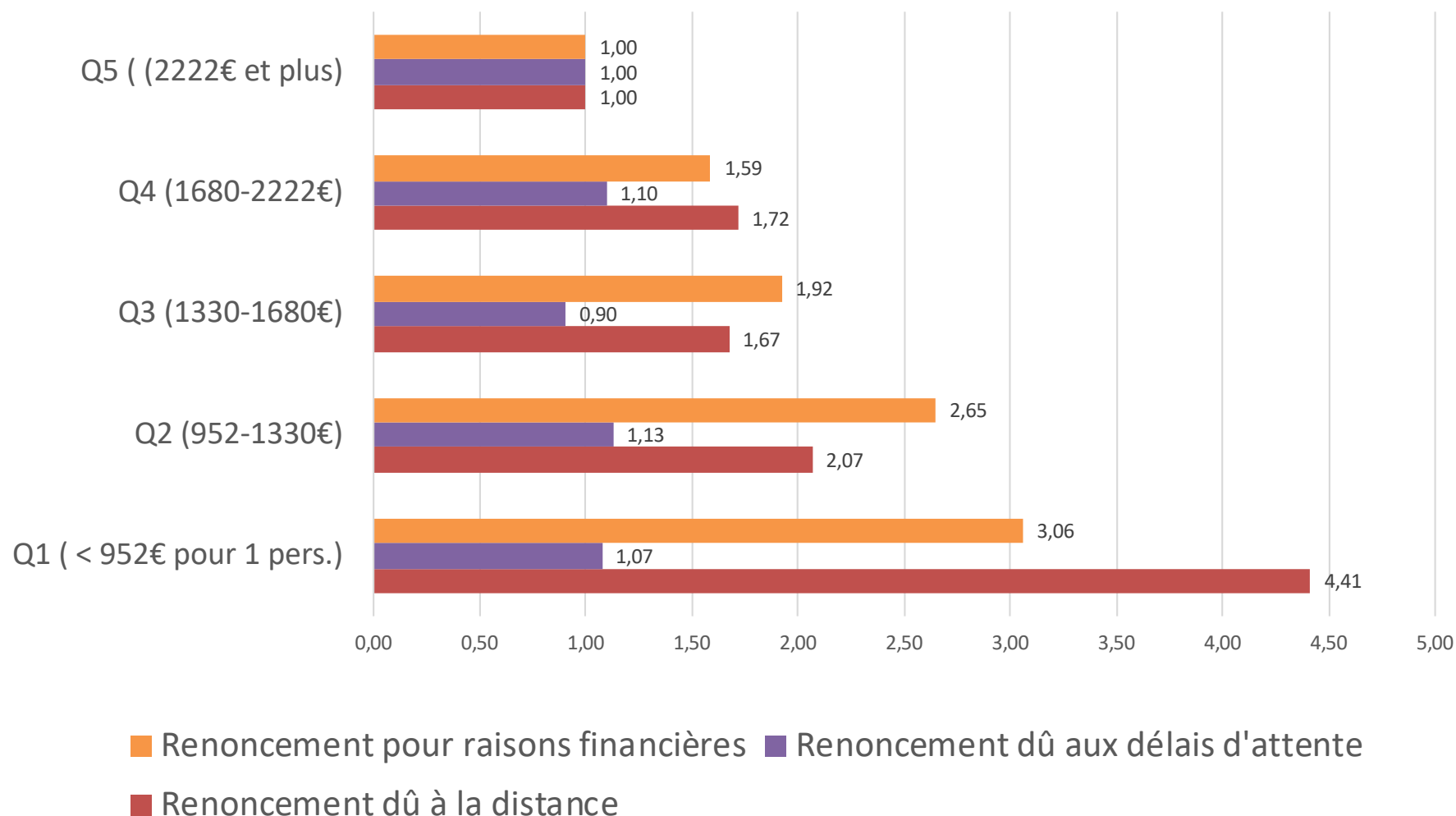
Des renoncements aux soins importants chez les plus démunis en 2014



Source : Enquête EHIS-ESPS 2014

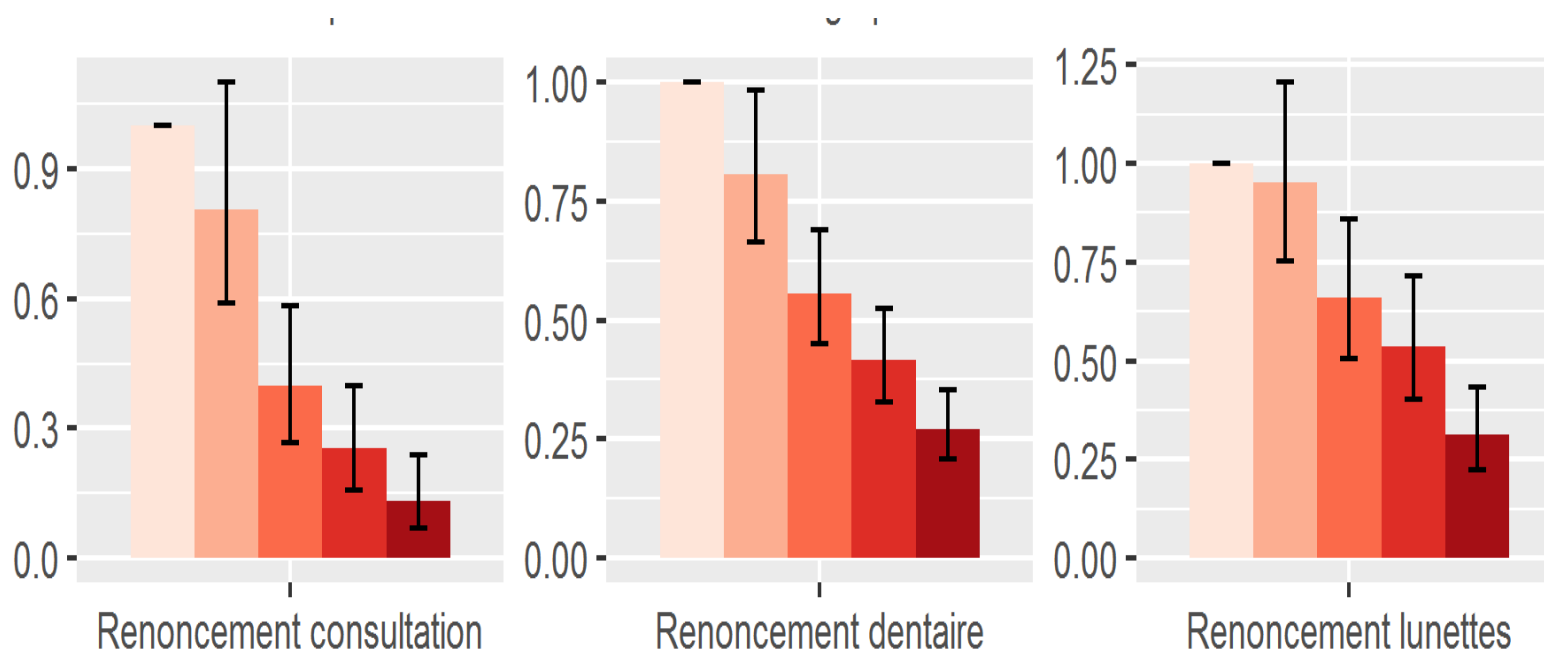
Des renoncements plus importants pour raisons financières et à cause de la distance chez les plus démunis

Risques relatifs de renoncement aux soins par rapport au 5° quintile de niveau de vie à âge et sexe donnés en 2014 (EHIS/ESPS)



Source : Enquête EHIS-ESPS 2014

Inégalités de renoncement en 2014 selon le revenu, après ajustement par l'état de santé, l'âge, l'éducation et la couverture



Source : Enquête EHIS-ESPS 2014

**Les inégalités sociales de
consommation de soins.**

Quelles causes ?

Comment expliquer ces différences de d'accès / recours aux soins ?

- Barrières culturelles / Préférences
 - Rapports à la santé, au corps, au risque, au temps différents
 - Rapport au système de soins
- Barrières informationnelles
 - Sur les risques encourus
 - Sur les filières de soins (surtout dans les systèmes orientant peu les patients)
- Barrières financières
 - Coûts des soins (surtout dans les systèmes laissant des restes à charge)
 - Revenu (priorisation différente des consommations guidées par les restrictions à préférences données)
 - Accès à la complémentaire santé
- Comportement des professionnels
 - Différences de diagnostic et de traitement liées aux difficultés de communication entre patients et médecins
 - Stéréotypes des professionnels de santé
 - Demande induite auprès des patients les plus solvables
- La répartition de l'offre de soins, et l'organisation du système de soins

Comment expliquer ces différences de d'accès / recours aux soins ?

Des inégalités sociales de recours aux soins existent partout en Europe mais leur ampleur diffère d'un pays à l'autre

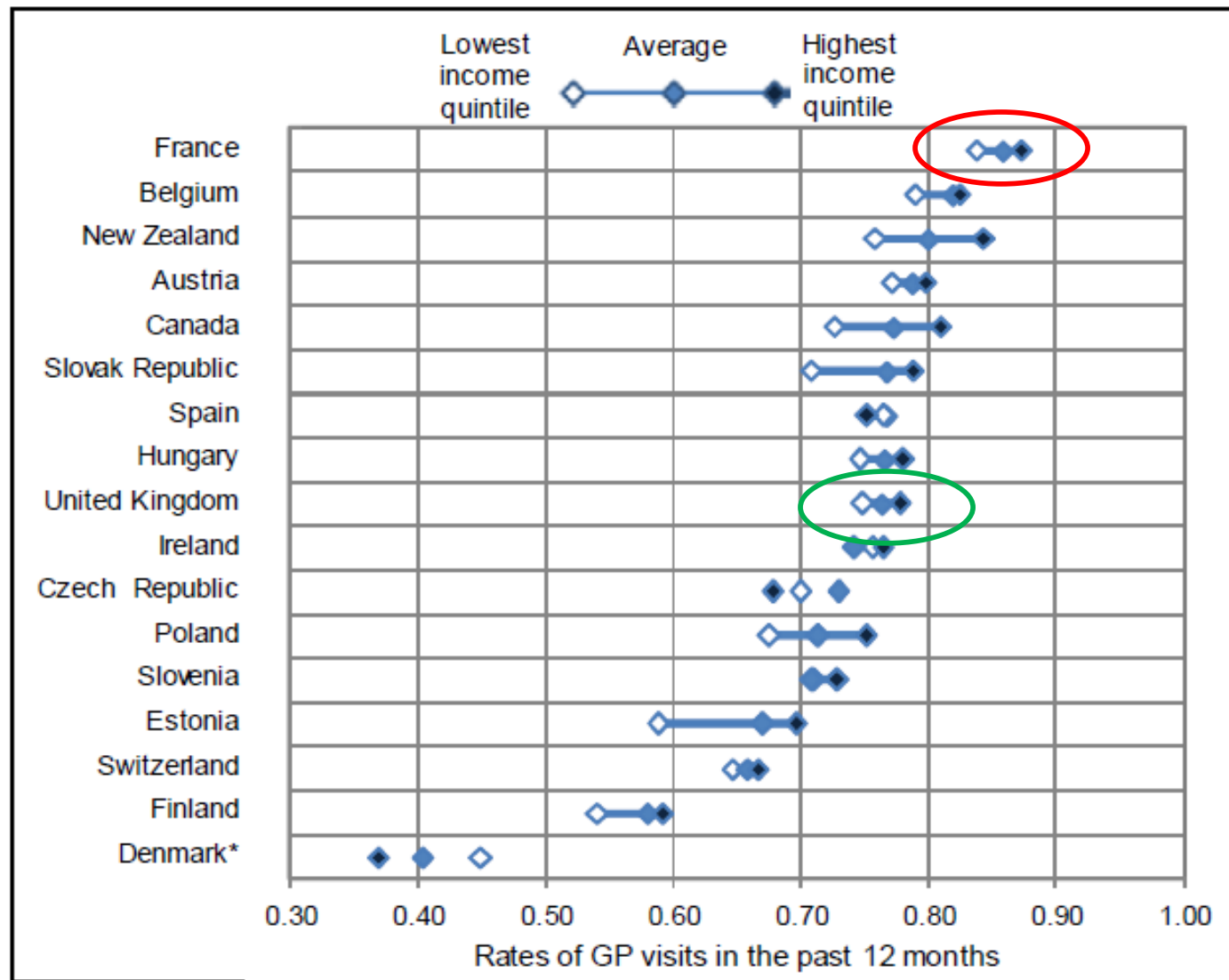
Elles sont plus importantes en France pour les soins de spécialistes et préventifs

Elles sont plus faibles dans les pays ayant un faible niveau de reste à charge, des systèmes de soins beveridgiens et non bismarkiens, une médecine de soins primaires fortes et organisée (orientation dans le système des patients), des médecins non payés à l'acte.

En France, les inégalités de recours aux soins sont liées :

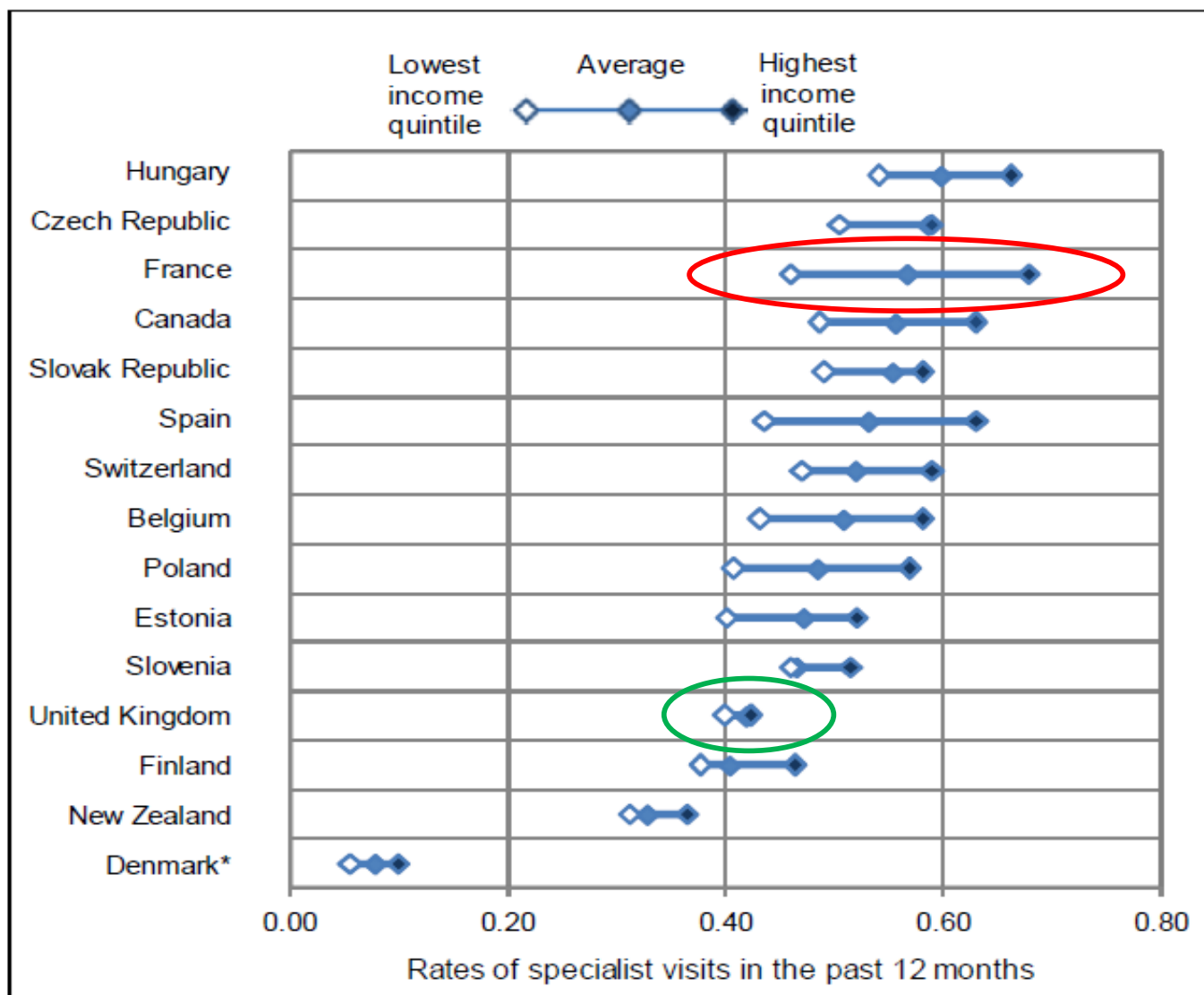
- à la structure des restes à charge
- à la faible orientation des patients dans le système de santé

Peu de différences selon le revenu dans l'accès au généraliste à besoin de soins donné



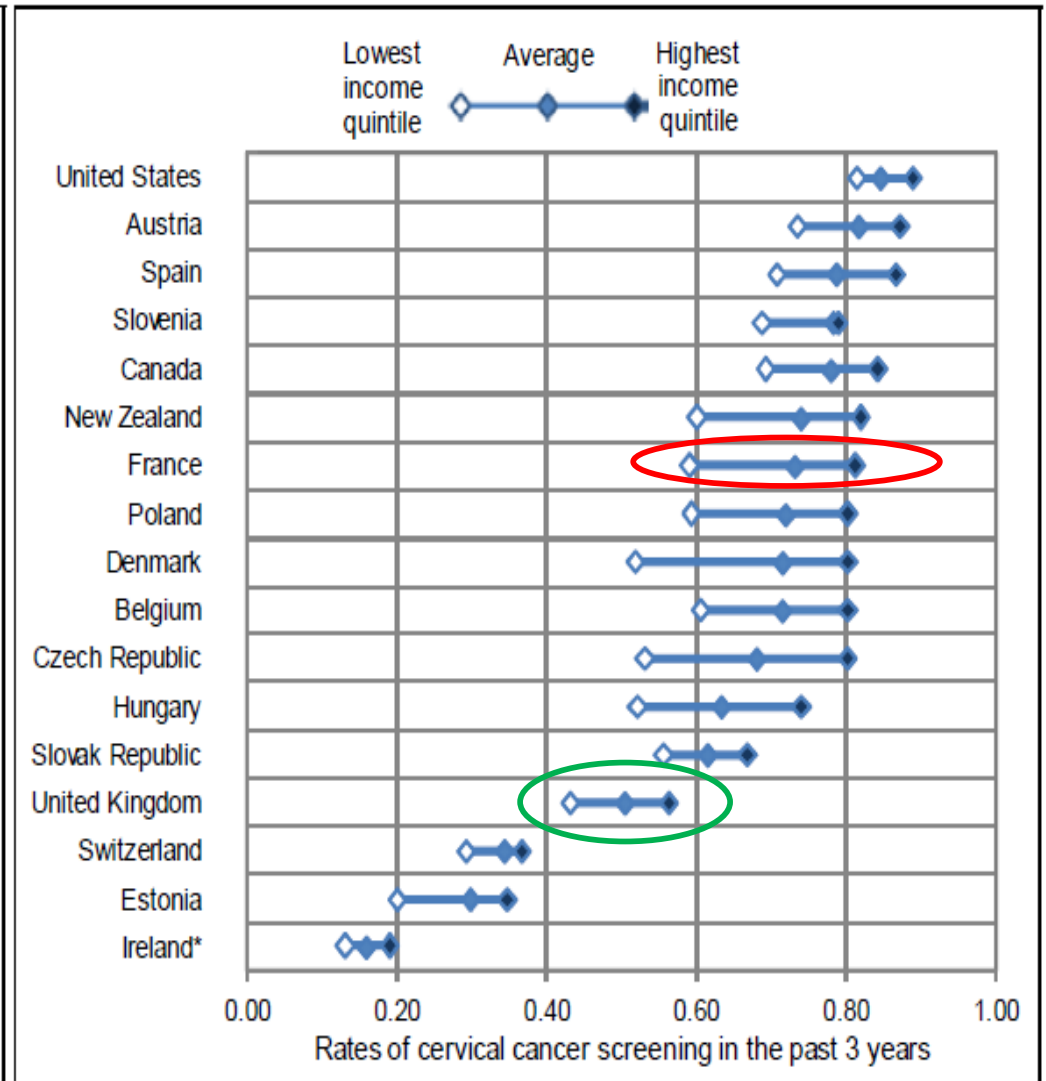
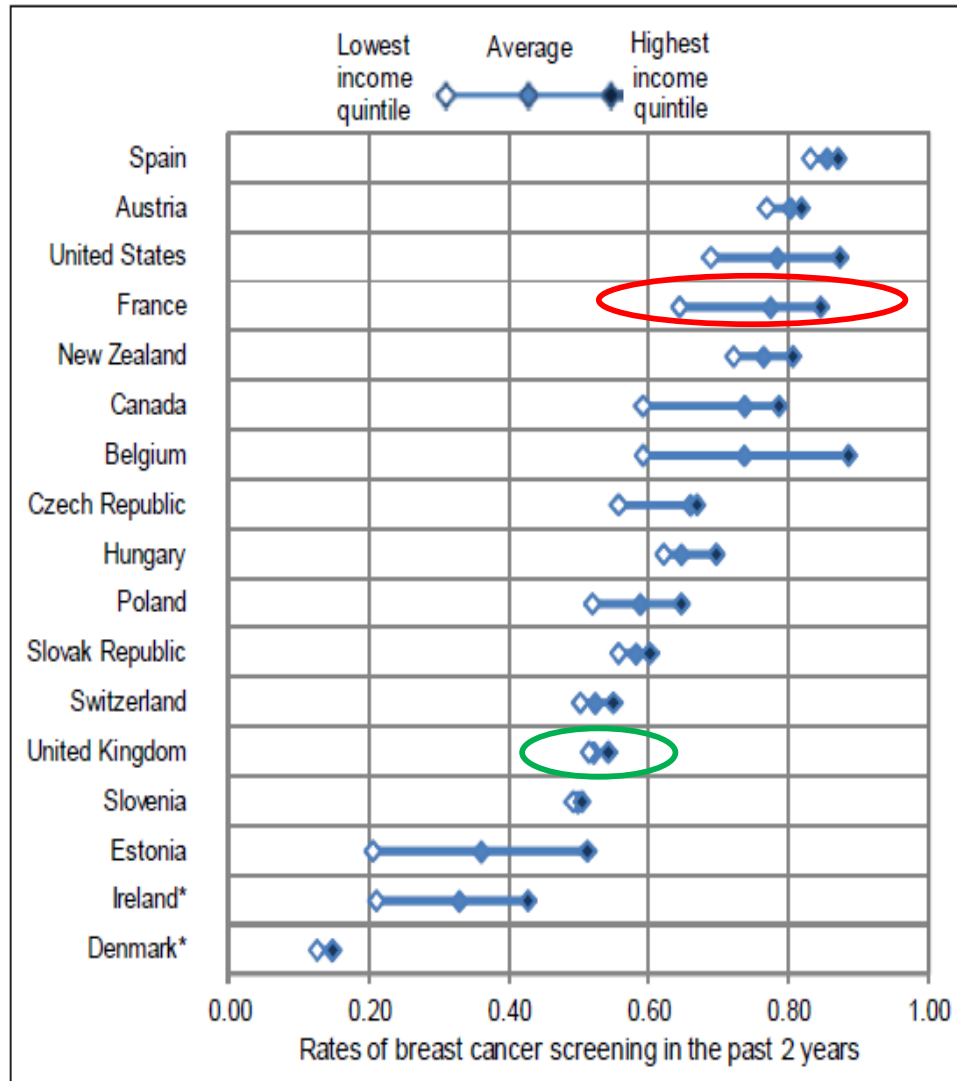
Résultats après
ajustement par
l'âge, le sexe et
l'état de santé

Mais des différences importantes dans l'accès aux spécialistes à besoin de soins donné



Résultats après ajustement par l'âge, le sexe et l'état de santé

Recours à la mammographie (gauche) ou au frottis (à droite)

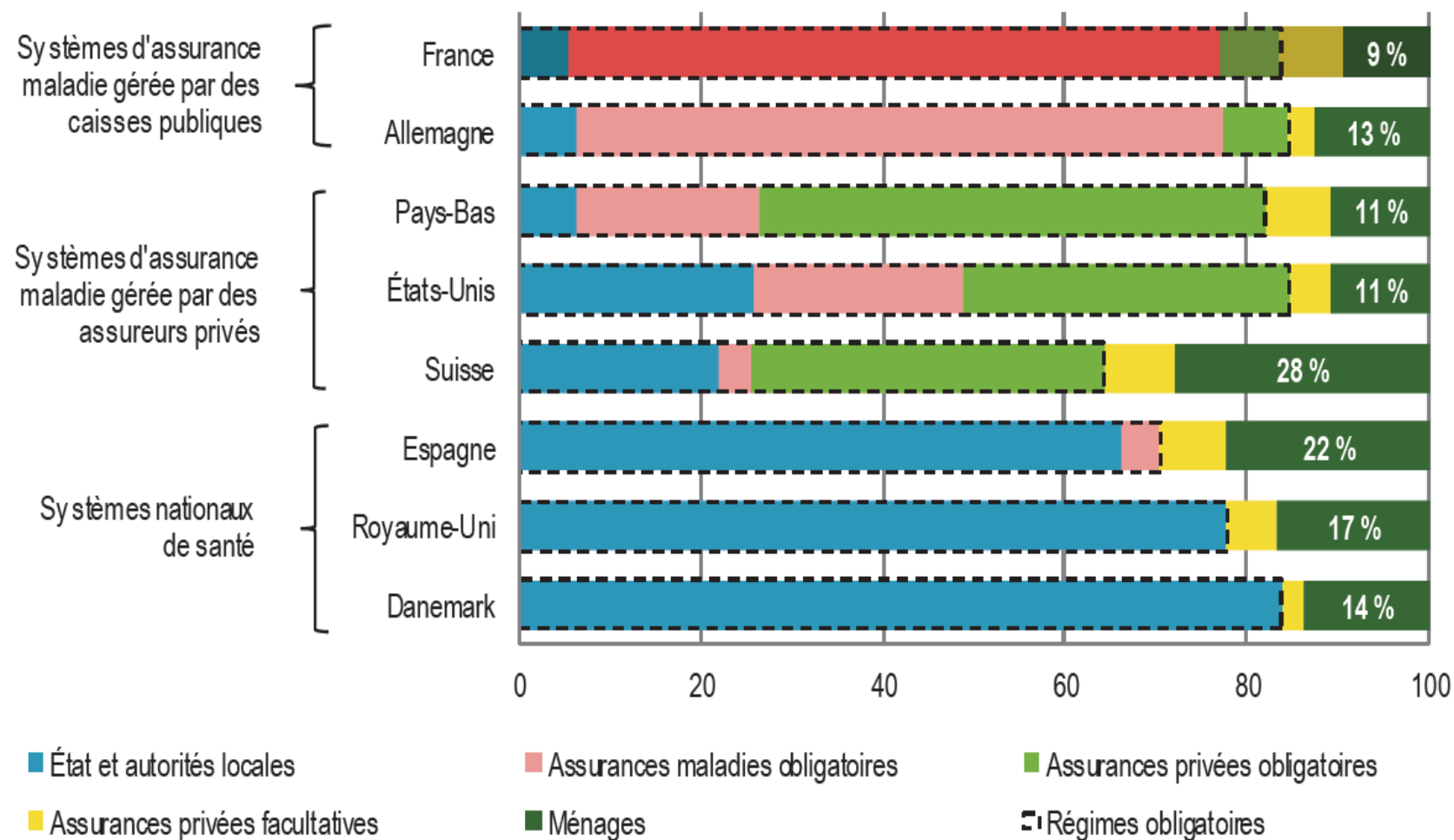


Source : Devaux, M., de Looper M. (2012). "Income-related inequalities in health service utilisation in 19 OECD countries, 2008-2009", OECD Health Working Papers, No. 58.

Le financement des soins

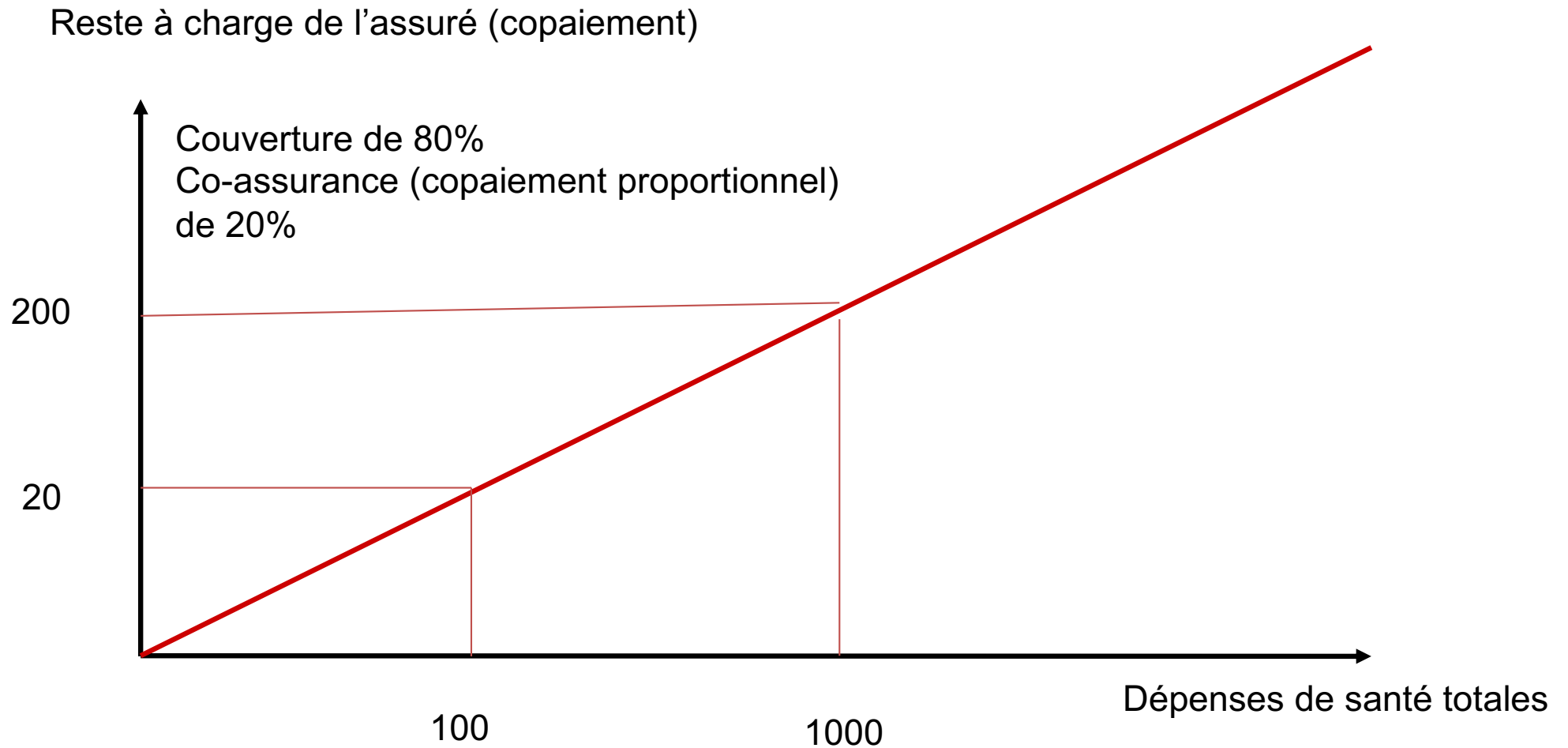
Graphique 8 Financement de la dépense courante de santé au sens international en 2018

En % de la dépense courante de santé internationale (DCSi)



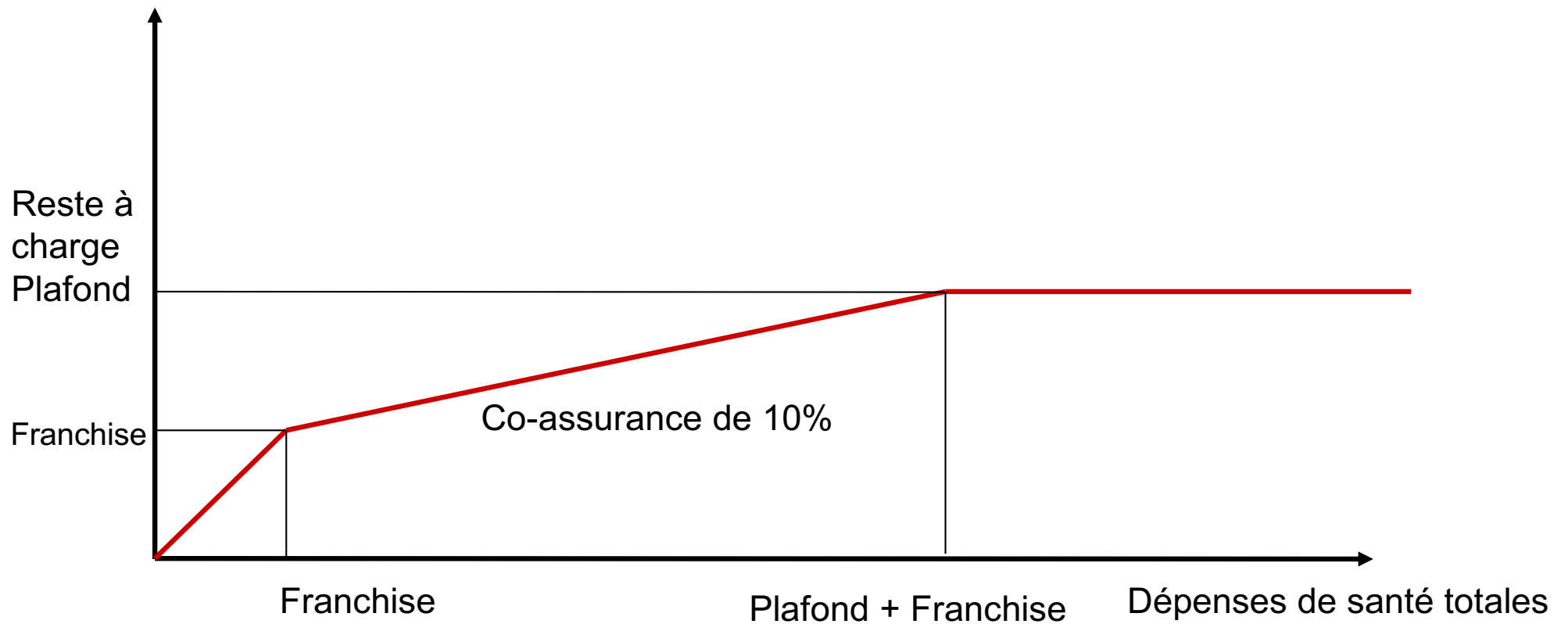
Source > OCDE, Eurostat, OMS, Système international des comptes de la santé (SHA).

Contrat avec co-assurance en France

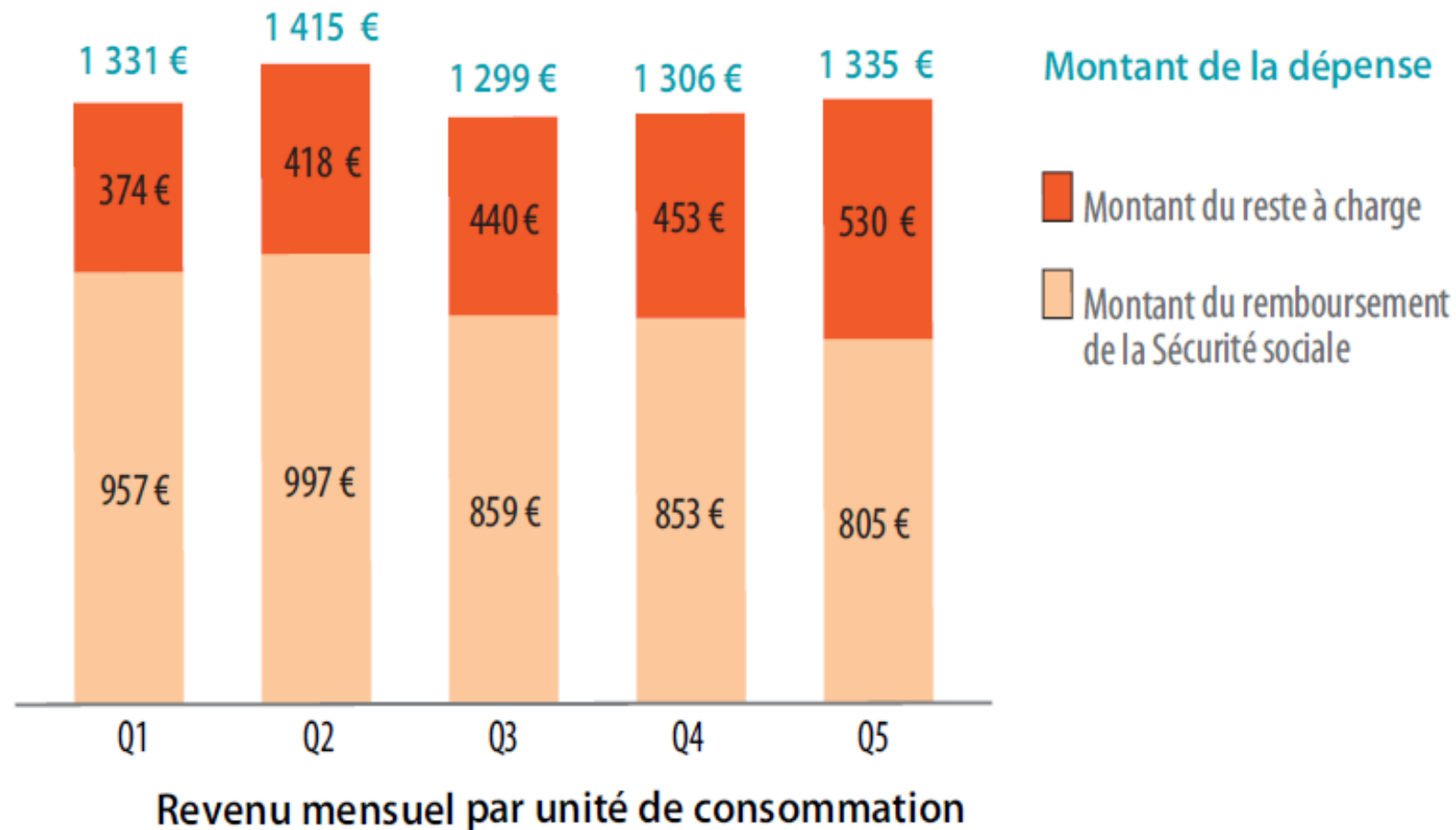


Contrat avec franchise, co-assurance et plafond

Reste à charge de l'assuré (copaiement)

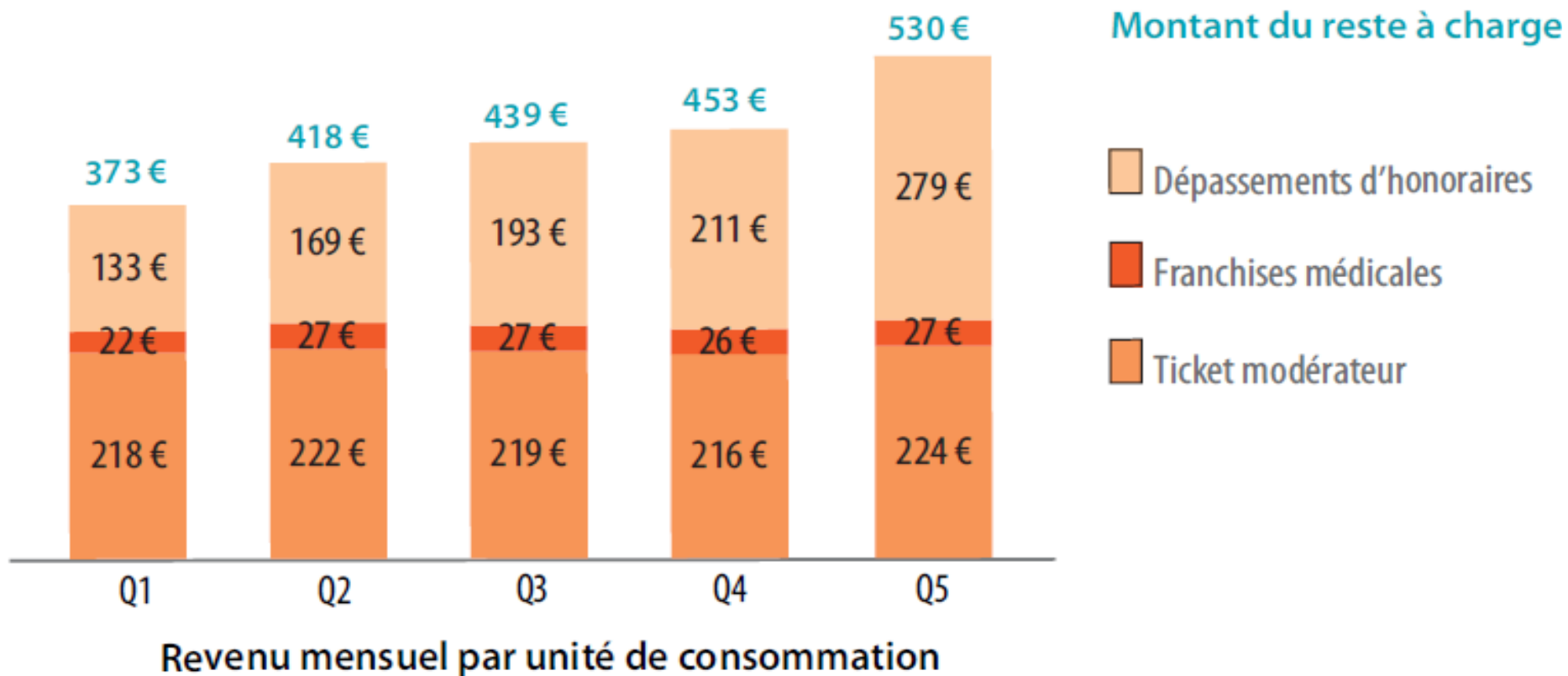


Un accès aux soins qui induit des restes à charge importants en ambulatoire



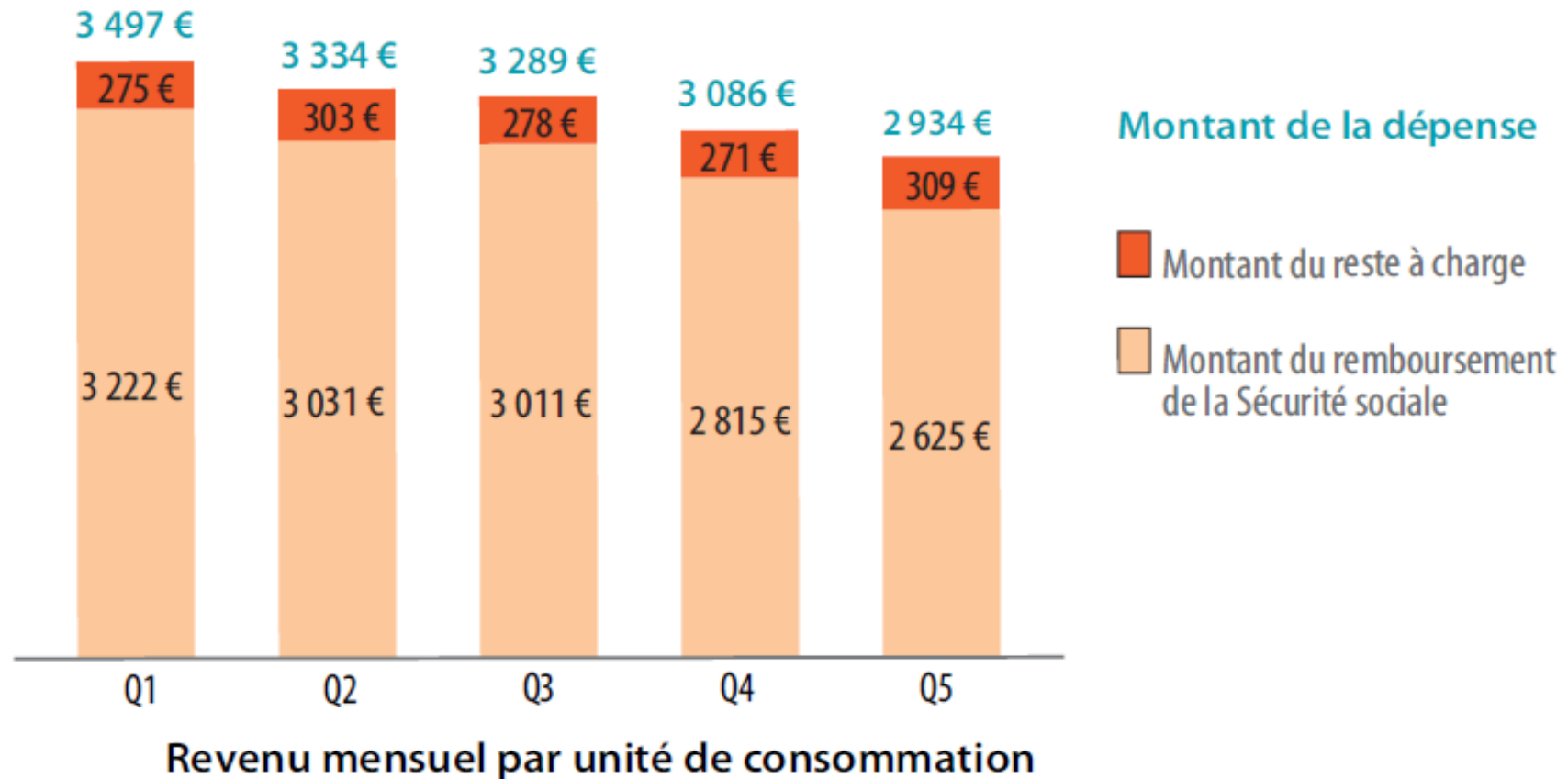
Source : Appariement DCIR-ESPS 2010

...liés à la mixité du financement du système de santé



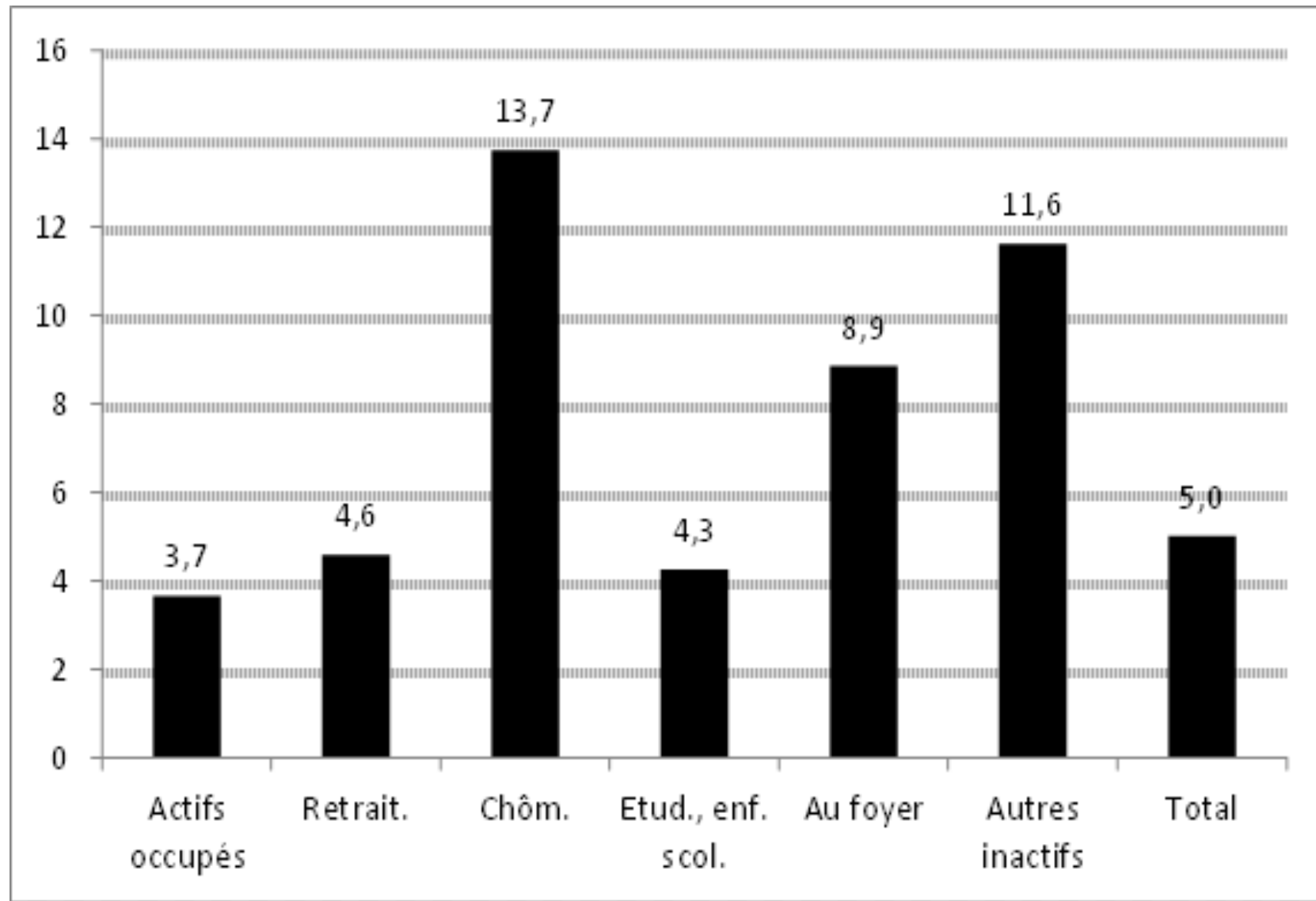
Source : Appariement DCIR-ESPS 2010

Des restes à charge importants à l'hôpital aussi...



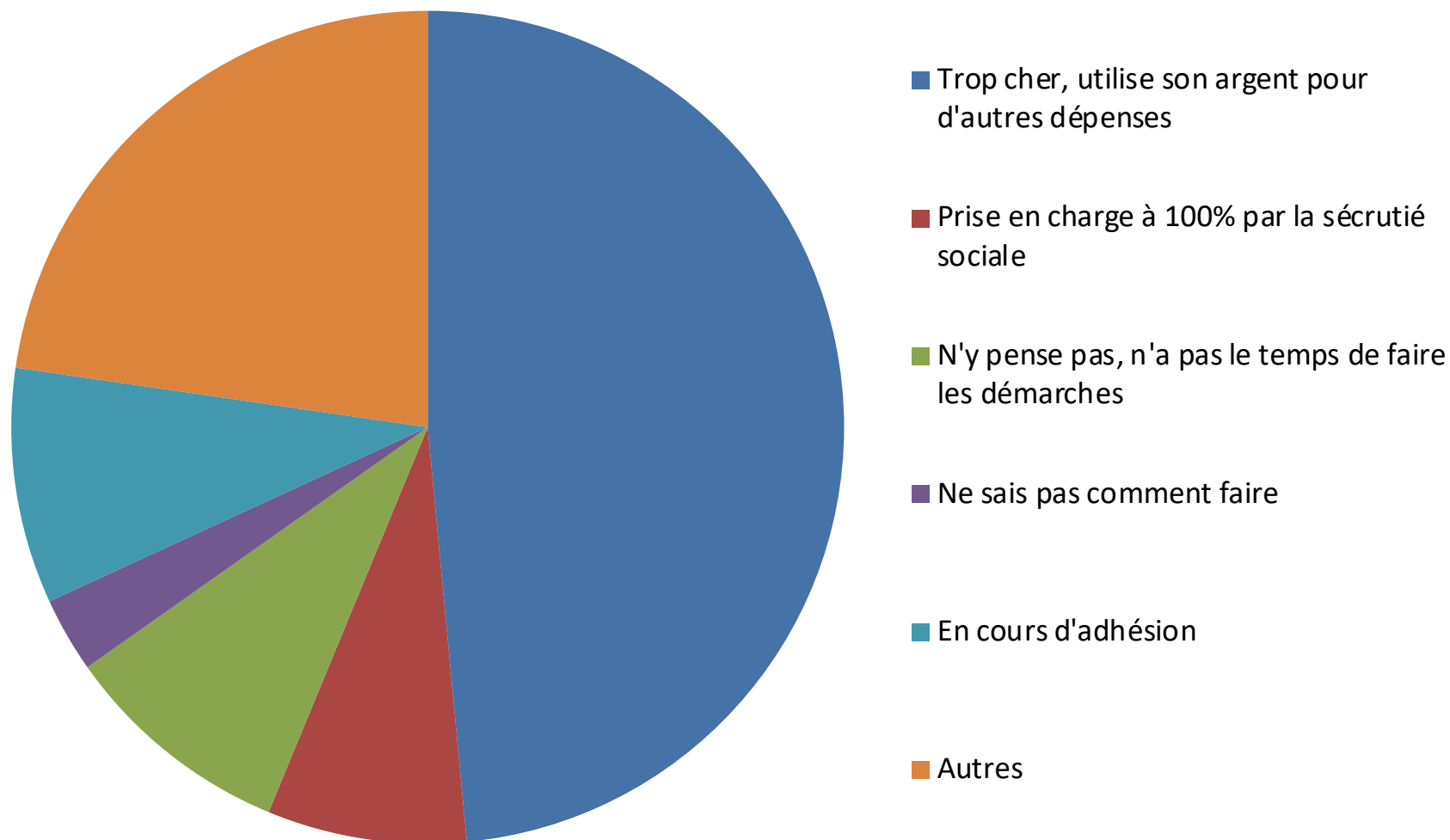
Source : Appariement DCIR-ESPS 2010

Une non couverture qui touchent toujours les plus démunis et les plus fragiles



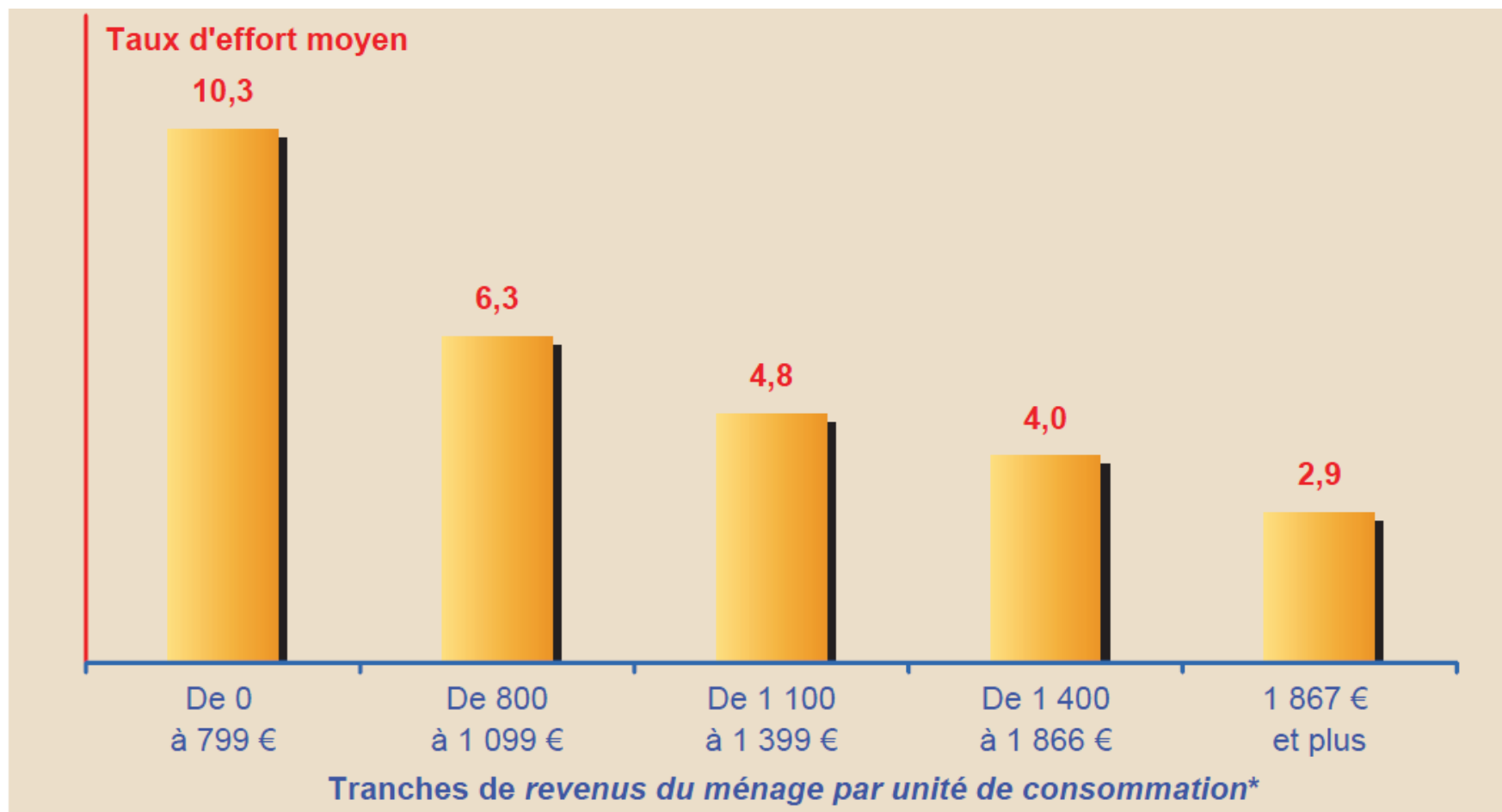
Source: Jusot F., Pierre A. (2015), « Quels impacts attendre de la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise sur la non-couverture en France ? Une simulation à partir de l'Enquête santé et protection sociale (ESPS) 2012 », Questions d'économie de la santé, n°209

Une non couverture expliquée par les difficultés financières



Source : Enquête EHIS-ESPS 2014

Part du revenu disponible consacrée à l'achat d'une couverture complémentaire selon le niveau de revenu



Source : Kambia-Chopin B., Perronnin M., Pierre A., Rochereau T. (2008), "La complémentaire santé en France en 2006 : un accès qui reste inégalitaire. Résultats de l'Enquête Santé Protection Sociale 2006 (ESPS 2006) ", Questions d'économie de la santé, 132.

Les inégalités sociales de santé : Comment les réduire ?

Comment réduire les inégalités de santé ?

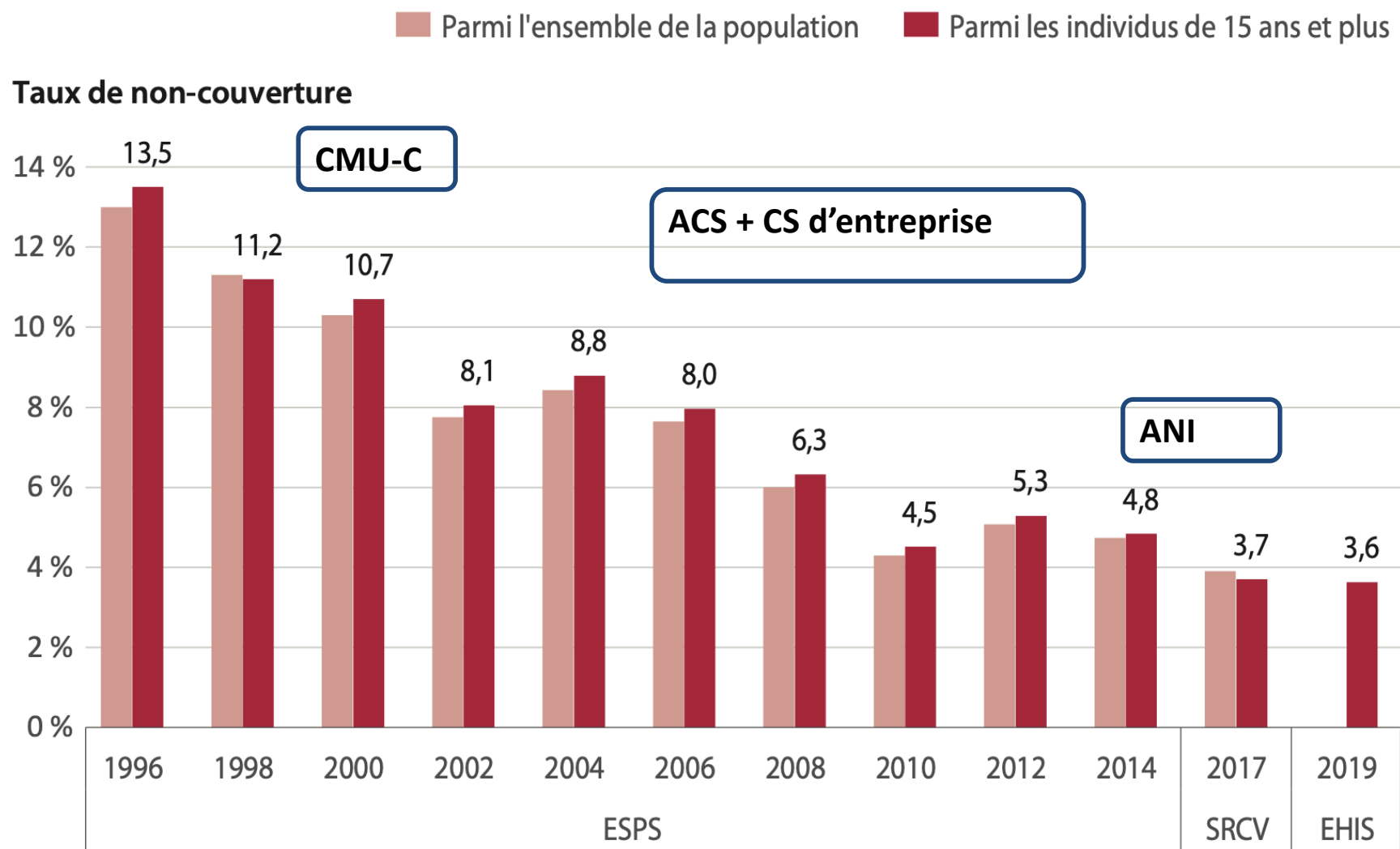
- **Des causes multiples expliquent les inégalités sociales de santé, qui sont autant de leviers d'action :**
 - Réduction des inégalités de revenus, d'accès à l'emploi
 - Politique éducative
 - Amélioration des conditions de travail
 - Prise en charge des conséquences sociales des maladies
 - En modifiant les comportements liés à la santé :
 - Réduction des comportements à risque
 - Amélioration de l'accès aux soins et à la prévention
- **Comment modifier les comportements (soins, préventifs, à risque)**
 - Restriction des choix (prohibition, obligation d'assurance, de vaccination, parcours)
 - Incitations financières (gratuité, subvention, récompenses)
 - Campagne d'information
 - Nudges : modification du contexte des choix

Des politiques d'accès aux soins nombreuses

De manière cohérente, plusieurs types d'interventions ont été mis en place pour garantir l'accès aux soins des plus démunis depuis 20 ans :

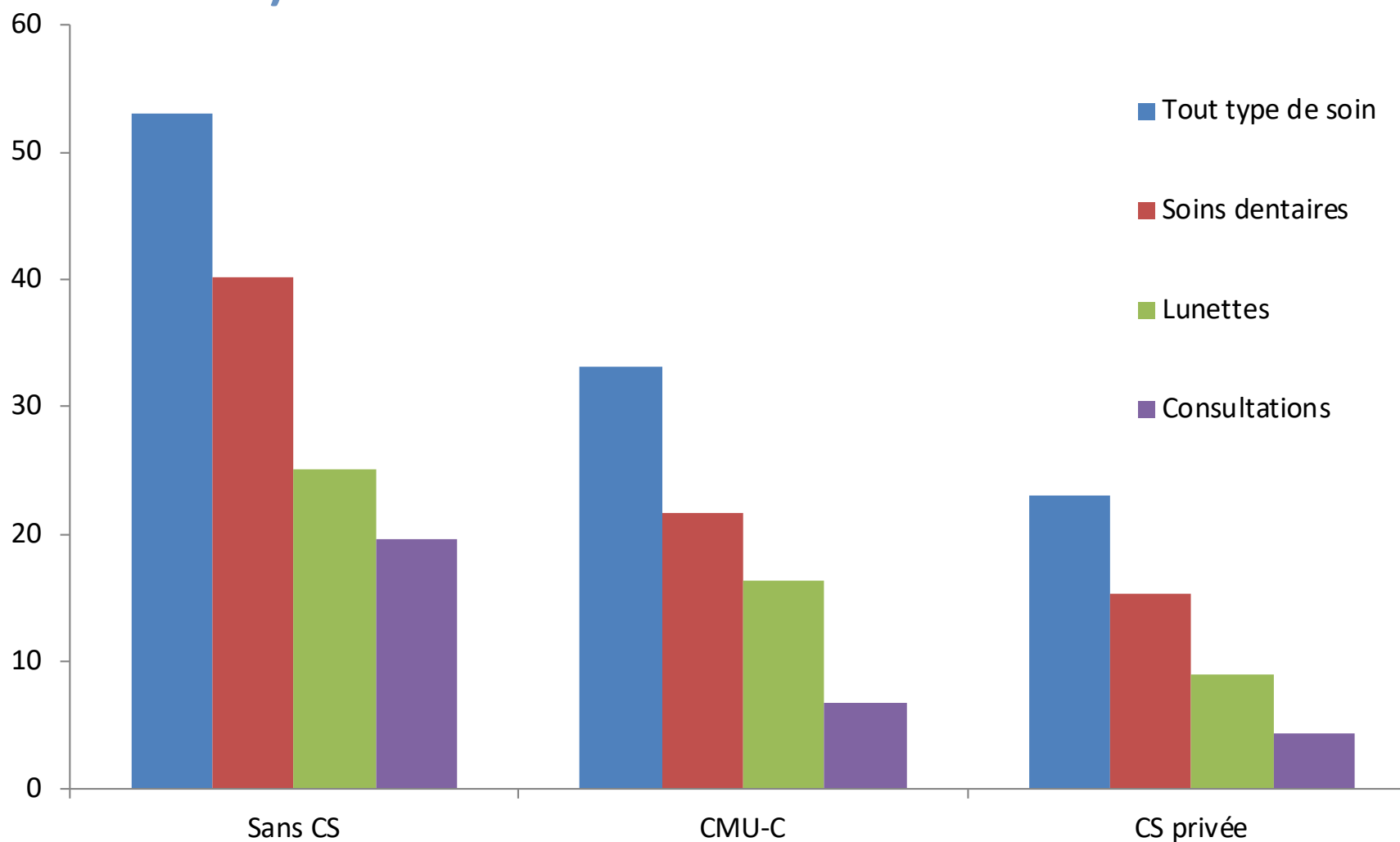
- Diffusion de la complémentaire santé :
 - Couverture Maladie Universelle Complémentaire en 2000
 - Aide médicale d'Etat en 2000
 - Aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en 2005
 - Généralisation de la complémentaire d'entreprise en 2016
- Parcours de soins en 2005
- Campagne d'information et gratuité de certains soins :
 - Mammographie pour les femmes de 50 à 74 ans
 - Vaccination contre la grippe pour les personnes de 65 ans et plus et les personnes fragiles

Évolution du taux de personnes sans complémentaire santé entre 1996 et 2019 en France métropolitaine



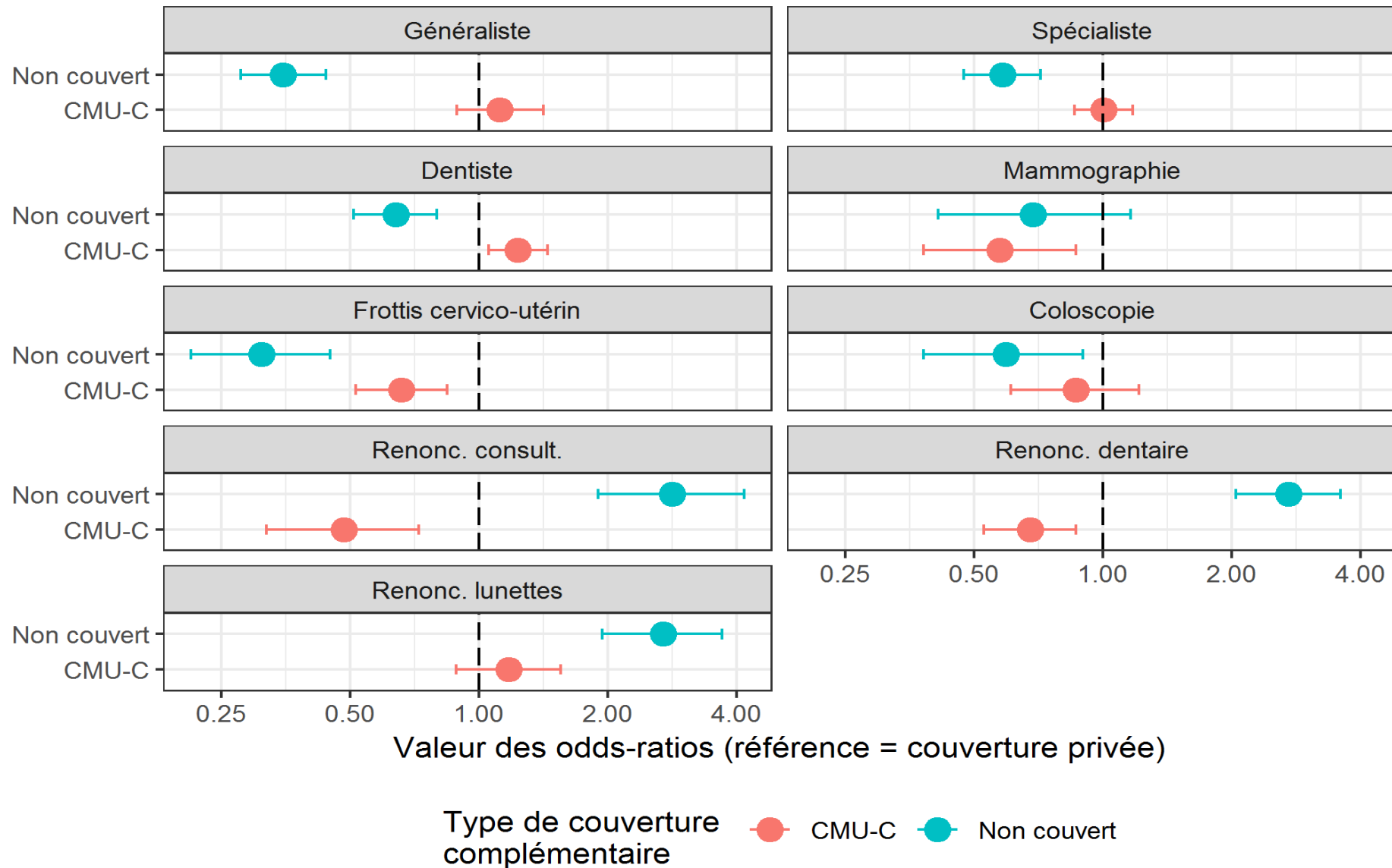
Sources : Enquêtes ESPS 1996-2014, Irdes ; SRCV 2017, Insee et EHIS 2019, Drees-Irdes.

Des renoncements aux soins pour raisons financières limités par la couverture la Couverture Maladie universelle complémentaire (complémentaire gratuite sous condition de ressources)



Source : Enquête EHIS-ESPS 2014

Odds-Ratios du recours aux soins associé à la couverture complémentaire santé, après contrôle par l'âge, le sexe, le fait d'être en ALD, l'état de santé perçu, le niveau d'étude, le revenu par unité de consommation et l'offre de soins (données EHIS-ESPS 2014, personnes âgées de 15 ans et plus (EHIS/ESPS 2014))



Mais des refus de soins aux CMUistes

Catégorie de Médecins	Taux de refus de soins imputables à la CMUC à Paris en dec 2008-jan 2009 en %
Généralistes secteur 1	9,2
Généralistes secteur 2	32,6
Ophtalmologues secteur 1	9,1
Ophtalmologues secteur 2	31,3
Gynécologues secteur 1	17,4
Gynécologues secteur 2	40,2
Radiologues secteur 1	4,1
Radiologues secteur 2	6,3
Dentistes	31,6
Ensemble	25,5

Source : Desprès C., Guillaume S., Couralet P.E. (2009), « Le refus de soins à l'égard des bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire à Paris : une étude par testing auprès d'un échantillon représentatif de médecins (omnipraticiens, gynécologues, ophtalmologues, radiologues) et de dentistes parisiens », rapport pour le Fonds CMU.

Un non recours important à l'Aide Complémentaire santé

Aide complémentaire santé :

Une subvention pour réduire le cout de la complémentaire introduite en 2005 pour les personnes dont le niveau de vie se situe entre le plafond CMU-C (8593€ par an pour une personne soit 716 € par mois) et au plus 35% au dessus de ce seuil (11600 € par an pour une personne soit 966 €)

50 à 75% de non recours en raison du manque d'information ou du coût résiduel de la complémentaire santé

Expérimentation conduite auprès de 4209 assurés affectés aléatoirement en 3 groupes :

1. Groupe témoin : lettre d'information informant sur le dispositif légal en vigueur au 1er janvier 2009
2. Groupe traité 1 : lettre d'information stipulant un montant majoré du chèque santé pour une année (65 à 75% du montant habituel)
3. Groupe traité 2 : lettre d'information stipulant un montant majoré du chèque santé + invitation à une réunion d'information à la CPAM

Expérimentation conduite à Lille pour augmenter le recours à l'Aide Complémentaire Santé

Groupes	Nombre de dossiers complétés	Nombre d'assurés	Taux de retour
Témoin	222	1394	15.9
Traité 1	262	1412	18.6
Traité 2	217	1403	15.5
Total	701	4209	16.7

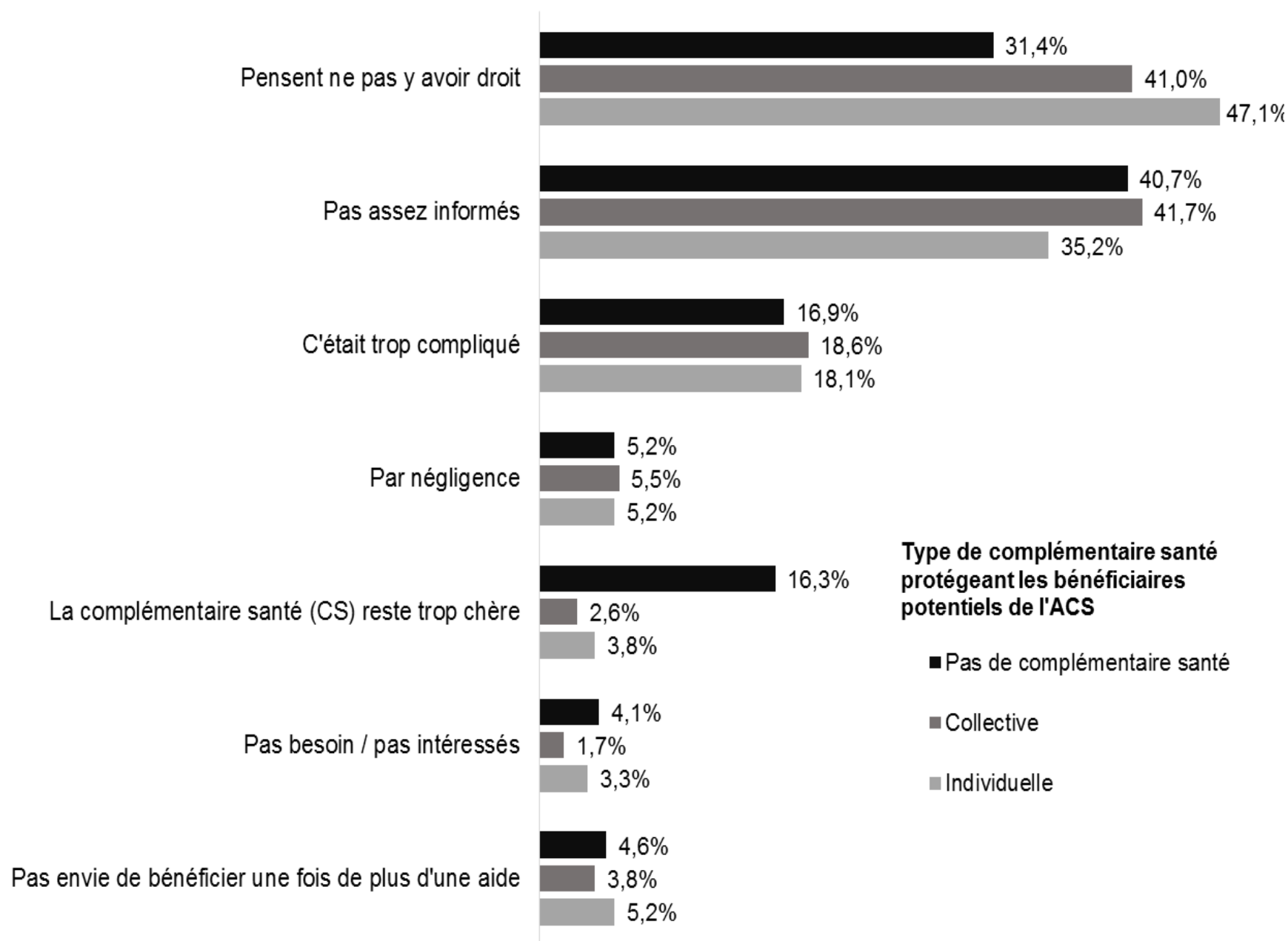
- Le taux de retour de dossiers dans le groupe traité 2 n'est pas significativement inférieur à celui du groupe témoin
- mais il est significativement inférieur à celui du groupe traité 1

Expérimentation conduite à Lille pour augmenter le recours à l'Aide Complémentaire Santé

Groupes	Nb dossiers complets	Nb assurés	Taux de retour
Avec réunion	35	125	28
Sans réunion	182	1278	14,2
Traité 2	217	1403	15,5

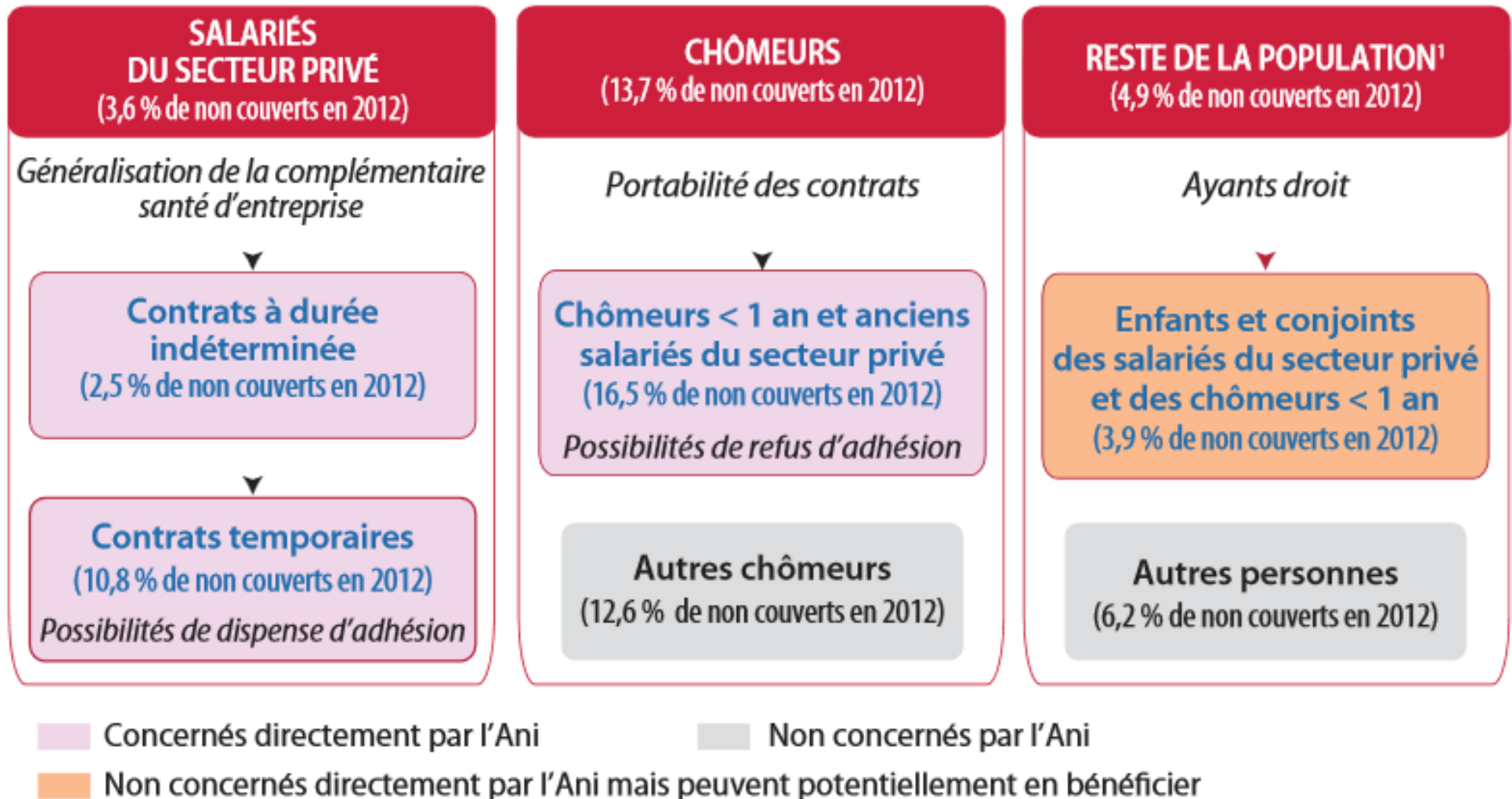
- Seules 9% des personnes invitées ont participé à la réunion (125 sur 1403)
- Les participants à la réunion ont plus souvent retourné un dossier de demande d'ACS : 28% contre 14.2 %
- Ce résultat est difficilement interprétable en raison d'un potentiel biais d'auto-sélection

Un non recours à l'ACS liés à la complexité des démarches



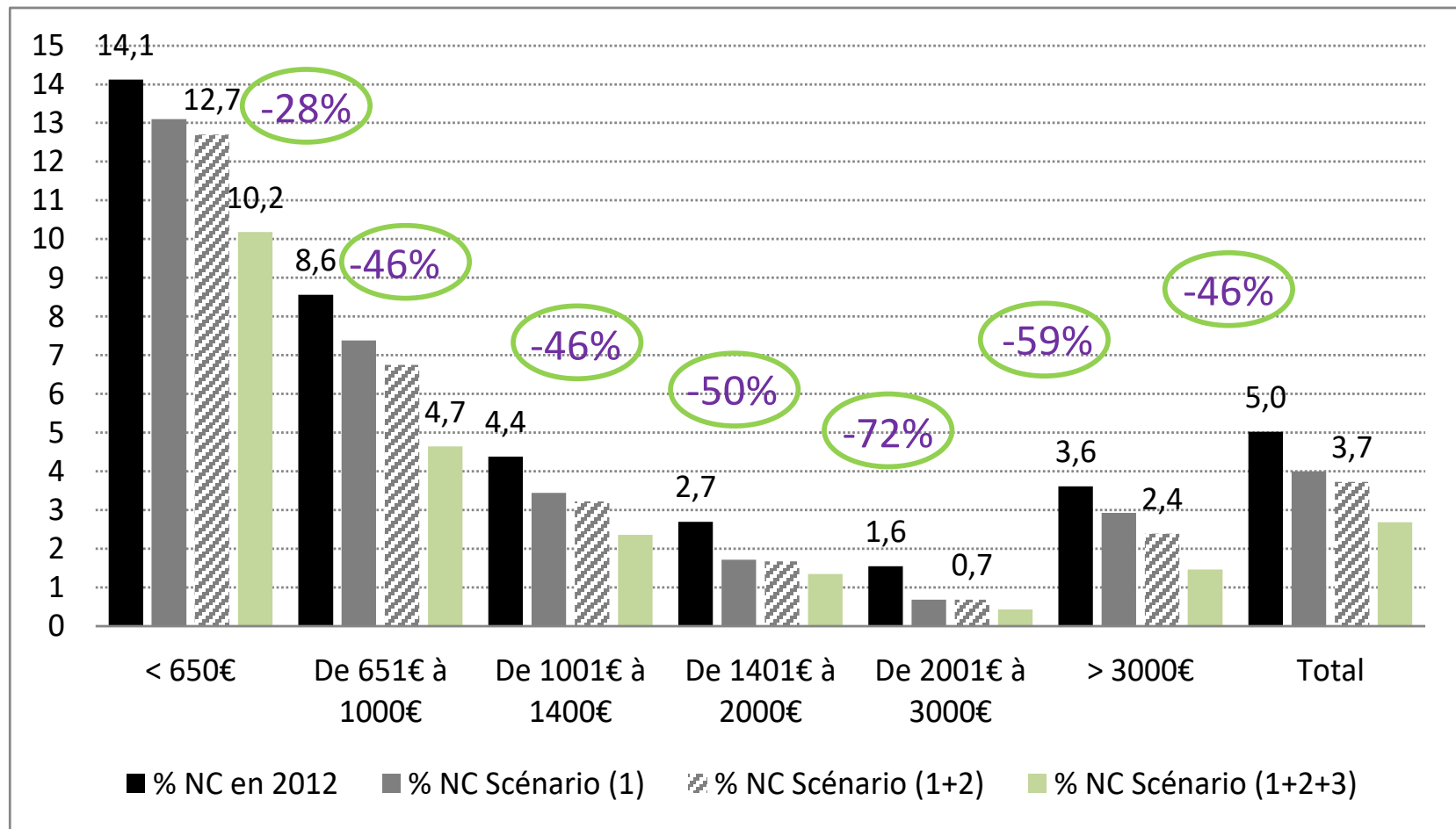
Source: Guthmuller S., Jusot F., Renaud T., Wittwer J. (2014), « Comment expliquer le non-recours à l'Aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ? Les résultats d'une enquête auprès de bénéficiaires potentiels à Lille en 2009 », Questions d'économie de la santé, 195.

L'ANI, une réforme non ciblée vers les non couverts



Source: Jusot F., Pierre A. (2015), « Quels impacts attendre de la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise sur la non-couverture en France ? Une simulation à partir de l'Enquête santé et protection sociale (ESPS) 2012 », Questions d'économie de la santé, n°209

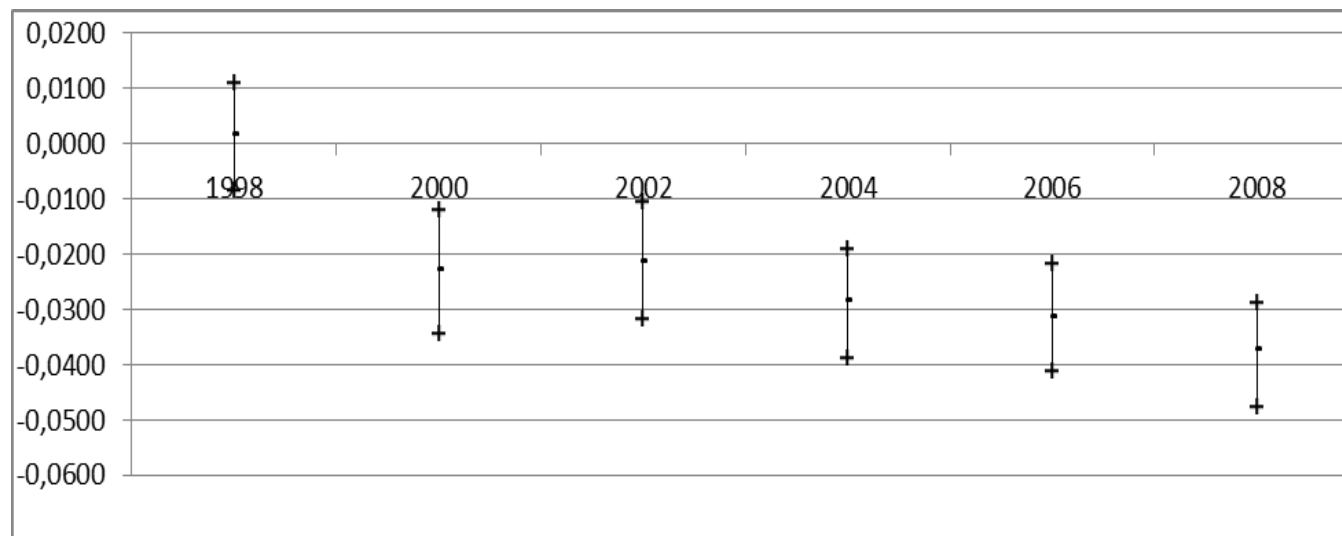
Un faible effet à attendre de l'ANI sur l'accès à la complémentaire des plus démunis



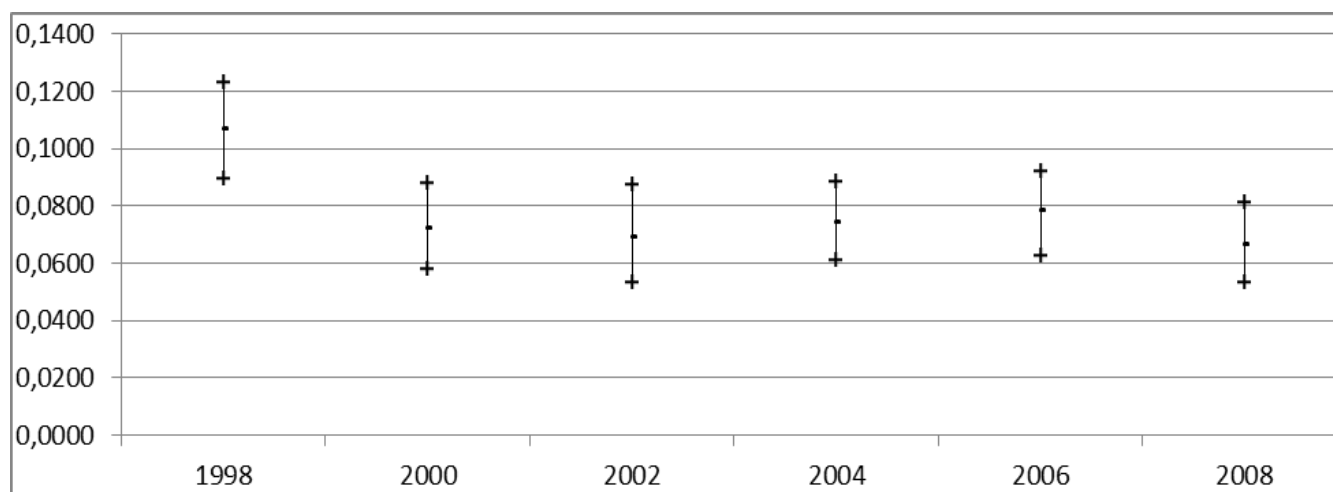
Proportion de non couverts selon le niveau de revenu par UC

Un parcours de soins sans effet sur les inégalités de recours aux soins

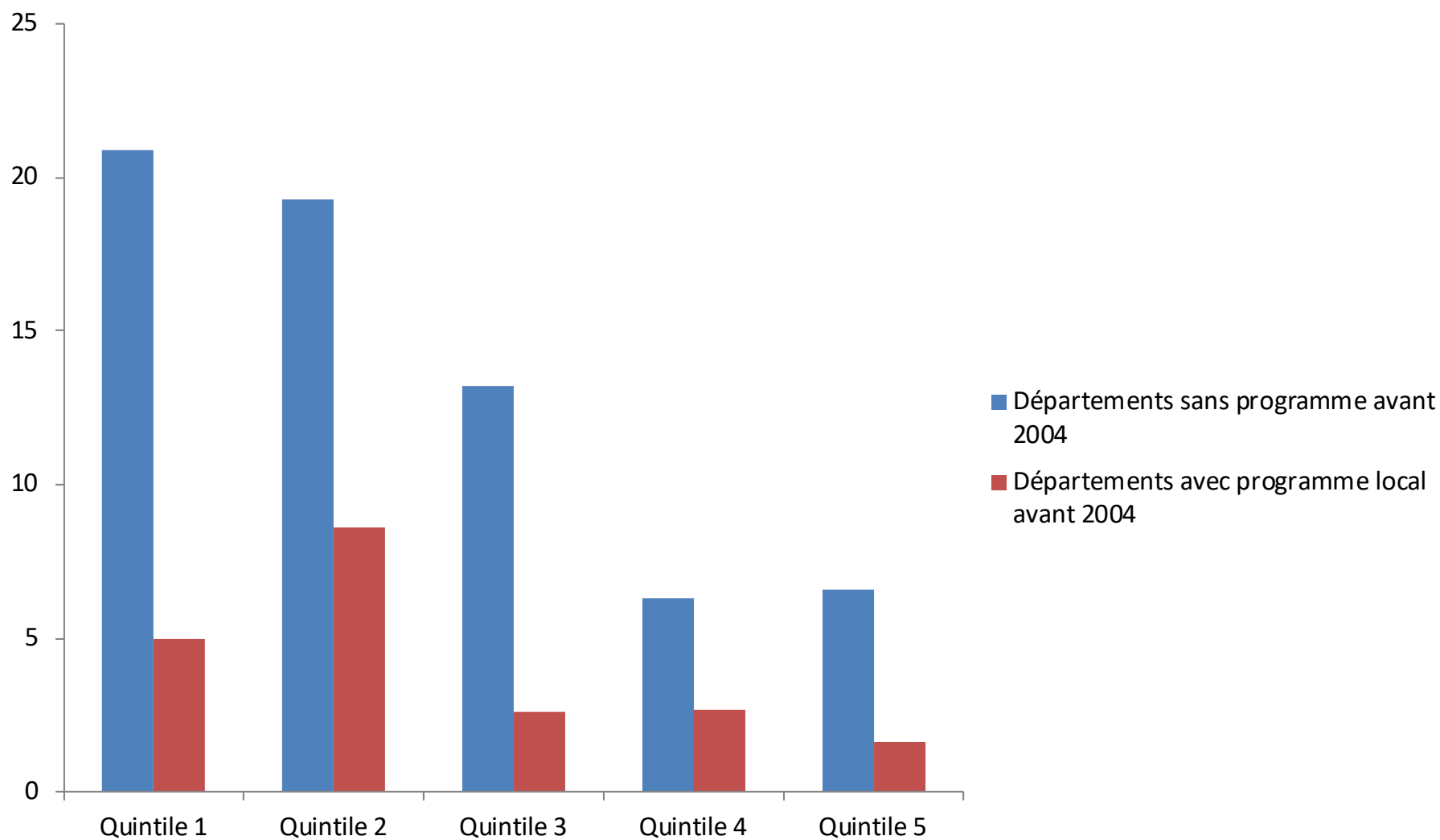
Inégalités dans la
probabilité de
consulter au moins
un généraliste



Inégalités dans la
probabilité de
consulter au moins
un spécialiste



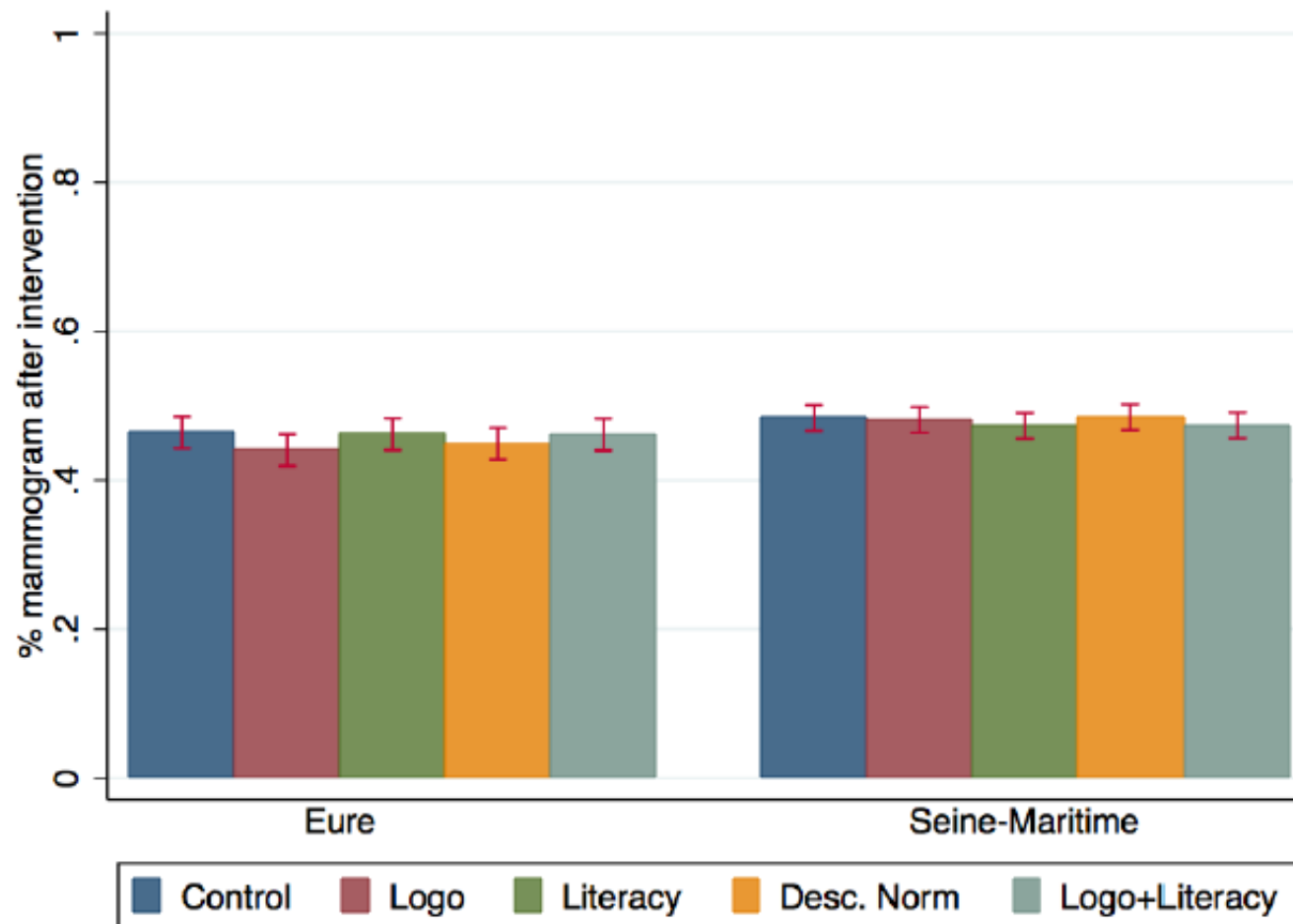
Impact de l'introduction du dépistage organisé en 2004 sur le recours à la mammographie



Source : Buchmueller, Goldzahl, 2017

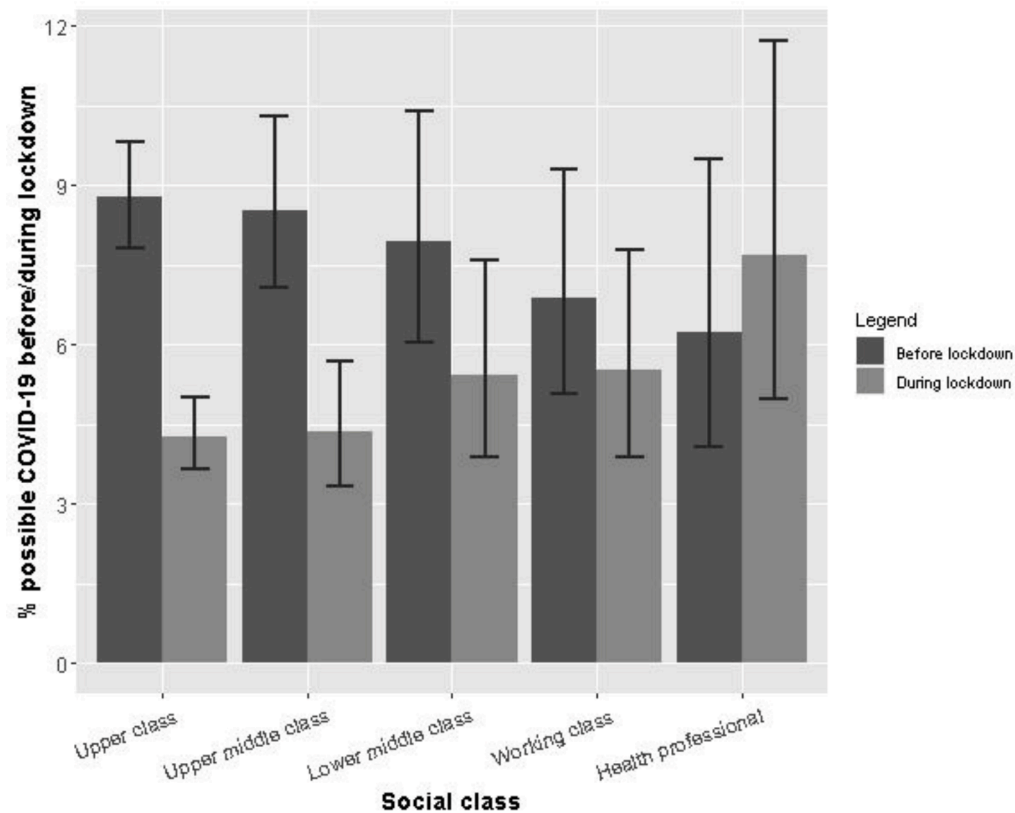
Effet des modifications des courriers d'invitation à la mammographie en Eure et Seine Maritime en 2015

Treatment effects on mammography use



Source : Goldzahl L., Hollard G., Jusot F. (2018), "Increasing breast cancer screening uptake: a randomized controlled experiment", *Journal of Health Economics*, forthcoming.

Figure 1: Percentage of individuals likely to be contaminated before or during lockdown by social class (Sapris survey)



Bajos N., Jusot F., Pailhé A., et al. (2021), "When lockdown policies amplify social inequalities in COVID-19 infections. Evidence from a cross-sectional population-based survey in France.", BMC public health, 21, 705.

Pour conclure...

Conclusion (1/3)

- Des causes multiples expliquent les inégalités sociales de santé :
 - Déterminants sociaux de la santé
 - Effet des problèmes de santé sur la situation sociale
 - Comportements à risque
 - Recours aux soins et à la prévention
 - Recours et accès au droit
- Qui sont autant de leviers d'action :
 - politiques redistributives en amont du système de soins (éducation, revenu ou emploi)
 - politiques intermédiaires visant les comportements de risque

L'enjeu est alors de concevoir des interventions ou politiques efficaces pour réduire les comportements à risque en moyenne, et qui réduisent ou pour le moins n'augmentent pas les inégalités
 - politiques en aval ciblant le système de soins (prévention et accès financiers aux soins)

Conclusion (2/3)

- En dépit des nombreuses interventions mises en place pour améliorer l'accès aux soins des plus démunis, il existe encore de fortes inégalités de recours aux soins
- Le recours aux soins entraîne en outre des dépenses importantes liées au reste à charge ou aux primes de complémentaires santé
- Ces inégalités sont liées aux caractéristiques du système de soins
 - Inefficacité de certaines politiques d'accès aux soins
 - Reste à charge
 - Paiement à l'acte
 - Manque d'orientation dans le système de soins
- Plusieurs pistes d'interventions restent possibles
 - Améliorer l'accès financier (gratuité, automaticité des droits)
 - Campagne d'information ciblée
 - Encadrement strict des parcours
 - Incitations ciblées des professionnels de santé

Conclusion (3/3)

- La mise en œuvre de politiques publiques et d'intervention se heurtent enfin à l'acceptabilité politique des interventions
- Ce qui renvoie à la légitimité des inégalités de santé ou au contraire de leur perception comme une injustice
- Les inégalités de recours aux soins étant jugées plus inacceptables que les inégalités de revenu, les interventions au sein du système de soins peuvent être plus acceptables, indépendamment de leur efficacité relative.

Merci de votre attention